

Bunga Rampai **PERAN TENAGA KESEHATAN**

DALAM PENGUATAN PELAYANAN KESEHATAN PRIMER



Farhan Ardiansyah • Erma Puspita Sari • Rizki Amalia
Putu Lusita Nati Indriani • Susi Milwati • Arief Hendrawan
Enik Suhariyanti • Wirda Hayati

Editor : Juni Andriani Rangkuti

BUNGA RAMPAI: PERAN TENAGA KESEHATAN DALAM PENGUATAN PELAYANAN KESEHATAN PRIMER

Penulis:

Farhan Ardiansyah S.Kep., Ns., M.Kep.
Erma Puspita Sari, SST.,Bdn.,M.Kes
Bdn. Rizki Amalia, SST., M.Kes.
Bdn. Putu Lusita Nati Indriani, SST., M.Kes.
Dr. Susi Milwati, S.Kp., M.Pd
Arief Hendrawan, S.St., M.Fis
Enik Suhariyanti,S.Kep., Ners., M.Kep.
Dr. Ns. Wirda Hayati, M.Kep., Sp.Kom

Editor:

Bdn. Juni Andriani Rangkuti, S.Keb, M.K.M

Bunga Rampai: Peran Tenaga Kesehatan Dalam Penguatan Pelayanan Kesehatan Primer

Penulis:

Farhan Ardiansyah S.Kep., Ns., M.Kep.
Erma Puspita Sari, SST.,Bdn.,M.Kes
Bdn. Rizki Amalia, SST., M.Kes.
Bdn. Putu Lusita Nati Indriani, SST., M.Kes.
Dr. Susi Milwati, S.Kp., M.Pd
Arief Hendrawan, S.St., M.Fis
Enik Suhariyanti,S.Kep., Ners., M.Kep.
Dr. Ns. Wirda Hayati, M.Kep., Sp.Kom

Editor:

Bdn. Juni Andriani Rangkuti, S.Keb, M.K.M

Desain Sampul: Ivan Zumarano

Penata Letak: Helmi Syaukani, S.Pd.

ISBN: 978-634-7556-75-2

Cetakan Pertama: Maret, 2026

Hak Cipta 2026

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Copyright © 2026

by Penerbit PT Optimal Untuk Negeri

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Website : optimaluntuknegeri.com

Instagram : @bimbel.optimal

Tiktok : @maskokooo

PENERBIT:

PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat, DKI Jakarta

Anggota IKAPI No. 635/DKI/2025



PRAKATA



Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya bunga rampai berjudul “Peran Tenaga Kesehatan dalam Penguatan Pelayanan Kesehatan Primer” ini dapat disusun dan dihadirkan sebagai salah satu kontribusi pemikiran untuk mendukung penguatan sistem kesehatan di Indonesia. Pelayanan kesehatan primer merupakan garda terdepan yang menjadi fondasi utama dalam mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal—terutama melalui upaya yang menyentuh kebutuhan dasar, dekat dengan komunitas, dan berorientasi pada pencegahan.

Bunga rampai ini disusun dengan keyakinan bahwa keberhasilan pelayanan kesehatan primer tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan fasilitas dan kebijakan, tetapi juga oleh kualitas peran, kolaborasi, dan dedikasi tenaga kesehatan di lapangan. Di tengah dinamika tantangan kesehatan, beban penyakit ganda, serta tuntutan pelayanan yang semakin kompleks, tenaga kesehatan dituntut untuk adaptif, profesional, serta mampu menjadi penggerak perubahan di tingkat komunitas.

Melalui rangkaian topik yang disajikan, buku ini mengulas pelayanan kesehatan primer sebagai fondasi sistem kesehatan, serta memperkuat pemahaman mengenai peran tenaga kesehatan dalam penguatan Puskesmas dan layanan primer. Pembahasan juga menekankan pentingnya upaya promotif dan preventif sebagai inti pelayanan primer, yang menempatkan masyarakat bukan sekadar penerima layanan, melainkan mitra aktif dalam menjaga kesehatan.

Secara lebih spesifik, bunga rampai ini memuat peran strategis berbagai profesi kesehatan. Kebidanan dibahas dalam kontribusinya terhadap kesehatan ibu dan anak, pelayanan reproduksi, serta pendampingan keluarga di tingkat primer. Keperawatan diulas sebagai pilar pelayanan yang berfokus pada kontinuitas asuhan, edukasi, manajemen kasus, serta dukungan bagi pasien dan keluarga. Tidak kalah penting, buku ini juga menyoroti pemberdayaan masyarakat sebagai kunci penguatan layanan primer—melalui partisipasi komunitas, kader kesehatan, dan pendekatan berbasis keluarga.

Selain itu, bunga rampai ini mengangkat realitas tantangan pelayanan kesehatan primer di daerah perkotaan dan pedesaan, mulai dari kesenjangan akses, ketersediaan tenaga, hambatan geografis, hingga perbedaan karakteristik sosial budaya. Pada bagian akhir, disajikan pula strategi peningkatan mutu dan akses, yang diharapkan dapat menjadi rujukan praktis sekaligus inspirasi untuk pengembangan layanan primer yang lebih responsif, merata, dan berkualitas.

Kami menyadari bahwa penyusunan bunga rampai ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan demi penyempurnaan di masa mendatang. Besar harapan kami, buku ini dapat menjadi bahan bacaan yang bermanfaat bagi tenaga kesehatan, akademisi, mahasiswa, pengelola fasilitas pelayanan kesehatan, serta para pemangku kebijakan dalam memperkuat pelayanan kesehatan primer yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Februari 2026

Penulis



DAFTAR ISI



PRAKATA.....	iii
DAFTAR ISI.....	v

CHAPTER 1 PELAYANAN KESEHATAN PRIMER SEBAGAI FONDASI SISTEM

KESEHATAN	1
Farhan Ardiansyah, S.Kep., Ns., M.Kep.....	1
A. Pendahuluan.....	1
B. Pelayanan Kesehatan Primer dalam Perspektif Keperawatan Komunitas	4
C. Peran Tenaga Kesehatan dalam Penguatan Pelayanan Kesehatan Primer sebagai Fondasi Sistem Kesehatan	8
D. Simpulan	12
E. Referensi	13

CHAPTER 2 PERAN TENAGA KESEHATAN DALAM PENGUATAN PUSKESMAS DAN LAYANAN PRIMER.....

Erma Puspita Sari, SST., Bdn., M.Kes.	19
A. Pendahuluan.....	19
B. Konsep Layanan Kesehatan Primer dan Kerangka Operasional Peran Bidan	20
C. Peran Operasional Bidan terhadap Klien dalam Praktik Layanan Primer	21
D. Peran Bidan dalam Penguatan Puskesmas dan Layanan Primer pada Level Sistem dan Program.....	22
E. Implementasi Peran Bidan dalam Integrasi Layanan Primer (ILP).....	22
F. Tantangan dan Peluang Bidan dalam Penguatan Layanan Primer.....	23
G. Praktik Baik (Best Practices) Penguatan Layanan Primer Berbasis Kebidanan.....	24
H. Arah Penguatan Peran Bidan dalam Layanan Primer Berkelanjutan.....	24
I. Simpulan	26
J. Referensi	27
K. Glosarium.....	28

CHAPTER 3 UPAYA PROMOTIF DAN PREVENTIF DI TINGKAT PELAYANAN KESEHATAN PRIMER

Bdn. Rizka Amalia, SST., M.Kes.....	30
A. Pendahuluan.....	30
B. Landasan Teoretis Pelayanan Kesehatan Primer dalam Perspektif Kebidanan	32
C. Konsep Promotif dan Preventif dalam Praktik Kebidanan Primer	34
D. Strategi Promotif di Pelayanan Primer dalam Perspektif Kebidanan.....	36

E. Strategi Preventif (Primer–Sekunder–Tersier) dalam Pelayanan Kebidanan Primer	38
F. Implementasi di Indonesia dalam Perspektif Kebidanan Primer	40
G. Model Berbasis Komunitas dalam Kebidanan Primer	42
H. Inovasi Digital & mHealth dalam Kebidanan Primer	43
I. Tantangan dan Hambatan dalam Implementasi Promotif-Preventif Kebidanan Primer	45
J. Rekomendasi Kebijakan dalam Penguatan Promotif-Preventif Kebidanan Primer	47
K. Simpulan	49
L. Referensi	49
M. Glosarium	51

CHAPTER 4 PERAN KEBIDANAN DALAM PELAYANAN KESEHATAN PRIMER

.....	53
Bdn. Putu Lusita Nati Indriani, SST., M.Kes.	53
A. Pendahuluan	53
B. Landasan Teoretis Peran Kebidanan dalam Pelayanan Kesehatan Primer	55
C. Ruang Lingkup Peran Kebidanan dalam Pelayanan Kesehatan Primer	56
D. Peran Promotif Kebidanan dalam Pelayanan Kesehatan Primer	59
E. Preventif Kebidanan dalam Pelayanan Kesehatan Primer	61
F. Peran Kebidanan dalam Transformasi Digital Pelayanan Kesehatan Primer	63
G. Tantangan dalam Penguatan Peran Kebidanan di Pelayanan Kesehatan Primer	64
H. Rekomendasi Penguatan Peran Kebidanan dalam Pelayanan Kesehatan Primer	66
I. Simpulan	68
J. Referensi	69
K. Glosarium	70

CHAPTER 5 KONTRIBUSI KEPERAWATAN DALAM PELAYANAN KESEHATAN PRIMER

.....	72
Dr. Susi Milwati, S.Kp., M.Pd.	72
A. Pendahuluan	72
B. Konsep Dasar Hipertensi Ringan	74
C. Gambaran Hipertensi Ringan Di Puskesmas	76
D. Manajemen Asuhan Keperawatan Hipertensi Ringan (Berbasis Sdki–Slki–Siki)	79
E. Edukasi Pola Hidup Sehat Pada Pasien Hipertensi Ringan	82
F. Peran Perawat dalam Pendekatan Promotif dan Preventif	85
G. Studi Kasus Hipertensi Ringan Di Puskesmas	86
H. Tantangan Dan Strategi Pengendalian Hipertensi Ringan Di Puskesmas (Dalam Perspektif Asuhan Keperawatan Dan Edukasi Berkelanjutan)	88
I. Penutup	90
J. Daftar Pustaka	92

K. Glosarium.....	93
-------------------	----

CHAPTER 6 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM MENDUKUNG PELAYANAN KESEHATAN PRIMER 97

Arief Hendrawan, S.St., M.Fis.....	97
A. Pendahuluan.....	97
B. Konsep Dasar Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelayanan Kesehatan Primer.	98
C. Implementasi Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelayanan Kesehatan Primer	100
D. Strategi Implementasi Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelayanan Kesehatan Primer.....	101
E. Tantangan dan Solusi dalam Pemberdayaan Masyarakat pada Pelayanan Kesehatan Primer	103
F. Implikasi Kebijakan Nasional dan Lokal.....	104
G. Simpulan	106
H. Referensi	106
I. Glosarium.....	109

CHAPTER 7 TANTANGAN PELAYANAN KESEHATAN PRIMER DI DAERAH PERKOTAAN DAN PEDESAAN 112

Enik Suhariyanti, S.Kep., Ners., M.Kep	112
A. Pendahuluan.....	112
B. Tantangan Pelayanan Kesehatan Primer di Perkotaan	115
C. Tantangan Pelayanan Kesehatan Primer di Pedesaan.....	116
D. Perbandingan Tantangan Perkotaan dan Pedesaan.....	119
E. Implikasi bagi Peran Tenaga Kesehatan.....	121
F. Simpulan	124
G. Referensi	125
H. Glosarium.....	126

CHAPTER 8 STRATEGI PENINGKATAN MUTU DAN AKSES PELAYANAN KESEHATAN PRIMER 129

Dr. Ns. Wirda Hayati, M.Kep., Sp.Kom.....	129
A. Pendahuluan.....	129
B. Pelayanan Kesehatan Primer dalam Transformasi Layanan Kesehatan	131
C. Konsep Mutu dan Akses dalam Pelayanan Kesehatan Primer	134
D. Keimpulan.....	140
E. Referensi	141
F. Glosarium.....	142

PROFIL PENULIS 145

CHAPTER 1

PELAYANAN KESEHATAN PRIMER SEBAGAI FONDASI SISTEM KESEHATAN

Farhan Ardiansyah, S.Kep., Ns., M.Kep

A. Pendahuluan

Dunia kesehatan sedang berada di persimpangan jalan. Saat ini, kecanggihan teknologi rumah sakit rujukan bukan lagi tolok ukur ketahanan sistem global; fondasi dasar di tingkat primerlah yang menentukan hidup-mati kesejahteraan manusia. Pelayanan Kesehatan Primer (PKP) atau *Primary Health Care* (PHC) telah lama diakui sebagai strategi paling efektif, efisien, dan berkeadilan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara menyeluruh (Walraven, 2019). Di lapangan, penerapan kebijakan ini sering terhambat kendala teknis, keterbatasan anggaran, hingga kurangnya tenaga medis yang kompeten (Abdullatif Alnaser, 2021).

Di Indonesia, menjadikan pelayanan kesehatan primer sebagai jantung transformasi kesehatan nasional bukan lagi sekadar pilihan kebijakan, melainkan keharusan mutlak. (Labkesmas Baturaja Kemenkes RI, 2025). Dengan cakupan geografis yang sangat luas dan karakteristik demografis yang beragam, Indonesia memiliki tantangan besar dalam membangun sistem kesehatan yang merata hingga ke wilayah terpencil dan kepulauan. Pelayanan kesehatan primer diposisikan bukan hanya sebagai unit layanan teknis, melainkan sebagai ekosistem yang mengintegrasikan upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif dalam satu rangkaian yang berkesinambungan (Ardiansyah et al., 2024). Tenaga kesehatan di sini memegang peran ganda: sebagai pengambil keputusan klinis sekaligus pelaksana teknis di lapangan (KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR HK.01.07/MENKES/2015/2023, 2023).

Menghadapi berbagai tantangan tersebut, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia telah meluncurkan enam pilar transformasi kesehatan sebagai upaya menyeluruh untuk merombak sistem yang ada. Pilar pertama dan paling fundamental dalam transformasi ini adalah Transformasi Layanan Primer. Transformasi ini menggeser fokus utama dari layanan kuratif bagi individu yang sakit menuju penguatan upaya promotif dan preventif bagi seluruh masyarakat (Catra Octo Chrisandi, 2024).

Transformasi sistem kesehatan Indonesia disusun untuk menciptakan ketangguhan nasional dalam menghadapi krisis kesehatan di masa depan. Enam pilar tersebut mencakup:

1. Transformasi Layanan Primer: Fokus pada edukasi penduduk, pencegahan primer (imunisasi), pencegahan sekunder (skrining), dan peningkatan kapasitas layanan primer .
2. Transformasi Layanan Rujukan: Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas rumah sakit di seluruh Indonesia, termasuk pembangunan RS di wilayah timur.
3. Transformasi Sistem Ketahanan Kesehatan: Mendorong kemandirian farmasi dan kesehatan dalam negeri serta penguatan sistem penanganan dan tanggap darurat.
4. Transformasi Sistem Pembiayaan Kesehatan: Menjamin ketersediaan, kecukupan, dan keberlanjutan pembiayaan kesehatan yang berkeadilan.
5. Transformasi SDM Kesehatan: Memastikan pemerataan distribusi dan peningkatan kualitas tenaga kesehatan di seluruh pelosok tanah air.
6. Transformasi Teknologi Kesehatan: Pengembangan ekosistem data kesehatan yang terintegrasi (SATUSEHAT) dan pemanfaatan bioteknologi modern (Labkesmas Baturaja Kemenkes RI, 2025).

Dunia pertama kali berkomitmen secara global terhadap PHC melalui Deklarasi Alma-Ata pada tahun 1978, deklarasi ini mencetuskan visi "Kesehatan bagi Semua pada Tahun 2000" (*Health for All by the Year 2000*) dengan mendefinisikan kesehatan sebagai kesejahteraan fisik, mental, dan sosial yang utuh, bukan sekadar bebas dari penyakit (van Weel et al., 2020). Alma-Ata menekankan pentingnya partisipasi masyarakat, penggunaan teknologi yang tepat guna, serta kolaborasi lintas sektoral karena kesehatan dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar sektor medis, seperti sanitasi, pendidikan, dan kemiskinan (AbouZahr et al., 2007).

Empat puluh tahun kemudian, pada tahun 2018, para pemimpin dunia kembali berkumpul di Astana, Kazakhstan, untuk meratifikasi Deklarasi Astana (van Weel et al., 2020). Deklarasi ini tidak menggantikan Alma-Ata, melainkan memperbaruinya agar relevan dengan tantangan abad ke-21, seperti lonjakan PTM, dampak kesehatan dari perubahan iklim, dan kemajuan teknologi digital. Astana menegaskan bahwa penguatan PHC adalah prasyarat mutlak untuk mencapai *Universal Health Coverage* (UHC) dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). PKP dipandang sebagai cara yang paling inklusif dan efisien untuk meningkatkan kesejahteraan fisik dan mental penduduk secara berkelanjutan (Galea & Kruk, 2019).

Dalam setiap sistem kesehatan, tenaga kesehatan adalah aset yang paling berharga. Tenaga kesehatan merupakan ujung tombak yang mengimplementasikan regulasi pusat menjadi layanan kesehatan yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

Di tingkat pelayanan primer, tenaga kesehatan berperan sebagai garda terdepan yang tidak hanya melakukan pengobatan, tetapi juga menjadi pendidik, motivator, dan penggerak masyarakat (Janamian et al., 2014).

Transformasi layanan primer baru akan terlihat hasilnya jika tenaga kesehatan siap beradaptasi dengan peran-peran baru yang lebih luas. Perawat, misalnya, memegang peranan sangat penting karena intensitas kontak langsung mereka dengan pasien dan komunitas lebih tinggi dibanding profesi lain (Fahadayna & Hair, 2024). Peran perawat dalam pelayanan primer tidak hanya terbatas pada tindakan medis dasar, tetapi juga mencakup edukasi kesehatan di sekolah, posyandu, hingga kunjungan rumah untuk pemantauan pasien kronis dan pencegahan stunting (Verulava & Jorbenadze, 2022).

Dokter di pelayanan primer berperan sebagai *gatekeeper* yang harus memiliki keterampilan klinis yang mumpuni untuk menangani 90% masalah kesehatan masyarakat agar tidak perlu dirujuk ke rumah sakit. Sementara itu, bidan memiliki peran strategis dalam menurunkan angka kematian ibu dan bayi melalui pelayanan antenatal (ANC) yang berkualitas dan manajemen kesehatan reproduksi remaja (Starfield, 2012). Tenaga kesehatan lainnya, seperti ahli gizi, apoteker, dan sanitarian, bekerja secara kolaboratif untuk memastikan seluruh determinan kesehatan masyarakat dikelola secara holistik (Atun et al., 2010).

Penguatan pelayanan kesehatan primer sebagai fondasi sistem kesehatan adalah sebuah perjalanan panjang yang membutuhkan sinergi antara kebijakan yang tepat, pembiayaan yang memadai, dan tenaga kesehatan yang kompeten serta terdistribusi secara merata. Indonesia telah mengambil langkah besar melalui transformasi sistem kesehatan dan implementasi Integrasi Layanan Primer (ILP). Namun, keberhasilan ini sangat bergantung pada bagaimana kita menyelesaikan tantangan-tantangan fundamental di lapangan.

Tenaga kesehatan harus dipandang sebagai investasi strategis bangsa. Upaya peningkatan kesejahteraan, jaminan keamanan, dan penyediaan fasilitas hidup yang layak di daerah terpencil bukan lagi sekadar janji, melainkan kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah maldistribusi (Kruk et al., 2018). Selain itu, digitalisasi layanan primer harus diarahkan untuk mempermudah, bukan justru menambah beban administratif tenaga kesehatan, agar mereka dapat kembali fokus pada esensi profesi mereka: memberikan asuhan yang penuh empati dan berkualitas kepada pasien (Rezapour et al., 2019).

Fondasi kesehatan primer yang solid akan membentuk ketahanan nasional yang tangguh menghadapi pandemi masa depan dan lonjakan penyakit tidak menular. Dengan mengutamakan pelayanan primer, kita tak hanya bangun sistem yang efisien, tapi juga wujudkan keadilan sosial agar seluruh rakyat Indonesia punya

hak hidup sehat yang adil. Pelayanan primer yang kuat jadi warisan terbaik untuk generasi mendatang.

B. Pelayanan Kesehatan Primer dalam Perspektif Keperawatan Komunitas

Pelayanan Kesehatan Primer (PKP) telah mengalami redefinisi mendalam dalam beberapa dekade terakhir, bergeser dari sekadar gerbang pertama akses medis menuju sebuah filosofi sistemik yang mengintegrasikan seluruh aspek kehidupan manusia. Secara historis, Deklarasi Alma-Ata 1978 menjadi tonggak utama diakuinya kesehatan sebagai hak asasi manusia yang fundamental (Bhutta et al., 2008). Prinsip-prinsip inti yang diperkenalkan pada era tersebut, termasuk akses universal, keadilan (*equity*), partisipasi masyarakat, serta kolaborasi lintas sektoral, tetap relevan namun memerlukan kontekstualisasi baru di tengah tantangan abad ke-21 yang semakin kompleks.

Empat puluh tahun setelah Alma-Ata, dunia menegaskan kembali komitmennya melalui Deklarasi Astana 2018. Deklarasi ini tidak hanya memperkuat nilai-nilai lama, tetapi juga mengintegrasikan PKP ke dalam kerangka Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*) dan Cakupan Kesehatan Semesta (*Universal Health Coverage/UHC*)(UNICEF, 2018). Astana mengakui bahwa sistem kesehatan masa kini harus mampu menghadapi beban ganda penyakit, dampak perubahan iklim, serta ketimpangan yang persisten bagi kelompok miskin dan rentan. Di Indonesia, visi global ini diterjemahkan melalui transformasi sistem kesehatan yang mencakup enam pilar utama, dengan transformasi pelayanan kesehatan primer sebagai pilar prioritas pertama. Fokus transformasi ini adalah menata kembali struktur layanan agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat berdasarkan siklus hidup, mulai dari janin hingga lansia, yang diberikan secara komprehensif melalui integrasi fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama(Irving et al., 2017).

Keperawatan komunitas merupakan disiplin yang unik karena memadukan ilmu keperawatan dengan ilmu kesehatan masyarakat untuk meningkatkan kesehatan populasi. Dalam perspektif ini, Pelayanan Kesehatan Primer tidak hanya dilihat sebagai lokasi fisik (seperti Puskesmas), tetapi sebagai sebuah proses asuhan yang berkelanjutan dan terintegrasi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat (Febriyanti et al., 2025). Dalam keperawatan komunitas, pasien dikelola sebagai bagian utuh dari keluarga dan lingkungan sosialnya, bukan sekadar individu dengan keluhan medis.

Prinsip akses universal dalam keperawatan komunitas menuntut hilangnya segala bentuk hambatan—baik ekonomi, geografis, linguistik, maupun gender—yang mencegah masyarakat memanfaatkan layanan Kesehatan. Hal ini berarti

perawat harus aktif menjangkau populasi yang tidak terjangkau (*reaching the unreached*), memastikan bahwa mereka yang tinggal di daerah terpencil atau kelompok marginal mendapatkan hak kesehatan yang sama (Febriyanti et al., 2025). Keadilan (*equity*) dalam konteks ini bukan berarti memberikan hal yang sama kepada semua orang, melainkan mendistribusikan sumber daya berdasarkan tingkat kebutuhan dan risiko kesehatan. Misalnya, perawat memberikan perhatian lebih intensif kepada balita dengan gizi buruk atau lansia dengan penyakit kronis yang tinggal sendirian (Susilowati & Purwito, 2025).

Peran perawat komunitas sangat luas dan bersifat dinamis, menyesuaikan dengan tantangan kesehatan yang ada di wilayahnya. Secara garis besar, peran ini dibagi menjadi empat kategori utama yang saling mendukung dalam menciptakan masyarakat yang sehat dan mandiri.

Promosi kesehatan adalah pilar terpenting dalam PKP karena biaya pencegahan jauh lebih murah daripada biaya pengobatan. Perawat bertindak sebagai pendidik kesehatan yang tidak hanya memberikan informasi, tetapi juga berupaya mengubah sikap dan perilaku masyarakat (Apriany, 2025). Edukasi kesehatan berbasis keluarga dilakukan untuk memastikan bahwa pengetahuan yang diberikan dapat diterapkan secara konsisten dalam rutinitas rumah tangga (Hanson et al., 2022).

Meningkatkan pemahaman kesehatan masyarakat menjadi kunci agar mereka bisa mengambil keputusan medis yang tepat secara mandiri. Perawat membantu masyarakat untuk mampu memilah informasi kesehatan yang benar dan mengambil keputusan yang tepat terkait kesehatan mereka sendiri. Pemberdayaan kader kesehatan menjadi kunci sukses dalam strategi ini. Kader adalah anggota masyarakat yang dilatih untuk menjadi mitra perawat; mereka memiliki akses sosial yang lebih luas dan bahasa yang lebih mudah diterima oleh warga setempat. Melalui kader, perawat dapat menyebarkan pesan-pesan hidup bersih dan sehat (PHBS) secara lebih masif dan efektif (Zulu & Perry, 2021).

Pemberdayaan kelompok masyarakat juga dilakukan melalui pembentukan kelompok-kelompok swadaya, seperti kelompok pendukung ibu menyusui, kelompok penderita diabetes, atau kelompok lansia sehat. Interaksi di dalam kelompok ini memberikan dukungan emosional dan praktis yang sangat kuat, yang seringkali lebih efektif daripada sekadar nasihat medis dari tenaga profesional (Shrestha et al., 2024).

Dalam peran preventif, perawat komunitas menjadi garda terdepan dalam mencegah munculnya penyakit atau mendeteksinya sedini mungkin sebelum menjadi parah. Skrining dan deteksi dini Penyakit Tidak Menular (PTM) seperti hipertensi dan diabetes dilakukan secara rutin melalui kegiatan Pos Pembinaan

Terpadu (Posbindu). Data menunjukkan bahwa kehadiran perawat dalam kegiatan skrining di desa secara signifikan meningkatkan partisipasi masyarakat dan kepatuhan mereka dalam melakukan pemeriksaan kesehatan berkala (Agarwal et al., 2019).

Surveilans epidemiologi berbasis komunitas memungkinkan perawat untuk memantau tren penyakit di wilayah kerja mereka secara *real-time*. Jika ditemukan peningkatan kasus penyakit menular seperti demam berdarah atau tuberkulosis, perawat dapat segera melakukan investigasi wabah dan langkah-langkah penanggulangan bersama tim Puskesmas. Selain itu, peran preventif mencakup pelaksanaan program imunisasi nasional untuk memastikan terciptanya kekebalan kelompok (*herd immunity*) bagi anak-anak di wilayah tersebut (Susilowati & Purwito, 2025).

Monitoring tumbuh kembang balita dan kesehatan ibu adalah bagian integral dari pencegahan stunting dan kematian ibu/bayi. Perawat melakukan pengukuran antropometri secara rutin dan memberikan konseling gizi bagi ibu yang memiliki balita dengan risiko gagal tumbuh. Upaya pencegahan ini menuntut akurasi data yang baik guna memastikan seluruh warga di wilayah kerja mendapatkan layanan yang sama (Ernawati & Permaida, 2025).

Meskipun PKP berfokus pada pencegahan, perawat komunitas juga memberikan asuhan kuratif dan rehabilitatif dasar bagi masyarakat yang membutuhkan perawatan jangka panjang di rumah. Asuhan keperawatan pada penyakit kronis seperti stroke, penyakit jantung koroner, atau penyakit paru obstruktif kronis (PPOK) difokuskan pada manajemen gejala dan pencegahan komplikasi lebih lanjut (Sawin & O'Connor, 2019). Perawat melatih anggota keluarga untuk mampu melakukan perawatan luka sederhana, pemberian obat yang benar, atau latihan gerak bagi pasien pasca-stroke.

Manajemen kasus berbasis keluarga memungkinkan perawat untuk mengoordinasikan seluruh kebutuhan pasien dalam konteks sumber daya yang dimiliki keluarga tersebut. Kunjungan rumah (*home visit*) menjadi momen krusial untuk melakukan evaluasi terhadap efektivitas pengobatan dan memberikan dukungan psikososial bagi pasien maupun pengasuh (*caregiver*) (Kabir et al., 2021). Dalam beberapa kasus, perawat juga memberikan perawatan paliatif dasar untuk meningkatkan kualitas hidup pasien dengan penyakit terminal, memastikan mereka dapat menghabiskan waktu terakhirnya dengan nyaman dan bermartabat di tengah keluarga.

Dalam sistem kesehatan yang semakin kompleks, perawat komunitas berfungsi sebagai *care coordinator* yang memastikan alur pelayanan pasien berjalan mulus dari tingkat primer ke tingkat rujukan dan kembali lagi ke primer (Su et al., 2023).

Koordinasi ini penting untuk mencegah terjadinya tumpang tindih pelayanan atau hilangnya informasi medis penting saat pasien berpindah fasilitas.

Pelayanan Kesehatan Primer memegang peranan vital dalam mewujudkan sistem kesehatan nasional yang lebih adil bagi seluruh lapisan masyarakat. Perawat bekerja sama dalam tim multidisiplin yang terdiri dari dokter, bidan, sanitarian, nutrisisionis, dan tenaga kesehatan lainnya. Masing-masing profesi membawa perspektif uniknya; misalnya, saat menangani kasus stunting, perawat berkoordinasi dengan nutrisisionis untuk diet anak dan dengan sanitarian untuk memastikan akses air bersih di rumah keluarga tersebut (Khatri et al., 2023a). Kemampuan kolaborasi ini menuntut keterampilan komunikasi yang sangat baik dan rasa saling menghargai antar profesi.

Advokasi kesehatan masyarakat adalah peran yang seringkali terlupakan namun sangat strategis. Perawat menggunakan data kesehatan wilayah untuk meyakinkan pemangku kebijakan lokal (seperti Kepala Desa atau Camat) agar mengalokasikan anggaran untuk pembangunan jamban sehat, penyediaan ambulans desa, atau renovasi Posyandu. Melalui advokasi, perawat memastikan bahwa determinan sosial kesehatan juga diperhatikan dalam kebijakan pembangunan di tingkat dasar.

Keberlanjutan asuhan (*continuity of care*) memastikan bahwa pelayanan tidak terhenti setelah fase akut terlewati. Dalam sistem kesehatan primer, hal ini diwujudkan melalui mekanisme rujukan balik yang efektif dan pemantauan jangka panjang di komunitas. Perawat memastikan bahwa pasien yang pulang dari rumah sakit mendapatkan asuhan lanjutan di rumah melalui kunjungan rumah (*home visit*), sehingga risiko komplikasi atau perawatan ulang dapat ditekan. Pendekatan ini menciptakan rasa aman bagi pasien dan keluarga karena mereka merasa didampingi di setiap tahap pemulihan mereka (Drennan et al., 2014; Febriyanti et al., 2025).

Strategi penguatan PKP yang paling berkelanjutan adalah melalui pemberdayaan masyarakat. Model keperawatan berbasis pemberdayaan mengasumsikan bahwa masyarakat memiliki kekuatan dan sumber daya untuk menyelesaikan masalah kesehatannya sendiri jika diberikan panduan yang tepat (Mendis et al., 2012). Perawat berperan sebagai fasilitator yang membantu komunitas menemukan solusi lokal yang unik.

Contoh nyata dari model ini adalah pengembangan kebun herbal komunitas untuk kemandirian kesehatan keluarga, atau pembentukan kelompok bapak peduli ASI untuk meningkatkan cakupan ASI eksklusif (Mohamad Yoto, 2025). Penguatan kapasitas kader sebagai mitra strategis perawat dilakukan dengan memberikan mereka keterampilan teknis sederhana, seperti pengukuran tekanan darah menggunakan alat digital atau teknik komunikasi motivasi untuk mengajak warga

ber-KB. Ketika masyarakat merasa memiliki program kesehatan tersebut, tingkat partisipasi dan keberlanjutannya akan jauh lebih tinggi dibandingkan program yang dipaksakan dari atas (Walraven, 2019).

Meskipun penuh dengan tantangan, masa depan PKP di Indonesia menawarkan peluang besar melalui inovasi dan integrasi yang lebih dalam. Penggunaan kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*) dan *Big Data* dalam pemetaan risiko kesehatan masyarakat dapat membantu perawat melakukan intervensi yang jauh lebih presisi. Telemedisin dan konsultasi jarak jauh memungkinkan pasien di daerah terpencil mendapatkan masukan dari perawat spesialis tanpa harus menempuh perjalanan jauh (Akbar Pratama et al., 2025).

Penguatan kapasitas masyarakat melalui literasi digital akan mengubah posisi pasien dari penerima layanan yang pasif menjadi mitra aktif dalam menjaga kesehatannya sendiri. Perawat komunitas di masa depan tidak hanya akan bekerja di lapangan secara fisik, tetapi juga akan mengelola komunitas virtual untuk promosi kesehatan dan dukungan sebaya (Rifky & Jannatin, 2025).

Pelayanan Kesehatan Primer adalah lini utama dari sistem kesehatan nasional yang memiliki prinsip keadilan dan berkelanjutan. Peran perawat komunitas sebagai garda terdepan tidak dapat digantikan, karena mereka adalah satu-satunya tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi unik untuk menjembatani asuhan klinis dengan pemberdayaan sosial. Dengan menjalankan fungsi pencegahan dan pengobatan dasar secara terpadu, perawat komunitas mampu meminimalkan beban penyakit di tingkat lokal.

Agar penguatan PKP berjalan efektif, pemerintah perlu memprioritaskan penyederhanaan beban administratif bagi tenaga kesehatan di lapangan. Dengan menempatkan perawat komunitas sebagai aktor kunci dalam transformasi kesehatan, Indonesia memiliki peluang besar untuk mewujudkan visi "Health for All" dan mencapai target pembangunan berkelanjutan demi masa depan bangsa yang lebih sehat dan sejahtera. Kekuatan layanan primer terletak pada integrasi sistem, kemandirian masyarakat, dan jangkauan layanan yang mampu menyentuh setiap keluarga.

C. Peran Tenaga Kesehatan dalam Penguatan Pelayanan Kesehatan Primer sebagai Fondasi Sistem Kesehatan

Sistem kesehatan global saat ini tengah mengalami titik balik krusial yang menuntut reposisi mendasar atas peran Pelayanan Kesehatan Primer (PKP) atau *Primary Health Care* (PHC). Dalam beberapa dekade terakhir, fragmentasi layanan dan orientasi yang berlebihan pada perawatan rumah sakit yang bersifat kuratif (*hospital-centric*) telah mengakibatkan inefisiensi biaya serta ketimpangan akses

bagi populasi rentan. Menanggapi realitas ini, Badan Kesehatan Dunia (WHO) merekomendasikan penguatan PHC melalui tiga strategi utama: integrasi pelayanan kesehatan primer perorangan dan masyarakat, pemberdayaan individu serta komunitas, dan implementasi kebijakan serta aksi multi-sektor (Apriany, 2025). Di Indonesia, visi ini diwujudkan melalui transformasi sistem kesehatan pilar pertama, yaitu transformasi layanan primer, yang bertujuan memperkuat fondasi kesehatan nasional agar mampu menghadapi beban penyakit ganda dan tantangan masa depan (Putri & Adnan, 2025).

PKP bukan sekadar tingkat layanan kesehatan yang paling rendah dalam hierarki medis, melainkan sebuah pendekatan holistik yang memastikan setiap individu menerima asuhan komprehensif mulai dari promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, hingga paliatif sedekat mungkin dengan lingkungan tempat tinggal mereka (Aylward & Salomon, 2025). Sebagai fondasi, PKP yang kuat diproyeksikan dapat memenuhi lebih dari 90% kebutuhan intervensi kesehatan esensial untuk mencapai Cakupan Kesehatan Semesta atau *Universal Health Coverage* (UHC) (World Health Federation, 2026). Namun, penguatan ini memerlukan pergeseran paradigma yang radikal, dari model asuhan yang berpusat pada penyakit (*disease-centered care*) menuju asuhan yang berpusat pada orang (*people-centered care*) (Khatri et al., 2023). Dalam konteks perubahan ini, tenaga kesehatan, khususnya perawat komunitas, muncul sebagai aktor sentral yang tidak hanya bertindak sebagai praktisi klinis, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial yang menggerakkan kesadaran dan kemandirian kesehatan masyarakat (Setiawan, 2025).

Pergeseran paradigma dari *disease-centered* ke *people-centered care* adalah inti dari transformasi layanan primer. Dalam model *disease-centered*, fokus utama adalah pada diagnosis medis dan pengobatan gejala fisik secara terisolasi. Sebaliknya, *people-centered care* memandang individu secara utuh, mempertimbangkan faktor sosial, ekonomi, budaya, dan psikologis yang memengaruhi kesehatan mereka (Aylward & Salomon, 2025). Pendekatan ini menuntut sistem kesehatan untuk lebih responsif terhadap preferensi dan kebutuhan pasien, serta melibatkan mereka secara bermakna dalam proses pengambilan keputusan klinis.

Strategi untuk memperkuat *people-centeredness* mencakup lima komponen utama berdasarkan kerangka kerja *Integrated People-Centred Health Services* (IPCHS):

1. Melibatkan dan memberdayakan individu serta komunitas untuk mengambil peran aktif dalam menjaga kesehatan mereka sendiri.
2. Memperkuat tata kelola dan akuntabilitas sistem kesehatan agar lebih transparan dan berorientasi pada hasil bagi masyarakat.

3. Reorientasi model asuhan dengan menekankan pada pencegahan dan perawatan jangka panjang yang terintegrasi.
4. Mengoordinasikan layanan di dalam dan lintas sektor guna mengatasi determinan sosial kesehatan.
5. Menciptakan lingkungan yang mendukung melalui kebijakan pendanaan yang inklusif dan pengembangan sumber daya manusia.

Di tatanan praktis, perawat komunitas menjadi garda terdepan dalam operasionalisasi *people-centered care*. Mereka melakukan kunjungan rumah untuk memahami konteks kehidupan pasien, memberikan edukasi yang disesuaikan dengan tingkat literasi keluarga, dan membangun hubungan kepercayaan yang memungkinkan intervensi kesehatan diterima dengan lebih baik (Hasna & Falah, 2025).

Perawat komunitas bekerja melampaui tugas klinis di Puskesmas; mereka berperan aktif mendorong perubahan perilaku sehat di lingkungan warga. Sebagai agen perubahan sosial, perawat mengidentifikasi ketimpangan kesehatan dan melakukan advokasi untuk kelompok marginal guna memastikan hak atas kesehatan terpenuhi (Hasna & Falah, 2025). Perawat komunitas menjalankan fungsi multifaset yang krusial bagi keberlangsungan layanan primer.

Untuk mencapai ketahanan sistem kesehatan yang kokoh, diperlukan model ideal penguatan PKP yang menempatkan keperawatan komunitas sebagai intinya. Model ini harus bersifat integratif, berkelanjutan, dan didukung oleh infrastruktur data yang kuat. Fokus utama dari model ini adalah menjaga agar masyarakat tetap sehat melalui upaya promotif dan preventif, tanpa mengabaikan kualitas layanan kuratif di tingkat dasar (KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR HK.01.07/MENKES/2015/2023, 2023).

Model ideal menuntut pergeseran alokasi sumber daya agar lebih dominan pada upaya pencegahan. Investasi pada layanan promotif dan preventif di tingkat primer jauh lebih efektif secara biaya dibandingkan menangani komplikasi penyakit kronis di rumah sakit (World Health Federation, 2026). Hal ini mencakup program skrining massal untuk penyakit tidak menular (PTM), kampanye nutrisi untuk mencegah *stunting*, dan imunisasi dasar lengkap (Putri & Adnan, 2025).

Dalam model integratif, layanan kesehatan tidak lagi diberikan secara terpisah berdasarkan penyakit (*silo-based*), melainkan berdasarkan kelompok usia atau siklus hidup. Sebagai contoh, di sebuah Posyandu yang terintegrasi, seorang ibu hamil tidak hanya diperiksa kehamilannya, tetapi juga diberikan edukasi tentang persiapan menyusui, nutrisi balita bagi anak pertamanya, serta pemeriksaan kesehatan dasar bagi anggota keluarga lainnya yang mendampingi (Kringos et al., 2010). Pendekatan

ini memastikan bahwa setiap kontak dengan tenaga kesehatan menjadi peluang untuk melakukan intervensi kesehatan menyeluruh.

Penguatan PKP juga berarti memperkuat kapasitas keluarga sebagai unit pemberi asuhan mandiri. Sistem rujukan ideal tidak hanya berbicara tentang perpindahan fisik pasien dari Puskesmas ke Rumah Sakit, tetapi juga tentang bagaimana keluarga mampu menjadi "rujukan pertama" dalam mengenali gejala awal penyakit. Perawat komunitas berperan melatih anggota keluarga untuk melakukan perawatan luka mandiri, manajemen diet bagi penderita diabetes, dan pengenalan tanda bahaya pada anak-anak (Macinko et al., 2003).

Dengan sistem rujukan berbasis keluarga yang kuat, banyak kasus yang sebelumnya langsung dibawa ke Instalasi Gawat Darurat (IGD) dapat ditangani secara efektif di rumah atau melalui konsultasi dengan perawat komunitas. Hal ini secara signifikan mengurangi beban kerja rumah sakit yang seringkali kewalahan oleh kasus-kasus non-emergensi (Abdullatif Alnaser, 2021).

Pilar penting dalam model ideal ini adalah digitalisasi dan integrasi data kesehatan. Penggunaan aplikasi seperti "Wilpirangan" menunjukkan bagaimana teknologi berbasis web dapat membantu kader dan perawat dalam melakukan manajemen Posyandu secara lebih efisien (Apriany, 2025). Integrasi data memungkinkan terciptanya profil kesehatan keluarga yang komprehensif, di mana riwayat penyakit, status imunisasi, dan risiko lingkungan terekam dengan baik.

Data yang terintegrasi memungkinkan perawat untuk melakukan intervensi komunitas yang bersifat proaktif. Misalnya, jika data menunjukkan adanya tren peningkatan tekanan darah di satu RW tertentu, perawat dapat segera menginisiasi program intervensi berbasis komunitas seperti klub senam hipertensi atau program edukasi pengurangan asupan garam di wilayah tersebut. Transparansi data juga mendorong akuntabilitas lokal dan memfasilitasi pengambilan keputusan oleh pemerintah desa dalam alokasi anggaran kesehatan (KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR HK.01.07/MENKES/2015/2023, 2023)

Peran aktif perawat komunitas secara langsung akan memperkuat ketangguhan sistem kesehatan nasional dalam jangka panjang. Ketangguhan di sini didefinisikan sebagai kemampuan sistem untuk tetap berfungsi secara efektif selama masa krisis, sekaligus kemampuan untuk terus meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam kondisi normal (WHO, 2025).

PKP berfungsi sebagai sistem peringatan dini (*early warning system*) yang paling sensitif terhadap ancaman penyakit menular. Selama pandemi COVID-19, terlihat jelas bahwa wilayah dengan layanan kesehatan primer yang terintegrasi dengan baik mampu melakukan pelacakan kontak (*tracing*), edukasi masyarakat, dan distribusi vaksin dengan jauh lebih cepat. Perawat komunitas, dengan modal

sosial dan kepercayaan yang mereka miliki, merupakan komunikator risiko yang paling efektif dalam menghadapi miss informasi dan keraguan masyarakat terhadap vaksin (Kabak, 2025).

Resiliensi sistem kesehatan juga diuji dari kemampuannya untuk tetap menyediakan layanan kesehatan rutin di tengah krisis. PKP memastikan bahwa ibu hamil tetap mendapatkan pemeriksaan antenatal, bayi tetap mendapatkan imunisasi, dan penderita penyakit kronis tetap mendapatkan pasokan obat meskipun sistem kesehatan sedang berada di bawah tekanan besar (World Health Federation, 2026). Dengan demikian, PKP adalah jangkar yang menjaga sistem kesehatan agar tidak runtuh saat menghadapi beban yang tak terduga.

Transformasi sistem kesehatan menuju penguatan layanan primer bukan sekadar perubahan administratif, melainkan sebuah komitmen moral untuk menciptakan keadilan kesehatan. Peran tenaga kesehatan, khususnya perawat komunitas, sebagai jembatan antara kebijakan dan realitas, antara institusi dan individu, adalah kunci keberhasilan transformasi ini. Dengan memperkuat pendidikan keperawatan yang berbasis komunitas, menerapkan model asuhan yang berpusat pada orang, dan mengintegrasikan data untuk intervensi yang presisi, Indonesia dapat membangun sistem kesehatan yang tidak hanya tangguh terhadap krisis, tetapi juga mampu memberikan kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya menuju visi Indonesia Emas 2045

D. Simpulan

Pelayanan Kesehatan Primer (PKP) atau *Primary Health Care* (PHC) tidak lagi sekadar dipandang sebagai unit layanan teknis tingkat dasar, melainkan fondasi utama dan strategi paling efektif untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan. Transformasi sistem kesehatan di Indonesia, khususnya melalui pilar pertama Transformasi Layanan Primer, menandai pergeseran paradigma fundamental dari fokus penyembuhan penyakit (*sick care* atau *disease-centered*) menjadi pemeliharaan kesehatan (*health care* atau *people-centered*) yang memprioritaskan upaya promotif dan preventif.

Perubahan ini menempatkan tenaga kesehatan, khususnya perawat komunitas, sebagai aset strategis dan garda terdepan. Peran perawat komunitas kini melampaui batas klinis tradisional, berkembang menjadi edukator, *care coordinator*, advokat, serta agen perubahan sosial yang menjembatani kebijakan kesehatan dengan realitas kebutuhan masyarakat. Melalui pendekatan yang holistik, perawat komunitas memastikan layanan kesehatan terintegrasi berdasarkan siklus hidup manusia, mulai dari janin hingga lansia, serta aktif menjangkau populasi yang terpinggirkan (*reaching the unreached*) demi terciptanya keadilan akses (*equity*).

Keberhasilan penguatan PKP di masa depan sangat bergantung pada sinergi antara pemberdayaan masyarakat, kolaborasi interprofesional, dan adopsi teknologi digital. Pemanfaatan *Artificial Intelligence*, *Big Data*, dan telemedisin diharapkan dapat meningkatkan presisi intervensi kesehatan serta mempermudah akses bagi wilayah terpencil, tanpa menambah beban administratif tenaga kesehatan. Selain itu, pemberdayaan kader dan keluarga sebagai unit pemberi asuhan mandiri menjadi kunci keberlanjutan program kesehatan

E. Referensi

- Abdullatif Alnaser, F. (2021). Primary Health Care: The Foundation of the Health System. *International Journal of Family Medicine and Primary Care*, 2(2), 1037. <https://www.who.int/mediacentre/news/releases/2015/uhc-report/>
- AbouZahr, C., Adjei, S., & Kanchanachitra, C. (2007). From data to policy: good practices and cautionary tales. *Lancet*, 369(9566), 1039–1046. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(07\)60463-2](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(07)60463-2)
- Agarwal, S., Kirk, K., Sripad, P., Bellows, B., Abuya, T., & Warren, C. (2019). Setting the global research agenda for community health systems: Literature and consultative review. *Human Resources for Health*, 17(1), 22-. <https://doi.org/10.1186/S12960-019-0362-8/PEER-REVIEW>
- Akbar Pratama, P., Ma, A., & Fikri, mun. (2025). Transformasi UU No. 17 Tahun 2023 dalam Mendorong Sistem Kesehatan yang Inklusif dan Berkelanjutan (Tinjauan Yuridis Normatif dalam Analisis Peluang dan Tantangan). *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 5(6), 5352–5367. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i6>
- Apriany, R. (2025). ANALISIS SDM TENAGA KESEHATAN DAN KADER UNTUK PENINGKATAN AKSES DAN KUALITAS LAYANAN ILP TERNATE 2024-2025. *Jurnal Inovasi Hasil Penelitian Dan Pengembangan*, 5(5), 714–723.
- Ardiansyah, F., Efendi, F., & Tristiana, R. R. D. (2024). Online-Based Intervention as an Effort to Increase Physical Activity Among Adolescent. *Journal Of Nursing Practice*, 7(2), 458–465. <https://doi.org/10.30994/JNP.V7I2.513>
- Atun, R., De Jongh, T., Secci, F., Ohiri, K., & Adeyi, O. (2010). Integration of targeted health interventions into health systems: A conceptual framework for analysis. *Health Policy and Planning*, 25(2), 104–111. <https://doi.org/10.1093/HEAPOL/CZP055>
- Aylward, B., & Salomon, J. (2025, May 2). *Primary health care: a scalable solution to the noncommunicable diseases and mental health crisis*. WHO.

<https://www.who.int/news-room/commentaries/detail/primary-health-care--a-scalable-solution-to-the-noncommunicable-diseases-and-mental-health-crisis>

- Bhutta, Z. A., Ali, S., Cousens, S., Ali, T. M., Haider, B. A., Rizvi, A., Okong, P., Bhutta, S. Z., & Black, R. E. (2008). Alma-Ata: Rebirth and Revision 6 Interventions to address maternal, newborn, and child survival: what difference can integrated primary health care strategies make? *The Lancet*, 372(9642), 972–989. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(08\)61407-5](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(08)61407-5)
- Catra Octo Chrisandi. (2024). *PENERAPAN INTEGRASI PELAYANAN PRIMER DI KLINIK*. PENERBIT DEEPUBLISH DIGITAL. <https://repository.deepublish.com/media/publications/592596-penerapan-integrasi-pelayanan-primer-di-aa844459.pdf>
- Drennan, V. M., Halter, M., Brearley, S., Carneiro, W., Gabe, J., Gage, H., Grant, R., Joly, L., & de Lusignan, S. (2014). Investigating the contribution of physician assistants to primary care in England: a mixed-methods study. *Health Services and Delivery Research*, 2(16), 1–136. <https://doi.org/10.3310/HSDR02160>
- Ernawati, & Permaida. (2025). Status of nursing documentation types in Indonesia and their association with nurse characteristics: A cross-sectional survey. *Belitung Nursing Journal*, 11(5), 630. <https://doi.org/10.33546/BNJ.3732>
- Fahadayna, A. C., & Hair, A. (2024). Mapping the extraordinary measure disease outbreak (EMDO): An analysis of health regulations in Indonesia 2000–2023. *World Medical and Health Policy*, 16(2), 153–171. <https://doi.org/10.1002/WMH3.593>
- Febriyanti, R. M., Irawan, A. A., Anggriani, N., Andriyana, Y., & Abdulah, R. (2025). Challenges in implementing Indonesia's community-based chronic disease management program (Prolanis): A scoping review. *AIMS Public Health*, 12(3), 890. <https://doi.org/10.3934/PUBLICHEALTH.2025045>
- Galea, S., & Kruk, M. E. (2019). Forty Years After Alma-Ata: At the Intersection of Primary Care and Population Health. *The Milbank Quarterly*, 97(2), 383–386. <https://doi.org/10.1111/1468-0009.12381>
- Hanson, K., Brikci, N., Erlangga, D., Alebachew, A., De Allegri, M., Balabanova, D., Blecher, M., Cashin, C., Esperato, A., Hipgrave, D., Kalisa, I., Kurowski, C., Meng, Q., Morgan, D., Mtei, G., Nolte, E., Onoka, C., Powell-Jackson, T., Roland, M., ... Wurie, H. (2022). The Lancet Global Health Commission on financing primary health care: putting people at the centre. *The Lancet. Global Health*, 10(5), e715–e772.

[https://doi.org/10.1016/S2214-109X\(22\)00005-5/ASSET/7BD6F69A-EE7E-4A59-9BAF-9A5A160C96B4/MAIN.ASSETS/GR12.JPG](https://doi.org/10.1016/S2214-109X(22)00005-5/ASSET/7BD6F69A-EE7E-4A59-9BAF-9A5A160C96B4/MAIN.ASSETS/GR12.JPG)

- Hasna, A., & Falah, M. (2025). Peran Perawat Komunitas Sebagai Edukator Terhadap Kesehatan Masyarakat Untuk Mencapai SDGs: Literatur Review. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 2(6), 1045–1050. <https://doi.org/doi.org/10.61722/jmia.v2i6.7416>
- Irving, G., Neves, A. L., Dambha-Miller, H., Oishi, A., Tagashira, H., Verho, A., & Holden, J. (2017). International variations in primary care physician consultation time: A systematic review of 67 countries. *BMJ Open*, 7(10). <https://doi.org/10.1136/BMJOPEN-2017-017902>
- Janamian, T., Jackson, C. L., Glasson, N., & Nicholson, C. (2014). A systematic review of the challenges to implementation of the patient-centred medical home: Lessons for australia. *Medical Journal of Australia*, 201(3). <https://doi.org/10.5694/MJA14.00295>
- Kabak, E. (2025). *PERAWAT SEBAGAI AGEN KESEHATAN MENJAGA KESEHATAN, MENYELAMATKAN NYAWA* (1st ed., Vol. 1). EUREKA MEDIA AKSARA. <https://repository.penerbiteureka.com/media/publications/610281-perawat-sebagai-agen-kesehatan-menjaga-k-d443603d.pdf>
- Kabir, A., Karim, M. N., & Billah, B. (2021). Primary healthcare system readiness to prevent and manage non-communicable diseases in Bangladesh: A mixed-method study protocol. *BMJ Open*, 11(9). <https://doi.org/10.1136/BMJOPEN-2021-051961>
- KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR HK.01.07/MENKES/2015/2023, Pub. L. NOMOR HK.01.07/MENKES/2015/2023, KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA (2023).
- Khatri, R. B., Wolka, E., Nigatu, F., Zewdie, A., Erku, D., Endalamaw, A., & Assefa, Y. (2023a). People-centred primary health care: a scoping review. *BMC Primary Care*, 24(1). <https://doi.org/10.1186/S12875-023-02194-3>
- Khatri, R. B., Wolka, E., Nigatu, F., Zewdie, A., Erku, D., Endalamaw, A., & Assefa, Y. (2023b). People-centred primary health care: a scoping review. *BMC Primary Care*, 24(1), 236. <https://doi.org/10.1186/S12875-023-02194-3>
- Kringos, D. S., Boerma, W. G., Bourgueil, Y., Cartier, T., Hasvold, T., Hutchinson, A., Lember, M., Oleszczyk, M., Pavlic, D. R., Svab, I., Tedeschi, P., Wilson, A., Windak, A., Dedeu, T., & Wilm, S. (2010). The european primary care monitor: Structure, process and outcome indicators. *BMC Family Practice*, 11. <https://doi.org/10.1186/1471-2296-11-81>
- Kruk, M. E., Gage, A. D., Joseph, N. T., Danaei, G., García-Saisó, S., & Salomon, J. A. (2018). Mortality due to low-quality health systems in the universal

health coverage era: a systematic analysis of amenable deaths in 137 countries. *The Lancet*, 392(10160), 2203–2212. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(18\)31668-4](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(18)31668-4)

- Labkesmas Baturaja Kemenkes RI. (2025, June). *6 Pilar Transformasi Kesehatan*. <https://labkesmas-baturaja.go.id/read-6-pilar-transformasi-kesehatan>
- Macinko, J., Starfield, B., & Shi, L. (2003). The contribution of primary care systems to health outcomes within Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) countries, 1970-1998. *Health Services Research*, 38(3), 831–865. <https://doi.org/10.1111/1475-6773.00149>
- Mendis, S., Al Bashir, I., Dissanayake, L., Varghese, C., Fadhil, I., Marhe, E., Sambo, B., Mehta, F., Elsayad, H., Sow, I., Algoe, M., Tennakoon, H., Truong, L. D., Lan, L. T. T., Huiuinato, D., Hewageegana, N., Fahal, N. A. W., Mebrhatu, G., Tshering, G., & Chestnov, O. (2012). Gaps in capacity in primary care in low-resource settings for implementation of essential noncommunicable disease interventions. *International Journal of Hypertension*, 2012. <https://doi.org/10.1155/2012/584041>
- Mohamad Yoto. (2025). Encouraging Healthcare Childbirth to Increase Exclusive Breastfeeding: Evidence from Madurese, Indonesia. *Amerta Nutrition*, 9(1), 45–54. <https://doi.org/10.20473/amnt.v9i1.2025.45-54>
- Putri, M., & Adnan, M. F. (2025). Implementasi Program Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer (ILP) melalui Posyandu di Nagari Kasang. *AI-DYAS*, 5(1), 27–40. <https://doi.org/10.58578/ALDYAS.V5I1.7832>
- Rezapour, R., Tabrizi, J. S., Farahbakhsh, M., Saadati, M., & Abdolahi, H. M. (2019). Developing Iranian primary health care quality framework: A national study. *BMC Public Health*, 19(1). <https://doi.org/10.1186/S12889-019-7237-8>
- Rifky, P. M., & Jannatin, I. S. (2025). Kajian Literatur tentang Pengaruh Aplikasi Kesehatan Satusehat Mobile dan Mobile JKN terhadap Kesadaran Gaya Hidup Sehat di Indonesia (2019-2023). *Jurnal Penelitian Inovatif*, 5(1), 327–352. <https://doi.org/10.54082/jupin.920>
- Sawin, G., & O'Connor, N. (2019). Primary Care Transformation. *Primary Care - Clinics in Office Practice*, 46(4), 549–560. <https://doi.org/10.1016/J.POP.2019.07.006>
- Setiawan, A. (2025, August 6). *Prof. Agus Setiawan Serukan Optimalisasi Peran Perawat Komunitas untuk Wujudkan Generasi Sehat Menuju Indonesia Emas 2045 – Fakultas Ilmu Keperawatan*. Universitas Indonesia. <https://nursing.ui.ac.id/prof-agus-setiawan-serukan->

- Shrestha, P., Afsana, K., Weerasinghe, M. C., Perry, H. B., Joshi, H., Rana, N., Memon, Z. A., Khaled, N., Malhotra, S., Bhardwaj, S., Kafle, S., Inagaki, Y., Schimdt, A., Hodgins, S., Neupane, D., & Rao, K. D. (2024). Strengthening primary health care through community health workers in South Asia. *The Lancet Regional Health - Southeast Asia*, 28, 100463. <https://doi.org/10.1016/J.LANSEA.2024.100463/ATTACHMENT/0921EC56-FC3A-47E9-A0FA-A03735AF540C/MMC1.DOCX>
- Starfield, B. (2012). Primary care: An increasingly important contributor to effectiveness, equity, and efficiency of health services. SESPAS report 2012. *Gaceta Sanitaria*, 26(SUPPL.1), 20–26. <https://doi.org/10.1016/J.GACETA.2011.10.009>
- Su, W., Hou, Y., Huang, M., Xu, J., Du, Q., & Wang, P. (2023). Evaluating the efficiency of primary health care institutions in China: an improved three-stage data envelopment analysis approach. *BMC Health Services Research*, 23(1). <https://doi.org/10.1186/S12913-023-09979-3>
- Susilowati, I., & Purwito, D. (2025). Expanding Nursing Roles: A Phenomenological Study in Indonesian Primary Health Care. *INTERNATIONAL JOURNAL OF CARE SCHOLARS*, 8(3), 104–110. <https://doi.org/10.31436/IJCS.V8I3.483>
- UNICEF. (2018, September 27). *Astana Global Conference on Primary Health Care A renewed commitment to primary health care to achieve universal health coverage*. 2018. <https://www.unicef.org/eca/stories/astana-global-conference-primary-health-care>
- van Weel, C., Hartman, T. O., Rouleau, K., Bazemore, A., Westfall, J., Russell, G., Kidd, M., Howe, A., Phillips, R. L., Li, D., & Goodyear-Smith, F. (2020). THE DECLARATION OF ASTANA AND WHAT IT MEANS FOR THE GLOBAL ROLE OF NAPCRG AND WONCA. *Annals of Family Medicine*, 18(2), 189. <https://doi.org/10.1370/AFM.2524>
- Verulava, T., & Jorbenadze, A. (2022). PRIMARY HEALTH CARE REFORMS IN GEORGIA: THE EXPERIENCE AND CHALLENGES. *Archives of the Balkan Medical Union*, 57(4), 384–389. <https://doi.org/10.31688/ABMU.2022.57.4.07>
- Walraven, G. (2019). The 2018 Astana Declaration on Primary Health Care, is it useful? *Journal of Global Health*, 9(1). <https://doi.org/10.7189/jogh.09.010313>
- WHO. (2025, December 5). *Primary health care*. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/primary-health-care>

- World Health Federation. (2026, February 3). *Strengthening Primary Healthcare as a Foundation for NCD Prevention and Care* - World Heart Federation. <https://world-heart-federation.org/news/strengthening-primary-healthcare-as-a-foundation-for-ncd-prevention-and-care/>
- Zulu, J. M., & Perry, H. B. (2021). Community health workers at the dawn of a new era. *Health Res Policy Syst*, 19, 1–6. <https://doi.org/10.1186/s12961-021-00761-7>

CHAPTER 2

PERAN TENAGA KESEHATAN DALAM PENGUATAN PUSKESMAS DAN LAYANAN PRIMER

Erma Puspita Sari, SST., Bdn., M.Kes.

A. Pendahuluan

Penguatan layanan kesehatan primer merupakan kebutuhan strategis dalam pembangunan kesehatan nasional karena layanan primer menjadi titik kontak awal masyarakat dengan sistem kesehatan serta berperan penting dalam upaya pencegahan penyakit dan peningkatan kualitas hidup. Layanan primer yang kuat terbukti mampu meningkatkan akses, kesinambungan pelayanan, dan efisiensi sistem kesehatan secara keseluruhan. (Starfield, 2011)

Sistem pelayanan kesehatan primer yang efektif tidak hanya berfokus pada penyembuhan penyakit, tetapi juga menempatkan individu dan keluarga sebagai pusat pelayanan melalui pendekatan promotif, preventif, dan berkelanjutan. Pendekatan ini relevan dengan tantangan kesehatan masyarakat saat ini, seperti meningkatnya penyakit tidak menular, masalah kesehatan ibu dan anak, serta perubahan pola demografi dan sosial. (Stanhope & Lancaster, 2020). Di Indonesia, Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) berfungsi sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan tingkat pertama yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan berbasis wilayah kerja. Keberadaan Puskesmas menjadi instrumen penting dalam menjamin pemerataan akses pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat. (Kementerian Kesehatan RI, 2019).

Perkembangan permasalahan kesehatan yang semakin kompleks menuntut Puskesmas untuk tidak hanya berperan sebagai penyedia layanan kuratif dasar, tetapi juga sebagai pusat penggerak upaya promotif dan preventif yang terintegrasi dengan kebutuhan masyarakat. Kondisi ini mendorong perlunya penguatan peran tenaga kesehatan sebagai pelaksana utama layanan primer. (Trisnantoro, 2018). Pemerintah Indonesia telah menginisiasi berbagai program penguatan layanan primer, salah satunya melalui transformasi layanan kesehatan yang menempatkan layanan primer sebagai fondasi sistem kesehatan. Program ini menekankan integrasi layanan berbasis siklus hidup, penguatan jejaring pelayanan, serta peningkatan kualitas dan kesinambungan layanan di tingkat komunitas. (Kementerian Kesehatan RI, 2023).

Implementasi penguatan layanan primer pada tingkat Puskesmas sangat bergantung pada peran tenaga kesehatan yang berinteraksi langsung dengan klien. Tenaga kesehatan tidak hanya berfungsi sebagai pemberi layanan klinis, tetapi juga sebagai pendamping, edukator, dan fasilitator perubahan perilaku kesehatan masyarakat. (Notoatmodjo, 2014).

Perawat dan bidan merupakan tenaga kesehatan yang memiliki intensitas interaksi paling tinggi dengan klien, keluarga, dan komunitas dalam pelayanan kesehatan primer. Kedekatan tersebut menjadikan perawat dan bidan memiliki posisi strategis dalam membangun hubungan terapeutik, meningkatkan kepercayaan klien, serta mendorong kepatuhan terhadap pelayanan kesehatan. (Allender, Rector, & Warner, 2014).

Peran perawat dalam layanan primer tercermin melalui asuhan keperawatan individu dan keluarga, pemantauan kondisi kesehatan jangka panjang, serta pendampingan klien dalam mengelola masalah kesehatan secara mandiri. Pendekatan keperawatan keluarga memungkinkan perawat memahami konteks sosial dan lingkungan yang memengaruhi status kesehatan klien. (Stanhope & Lancaster, 2020). Peran bidan dalam layanan primer diwujudkan melalui pelayanan kesehatan ibu dan anak, kesehatan reproduksi, serta keluarga berencana yang berorientasi pada kebutuhan dan pilihan klien. Asuhan kebidanan yang berkesinambungan berkontribusi pada peningkatan keselamatan ibu dan bayi serta kepuasan klien terhadap pelayanan kesehatan. (Sandall et al., 2016).

Penguatan peran perawat dan bidan dalam layanan primer juga didukung oleh kerangka regulasi nasional yang mengatur penyelenggaraan Puskesmas dan praktik pelayanan kesehatan tingkat pertama. Regulasi tersebut memberikan dasar hukum bagi perawat dan bidan untuk menjalankan perannya secara profesional dan terintegrasi dalam sistem pelayanan kesehatan. (Kementerian Kesehatan RI, 2019). Dengan demikian, penguatan Puskesmas dan layanan kesehatan primer tidak dapat dilepaskan dari optimalisasi peran perawat dan bidan sebagai tenaga kesehatan yang paling dekat dengan klien. Pemahaman terhadap peran tersebut menjadi penting untuk memastikan bahwa pelayanan kesehatan primer mampu menjawab kebutuhan kesehatan masyarakat secara efektif dan berkelanjutan. (Trisnantoro, 2018).

B. Konsep Layanan Kesehatan Primer dan Kerangka Operasional Peran Bidan

Layanan kesehatan primer dipahami sebagai pelayanan kesehatan esensial yang diselenggarakan secara komprehensif, berkesinambungan, dan berorientasi pada kebutuhan individu, keluarga, dan komunitas. Layanan ini menekankan pendekatan promotif dan preventif tanpa mengesampingkan aspek kuratif dasar

serta rehabilitatif sesuai kewenangan layanan tingkat pertama. (Starfield, 2011). Dalam konteks sistem kesehatan, layanan primer berfungsi sebagai pintu masuk utama masyarakat ke dalam sistem pelayanan kesehatan serta sebagai pengendali kesinambungan pelayanan melalui mekanisme rujukan yang rasional dan terkoordinasi. Penguatan layanan primer menjadi strategi efektif untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat sekaligus mengendalikan pembiayaan kesehatan. (Trisnantoro, 2018).

Puskesmas sebagai fasilitas layanan primer di Indonesia menjalankan fungsi pelayanan kesehatan berbasis wilayah kerja dengan karakteristik masyarakat yang beragam. Kondisi ini menuntut pendekatan operasional layanan yang adaptif terhadap kebutuhan kesehatan lokal dan dinamika sosial budaya masyarakat. (Kementerian Kesehatan RI, 2019). Kerangka operasional peran bidan di layanan primer disusun berdasarkan prinsip pelayanan berpusat pada klien, kesinambungan asuhan, pemberdayaan keluarga, serta keterpaduan layanan dalam jejaring Puskesmas. Kerangka ini menjadi landasan konseptual bagi pembahasan peran bidan pada subbab berikutnya. (Notoatmodjo, 2014).

C. Peran Operasional Bidan terhadap Klien dalam Praktik Layanan Primer

Bidan memiliki peran operasional yang sangat strategis dalam layanan kesehatan primer karena praktik kebidanan secara langsung menyentuh kebutuhan kesehatan perempuan, ibu, bayi, dan keluarga pada berbagai fase siklus kehidupan. Dalam konteks Puskesmas, bidan tidak hanya berperan sebagai pemberi layanan klinis, tetapi juga sebagai pendamping klien yang berkelanjutan dalam menjaga dan meningkatkan derajat kesehatan. (Homer et al., 2014).

Peran operasional bidan terhadap klien di layanan primer diawali melalui asuhan kebidanan yang berpusat pada klien (*woman-centered care*), yaitu pendekatan pelayanan yang menghormati kebutuhan, nilai, pilihan, serta kondisi sosial budaya klien. Pendekatan ini menempatkan klien sebagai subjek aktif dalam proses asuhan kebidanan. (Renfrew et al., 2014)

1. Asuhan kebidanan pada masa prakonsepsi dan kehamilan di Puskesmas berperan penting dalam mempersiapkan kesehatan ibu dan janin melalui skrining faktor risiko, pemantauan status kesehatan, konseling gizi, serta edukasi kesiapan persalinan. (Kementerian Kesehatan RI, 2019)
2. Pelayanan kebidanan pada masa persalinan dan nifas di layanan primer menuntut bidan memberikan asuhan yang aman, bermutu, dan berkelanjutan dengan dukungan emosional dan edukasi perawatan ibu serta bayi. (Sandall et al., 2016)

3. Pelayanan kesehatan bayi dan anak, keluarga berencana, serta kesehatan reproduksi remaja merupakan kelanjutan logis dari peran bidan terhadap klien yang bersifat berkesinambungan lintas fase kehidupan. (Homer et al., 2014)

Dengan pemahaman peran bidan terhadap klien pada level praktik, pembahasan selanjutnya diarahkan pada bagaimana peran tersebut diperluas dan diperkuat dalam konteks sistem dan program Puskesmas. (Trisnantoro, 2018)

D. Peran Bidan dalam Penguatan Puskesmas dan Layanan Primer pada Level Sistem dan Program

Penguatan Puskesmas dan layanan kesehatan primer pada level sistem dan program memerlukan kontribusi aktif bidan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program kesehatan ibu, anak, remaja, dan keluarga. Keterlibatan ini memastikan bahwa program yang dijalankan relevan dengan kebutuhan masyarakat di wilayah kerja. (Kementerian Kesehatan RI, 2019). Peran bidan dalam penguatan fungsi Puskesmas berbasis wilayah mencakup pemetaan masalah kesehatan, identifikasi kelompok berisiko, serta pengintegrasian pelayanan kebidanan dengan kegiatan berbasis komunitas. (Trisnantoro, 2018). Kontribusi bidan pada program prioritas nasional, seperti kesehatan ibu dan anak, pencegahan stunting, dan keluarga berencana, memperkuat kesinambungan antara kebijakan, program, dan pelayanan kepada klien. (BKKBN, 2020). Pemahaman peran bidan pada level sistem dan program menjadi dasar penting untuk melihat bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan secara operasional melalui Integrasi Layanan Primer.

E. Implementasi Peran Bidan dalam Integrasi Layanan Primer (ILP)

Integrasi Layanan Primer bertujuan memperkuat layanan kesehatan berbasis siklus hidup melalui pengintegrasian pelayanan klinis, promotif, dan preventif yang dilaksanakan secara terkoordinasi di tingkat Puskesmas dan jejaringnya. (Kementerian Kesehatan RI, 2023). Pendekatan siklus hidup memungkinkan bidan memberikan asuhan kebidanan yang berkesinambungan mulai dari remaja, prakonsepsi, kehamilan, persalinan, nifas, bayi baru lahir, hingga keluarga berencana. (Homer et al., 2014). Posyandu dan kunjungan rumah menjadi wahana utama implementasi ILP yang memperkuat kesinambungan layanan primer berbasis komunitas. (Notoatmodjo, 2014). Implementasi ILP menjadi landasan penting untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang bidan dalam penguatan layanan primer, yang dibahas pada subbab berikutnya. (Trisnantoro, 2018).

F. Tantangan dan Peluang Bidan dalam Penguatan Layanan Primer

Penguatan layanan kesehatan primer menempatkan bidan pada posisi strategis sekaligus menghadirkan berbagai tantangan dalam praktik pelayanan sehari-hari di Puskesmas dan jejaringnya. Tantangan tersebut muncul seiring meningkatnya kompleksitas masalah kesehatan ibu, anak, dan keluarga serta tuntutan pelayanan yang semakin komprehensif. (Trisnantoro, 2018). Salah satu tantangan utama yang dihadapi bidan adalah tingginya beban kerja yang disertai dengan keterbatasan sumber daya manusia dan sarana prasarana di beberapa wilayah kerja Puskesmas. Kondisi ini berpotensi memengaruhi kualitas asuhan kebidanan dan kesinambungan pendampingan klien apabila tidak dikelola secara sistematis. (Kementerian Kesehatan RI, 2019). Tantangan lain berkaitan dengan variasi kompetensi bidan dalam merespons perkembangan kebijakan dan pendekatan baru layanan primer, termasuk implementasi Integrasi Layanan Primer dan pendekatan berbasis siklus hidup. (Notoatmodjo, 2014).

Kondisi sosial budaya masyarakat juga menjadi tantangan tersendiri dalam praktik kebidanan di layanan primer karena nilai, kepercayaan, dan norma tertentu dapat memengaruhi penerimaan klien terhadap pelayanan kesehatan. Bidan dituntut memiliki kemampuan komunikasi dan pendekatan budaya yang sensitif agar asuhan kebidanan dapat diterima secara optimal. (Allender, Rector, & Warner, 2014). Di sisi lain, penguatan layanan primer membuka peluang besar bagi bidan untuk mengoptimalkan peran profesionalnya melalui perluasan cakupan praktik kebidanan berbasis komunitas dan keluarga. Peluang ini memungkinkan bidan berkontribusi lebih luas dalam upaya promotif dan preventif yang berdampak langsung pada peningkatan derajat kesehatan masyarakat. (Homer et al., 2014).

Implementasi kebijakan ILP memberikan peluang bagi bidan untuk memperkuat kesinambungan asuhan kebidanan melalui pendekatan siklus hidup, Posyandu, dan kunjungan rumah. Pendekatan ini mendukung bidan dalam membangun hubungan jangka panjang dengan klien dan keluarga. (Sandall et al., 2016). Pengembangan kompetensi bidan melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan menjadi peluang strategis dalam meningkatkan mutu layanan primer. Peningkatan kompetensi tersebut mendukung bidan dalam menerapkan praktik kebidanan berbasis bukti dan responsif terhadap kebutuhan klien. (Homer et al., 2014).

Pemanfaatan sistem informasi kesehatan dan pencatatan program juga membuka peluang bagi bidan untuk berperan dalam penguatan tata kelola layanan primer melalui pengambilan keputusan berbasis data. Peran ini memperkuat posisi bidan dalam sistem pelayanan kesehatan tingkat pertama. (Trisnantoro, 2018).

Dengan mengelola tantangan secara adaptif dan memanfaatkan peluang yang ada, bidan dapat menjadi penggerak utama dalam penguatan Puskesmas dan layanan kesehatan primer yang berorientasi pada kebutuhan klien, keluarga, dan komunitas. (Notoatmodjo, 2014).

G. Praktik Baik (Best Practices) Penguatan Layanan Primer Berbasis Kebidanan

Praktik baik penguatan layanan primer berbasis kebidanan ditandai oleh kemampuan bidan dalam mengintegrasikan asuhan kebidanan klinis dengan pendekatan kesehatan masyarakat secara kontekstual di wilayah kerja Puskesmas. Integrasi tersebut memungkinkan pelayanan yang lebih adaptif terhadap kebutuhan klien dan keluarga. (Trisnantoro, 2018). Salah satu praktik baik yang berkembang di layanan primer adalah pendampingan kebidanan berkelanjutan melalui pendekatan *continuity of care* yang diterapkan secara konsisten sejak masa kehamilan hingga keluarga berencana. Pendekatan ini terbukti meningkatkan kepuasan klien serta memperkuat kepercayaan terhadap layanan kebidanan. (Sandall et al., 2016)

Pelaksanaan kelas ibu hamil dan kelas ibu balita yang dikelola oleh bidan menjadi praktik promotif yang efektif dalam meningkatkan literasi kesehatan dan kesiapan keluarga menghadapi kehamilan, persalinan, serta pengasuhan anak. Kegiatan ini juga memperkuat fungsi edukatif Puskesmas di tingkat komunitas. (Notoatmodjo, 2014). Penguatan peran bidan dalam Posyandu melalui pembinaan kader dan pendampingan kegiatan rutin merupakan praktik baik yang berkontribusi pada peningkatan cakupan layanan dan deteksi dini masalah kesehatan ibu dan anak. Kolaborasi bidan dan kader memperluas jangkauan layanan primer hingga tingkat keluarga. (Kementerian Kesehatan RI, 2023).

Kunjungan rumah yang terencana dan terdokumentasi dengan baik menjadi praktik efektif dalam menjangkau ibu dan bayi berisiko serta keluarga dengan keterbatasan akses layanan. Melalui kunjungan rumah, bidan dapat memberikan asuhan kebidanan yang lebih personal dan kontekstual. (Stanhope & Lancaster, 2020). Pemanfaatan data pelayanan kebidanan sebagai dasar perencanaan kegiatan di Puskesmas merupakan praktik baik yang mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti. Data tersebut membantu bidan dan pengelola Puskesmas dalam menentukan prioritas intervensi kesehatan ibu dan anak. (Trisnantoro, 2018).

H. Arah Penguatan Peran Bidan dalam Layanan Primer Berkelanjutan

penguatan peran bidan dalam layanan primer perlu diarahkan pada pengembangan praktik kebidanan yang adaptif terhadap perubahan kebutuhan kesehatan masyarakat dan dinamika kebijakan kesehatan nasional. Pendekatan ini menuntut bidan untuk terus meningkatkan kompetensi profesional dan kapasitas

kepemimpinan di tingkat layanan primer. (Homer et al., 2014). Penguatan peran bidan sebagai pemimpin komunitas kesehatan perempuan menjadi penting dalam mendukung transformasi layanan primer yang berorientasi promotif dan preventif. Peran kepemimpinan ini mencakup kemampuan advokasi, komunikasi, dan kolaborasi lintas sektor (Notoatmodjo, 2014). Integrasi teknologi informasi dalam praktik kebidanan layanan primer membuka peluang pengembangan layanan yang lebih efisien, terjangkau, dan terdokumentasi dengan baik. Pemanfaatan teknologi ini dapat mendukung kesinambungan asuhan kebidanan dan pemantauan klien secara berkelanjutan. (Herawati, 2024). Dengan arah penguatan tersebut, bidan diharapkan mampu menjadi penggerak utama layanan kesehatan primer yang tidak hanya responsif terhadap masalah kesehatan saat ini, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan kesehatan perempuan dan keluarga secara berkelanjutan. (Trisnantoro, 2018).

Kondisi sosial budaya masyarakat juga menjadi tantangan tersendiri dalam praktik kebidanan di layanan primer karena nilai, kepercayaan, dan norma tertentu dapat memengaruhi penerimaan klien terhadap pelayanan kesehatan. Bidan dituntut memiliki kemampuan komunikasi dan pendekatan budaya yang sensitif agar asuhan kebidanan dapat diterima secara optimal. (Allender, Rector, & Warner, 2014). Di sisi lain, penguatan layanan primer membuka peluang besar bagi bidan untuk mengoptimalkan peran profesionalnya melalui perluasan cakupan praktik kebidanan berbasis komunitas dan keluarga. Peluang ini memungkinkan bidan berkontribusi lebih luas dalam upaya promotif dan preventif yang berdampak langsung pada peningkatan derajat kesehatan masyarakat. (Homer et al., 2014).

Implementasi kebijakan ILP memberikan peluang bagi bidan untuk memperkuat kesinambungan asuhan kebidanan melalui pendekatan siklus hidup, Posyandu, dan kunjungan rumah. Pendekatan ini mendukung bidan dalam membangun hubungan jangka panjang dengan klien dan keluarga. (Sandall et al., 2016). Pengembangan kompetensi bidan melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan menjadi peluang strategis dalam meningkatkan mutu layanan primer. Peningkatan kompetensi tersebut mendukung bidan dalam menerapkan praktik kebidanan berbasis bukti dan responsif terhadap kebutuhan klien. (Homer et al., 2014).

Pemanfaatan sistem informasi kesehatan dan pencatatan program juga membuka peluang bagi bidan untuk berperan dalam penguatan tata kelola layanan primer melalui pengambilan keputusan berbasis data. Peran ini memperkuat posisi bidan dalam sistem pelayanan kesehatan tingkat pertama. (Trisnantoro, 2018). Dengan mengelola tantangan secara adaptif dan memanfaatkan peluang yang ada, bidan dapat menjadi penggerak utama dalam penguatan Puskesmas dan layanan

kesehatan primer yang berorientasi pada kebutuhan klien, keluarga, dan komunitas. (Notoatmodjo, 2014).

I. Simpulan

Penguatan Puskesmas dan layanan kesehatan primer merupakan strategi fundamental dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat karena layanan primer menjadi titik kontak awal, paling dekat, dan paling berkelanjutan bagi individu, keluarga, dan komunitas. Dalam konteks tersebut, bidan memiliki peran yang sangat strategis karena praktik kebidanan secara langsung menyentuh kebutuhan kesehatan perempuan, ibu, bayi, dan keluarga sepanjang siklus kehidupan. Peran bidan dalam layanan primer tidak hanya terbatas pada pemberian asuhan kebidanan secara klinis kepada klien, tetapi juga mencakup peran yang lebih luas pada level sistem dan program Puskesmas. Peran operasional bidan terhadap klien melalui pendekatan asuhan kebidanan yang berpusat pada klien dan berkesinambungan menjadi fondasi utama dalam mewujudkan layanan primer yang responsif dan bermutu. Pada level sistem dan program, bidan berkontribusi penting dalam penguatan fungsi Puskesmas berbasis wilayah melalui keterlibatan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program kesehatan ibu, anak, remaja, dan keluarga berencana. Keterlibatan ini memastikan bahwa kebijakan dan program layanan primer dapat diterjemahkan secara kontekstual sesuai dengan kebutuhan kesehatan masyarakat di wilayah kerja.

Implementasi Integrasi Layanan Primer (ILP) mempertegas posisi bidan sebagai pelaksana utama layanan kesehatan berbasis siklus hidup melalui penguatan Posyandu, pelaksanaan kunjungan rumah, serta pendampingan berkelanjutan terhadap klien dan keluarga. Pendekatan ini memungkinkan bidan menjalankan fungsi promotif dan preventif secara lebih optimal sekaligus menjaga kesinambungan asuhan kebidanan. Tantangan yang dihadapi bidan dalam penguatan layanan primer, seperti beban kerja, keterbatasan sumber daya, adaptasi terhadap kebijakan baru, serta dinamika sosial budaya masyarakat, perlu dikelola secara adaptif melalui penguatan kapasitas, dukungan sistem, dan kolaborasi lintas sektor. Di sisi lain, kebijakan penguatan layanan primer membuka peluang bagi bidan untuk mengembangkan praktik kebidanan berbasis komunitas yang lebih luas dan bermakna. Dengan demikian, penguatan Puskesmas dan layanan kesehatan primer sangat bergantung pada optimalisasi peran bidan sebagai pemberi asuhan kebidanan, pendamping kesehatan perempuan dan keluarga, serta penggerak upaya promotif dan preventif di tingkat komunitas. Penguatan peran bidan secara berkelanjutan menjadi kunci dalam mewujudkan layanan kesehatan primer yang berorientasi pada kebutuhan klien, bermutu, dan berkelanjutan.

J. Referensi

- Allender, J. A., Rector, C., & Warner, K. D. (2014). *Community & Public Health Nursing: Promoting the Public's Health*. Philadelphia: Wolters Kluwer Health.
- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. (2020). *Pedoman Pelayanan Keluarga Berencana di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama*. Jakarta: BKKBN.
- BPJS Kesehatan. (2019). *Petunjuk Teknis Pembayaran Kapitasi Berbasis Kinerja*. Jakarta: BPJS Kesehatan.
- Herawati, L. (2024). *Manajemen Mutu Pelayanan Kesehatan Primer*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Homer, C. S. E., Brodie, P. M., & Leap, N. (2014). *Midwifery Continuity of Care: A Practical Guide*. Sydney: Allen & Unwin.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat*. Jakarta: Kemenkes RI.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2023a). *Transformasi Sistem Kesehatan: Pilar Transformasi Layanan Primer*. Jakarta: Kemenkes RI.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2023b). *Kebijakan Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer*. Jakarta: Kemenkes RI.
- Munawaroh, S. (2021). *Promosi Kesehatan Reproduksi Remaja*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Notoatmodjo, S. (2014). *Promosi Kesehatan dan Perilaku Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sandall, J., Soltani, H., Gates, S., Shennan, A., & Devane, D. (2016). Midwife-led continuity models versus other models of care for childbearing women. *Cochrane Database of Systematic Reviews*, (4).
- Stanhope, M., & Lancaster, J. (2020). *Public Health Nursing: Population-Centered Health Care in the Community*. St. Louis: Elsevier.
- Starfield, B. (2011). Primary care: An increasingly important contributor to effectiveness, equity, and efficiency of health services. *Milbank Quarterly*, 89(3), 457–502.
- Trisnantoro, L. (2018). *Memahami Penggunaan Ilmu Ekonomi dalam Manajemen Rumah Sakit*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- World Health Organization. (2018). *Continuity of Care for Maternal, Newborn and Child Health*. Geneva: WHO.

K. Glosarium

1. Asuhan Kebidanan : Pelayanan profesional yang diberikan oleh bidan kepada perempuan, ibu, bayi, dan keluarga yang mencakup upaya promotif, preventif, kuratif terbatas, dan rehabilitatif sesuai kewenangan, dengan pendekatan berpusat pada klien dan berkesinambungan.
2. Bidan : Tenaga kesehatan profesional yang memiliki kompetensi dan kewenangan dalam memberikan pelayanan kebidanan kepada perempuan sepanjang siklus kehidupan, termasuk pelayanan kesehatan ibu dan anak, kesehatan reproduksi, dan keluarga berencana.
3. Continuity of Care : Pendekatan pelayanan kebidanan yang menekankan kesinambungan asuhan sejak masa remaja, prakonsepsi, kehamilan, persalinan, nifas, bayi baru lahir, hingga keluarga berencana.
4. Integrasi Layanan Primer (ILP) : Pendekatan kebijakan pelayanan kesehatan yang mengintegrasikan layanan klinis, promotif, dan preventif berbasis siklus hidup melalui Puskesmas dan jejaringnya untuk meningkatkan akses, mutu, dan kesinambungan pelayanan kesehatan.
5. Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) : Upaya pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk meningkatkan derajat kesehatan ibu, bayi, dan anak melalui pelayanan promotif, preventif, dan pelayanan dasar kebidanan.
6. Kesehatan Reproduksi : Keadaan sehat secara fisik, mental, dan sosial yang berkaitan dengan sistem, fungsi, dan proses reproduksi pada perempuan dan laki-laki sepanjang siklus kehidupan.
7. Kunjungan Rumah : Kegiatan pelayanan kesehatan yang dilakukan bidan ke rumah klien untuk pemantauan kondisi kesehatan, pemberian edukasi, serta tindak lanjut pelayanan kebidanan, terutama pada kelompok berisiko.
8. Layanan Kesehatan Primer : Pelayanan kesehatan tingkat pertama yang bersifat esensial, komprehensif, berkesinambungan, dan berorientasi pada kebutuhan individu, keluarga, dan komunitas.
9. Pelayanan Berbasis Siklus Hidup : Pendekatan pelayanan kesehatan yang disesuaikan dengan tahapan kehidupan individu, mulai dari remaja, prakonsepsi, kehamilan, persalinan, nifas, bayi, hingga keluarga berencana.
10. Pemberdayaan Masyarakat : Proses meningkatkan kemampuan individu, keluarga, dan komunitas untuk mengenali, mencegah, dan mengatasi masalah kesehatan secara mandiri dan berkelanjutan.

11. Posyandu : Upaya kesehatan berbasis masyarakat yang berfungsi sebagai wahana pelayanan kesehatan dasar, promosi kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat dalam mendukung layanan kesehatan primer.
12. Promotif dan Preventif : Upaya kesehatan yang bertujuan meningkatkan derajat kesehatan dan mencegah terjadinya penyakit melalui edukasi, perubahan perilaku, dan intervensi dini.
13. Puskesmas : Fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan berbasis wilayah kerja.
14. Siklus Kehidupan Perempuan : Tahapan kehidupan perempuan yang meliputi masa remaja, praonsepsi, kehamilan, persalinan, nifas, dan masa reproduksi lanjut, yang menjadi fokus pelayanan kebidanan.
15. Woman-Centered Care : Pendekatan pelayanan kebidanan yang menempatkan perempuan sebagai pusat asuhan dengan menghormati pilihan, kebutuhan, nilai, dan konteks sosial budaya klien.

CHAPTER 3

UPAYA PROMOTIF DAN PREVENTIF DI TINGKAT PELAYANAN KESEHATAN PRIMER

Bdn. Rizka Amalia, SST., M.Kes

A. Pendahuluan

Pelayanan kesehatan primer memegang peranan strategis dalam peningkatan derajat kesehatan ibu, bayi, dan keluarga. Sistem kesehatan global menempatkan pelayanan primer sebagai kunci pencapaian *Universal Health Coverage* (UHC) serta penurunan angka kematian ibu dan bayi secara berkelanjutan (*World Health Organization* [WHO], 2023). Konteks kebidanan memperlihatkan bahwa sebagian besar determinan kematian maternal dan neonatal dapat dicegah melalui intervensi promotif dan preventif yang dilakukan sejak masa prakonsepsi hingga periode nifas.

Angka kematian ibu masih menjadi indikator sensitif dalam mengukur kualitas sistem kesehatan. Laporan *Trends in Maternal Mortality* menunjukkan bahwa komplikasi hipertensi dalam kehamilan, perdarahan postpartum, infeksi, serta penyakit tidak menular yang tidak terkontrol menjadi penyebab utama kematian maternal global (WHO, 2023). Kondisi Indonesia menunjukkan tantangan serupa dengan peningkatan faktor risiko seperti anemia pada remaja putri, kehamilan usia terlalu muda atau terlalu tua, serta tingginya prevalensi penyakit penyerta pada ibu hamil (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2023).

Ilmu kebidanan modern menekankan pendekatan *continuity of midwifery care* sebagai strategi efektif dalam menurunkan intervensi medis yang tidak perlu dan meningkatkan outcome maternal-neonatal (Sandall et al., 2022). Model ini berbasis bukti dan menempatkan bidan sebagai penyedia layanan primer yang memberikan asuhan komprehensif sejak prakonsepsi, antenatal, intrapartum, hingga postnatal. Pendekatan tersebut selaras dengan konsep promotif dan preventif dalam pelayanan kesehatan primer.

Fenomena peningkatan kehamilan risiko tinggi akibat obesitas, diabetes gestasional, hipertensi kronis, serta gangguan kesehatan mental perinatal menunjukkan perlunya skrining dan edukasi berbasis evidence sejak tahap awal (International Confederation of Midwives [ICM], 2023). Gangguan kesehatan mental seperti depresi postpartum dan kecemasan antenatal mengalami peningkatan signifikan pascapandemi COVID-19 (WHO, 2022). Peran bidan dalam deteksi dini dan konseling preventif menjadi bagian integral dari pelayanan primer kebidanan.

Pendekatan *evidence-based midwifery* mengintegrasikan hasil penelitian ilmiah terbaru, pengalaman klinis profesional, serta nilai dan preferensi perempuan dalam pengambilan keputusan klinis (Renfrew et al., 2021). Implementasi praktik berbasis bukti terbukti menurunkan angka intervensi yang tidak perlu, meningkatkan pengalaman persalinan positif, serta mengurangi morbiditas maternal. Model ini memperkuat argumentasi bahwa penguatan promotif dan preventif dalam kebidanan bukan sekadar pendekatan teoritis, melainkan kebutuhan sistemik berbasis bukti ilmiah.

Periode 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) menjadi fokus utama dalam intervensi kebidanan preventif. Kekurangan zat besi pada remaja putri, anemia dalam kehamilan, serta praktik pemberian makan bayi yang tidak optimal berkontribusi terhadap stunting dan gangguan perkembangan anak (UNICEF, 2023). Intervensi promotif berupa edukasi gizi prakonsepsi dan konseling menyusui eksklusif terbukti efektif dalam mencegah dampak jangka panjang terhadap kualitas sumber daya manusia.

Transformasi digital kesehatan menghadirkan inovasi dalam praktik kebidanan. Penggunaan aplikasi pemantauan kehamilan, telemidwifery, serta sistem rekam medis elektronik meningkatkan akses dan kontinuitas pelayanan (WHO, 2023). Studi terbaru menunjukkan bahwa intervensi mHealth dalam pengingat kunjungan antenatal dan edukasi kontrasepsi meningkatkan kepatuhan ibu terhadap layanan kesehatan (Johnson et al., 2022). Pengembangan ini memperluas peran bidan dalam promosi kesehatan berbasis teknologi.

Beban pembiayaan kesehatan maternal yang tinggi akibat komplikasi kehamilan memperlihatkan pentingnya investasi pada intervensi preventif. Analisis ekonomi kesehatan menunjukkan bahwa setiap dolar yang diinvestasikan dalam pencegahan komplikasi kehamilan menghasilkan penghematan biaya sistem kesehatan jangka panjang (World Bank, 2022). Strategi promotif dan preventif dalam kebidanan memiliki dampak ganda terhadap kesehatan ibu dan generasi berikutnya.

Penguatan upaya promotif dan preventif dalam pelayanan kesehatan primer berbasis kebidanan menjadi urgensi dalam transformasi kesehatan nasional. Pendekatan berbasis bukti, digitalisasi layanan, serta model continuity of care harus diintegrasikan dalam sistem pelayanan primer untuk menurunkan angka kematian maternal dan neonatal secara berkelanjutan.

Bab ini membahas secara komprehensif strategi promotif dan preventif di tingkat pelayanan kesehatan primer dengan perspektif kebidanan berbasis *evidence-based practice*. Pembahasan menyesuaikan perkembangan ilmu kebidanan terkini, fenomena kesehatan maternal global, serta arah pembaharuan sistem kesehatan Indonesia.

B. Landasan Teoretis Pelayanan Kesehatan Primer dalam Perspektif Kebidanan

Pelayanan kesehatan primer dalam perspektif kebidanan berakar pada filosofi asuhan kebidanan yang menempatkan perempuan sebagai pusat pelayanan (*woman-centered care*). Filosofi ini menekankan penghormatan terhadap hak reproduksi, otonomi perempuan dalam pengambilan keputusan, serta kesinambungan asuhan sepanjang siklus reproduksi (*International Confederation of Midwives* [ICM], 2023). Pendekatan tersebut selaras dengan prinsip *Primary Health Care* (PHC) yang berorientasi pada akses universal, pemberdayaan masyarakat, dan pencegahan penyakit sejak dini (World Health Organization [WHO], 2023).

Konsep pelayanan kesehatan primer menempatkan bidan sebagai tenaga kesehatan lini terdepan dalam sistem pelayanan maternal dan neonatal. Peran bidan tidak terbatas pada pertolongan persalinan, melainkan mencakup promosi kesehatan prakonsepsi, deteksi dini faktor risiko kehamilan, manajemen komplikasi ringan, konseling laktasi, serta pelayanan keluarga berencana berbasis bukti (Renfrew et al., 2021). Model ini memperlihatkan integrasi kuat antara promotif dan preventif dalam praktik kebidanan sehari-hari.

Teori *life-course approach* memberikan dasar konseptual penting dalam pelayanan primer kebidanan. Pendekatan ini menekankan bahwa kesehatan ibu dan anak dipengaruhi oleh paparan risiko sejak masa remaja, prakonsepsi, kehamilan, hingga pascapersalinan (United Nations, 2022). Anemia pada remaja putri, kekurangan energi kronis, serta paparan perilaku berisiko menjadi determinan penting terhadap outcome kehamilan di masa depan. Intervensi promotif dan preventif dalam kebidanan harus dimulai sebelum terjadinya konsepsi.

Model *continuity of midwifery care* menjadi salah satu landasan teoretis yang kuat dalam pelayanan primer kebidanan. Model ini memberikan asuhan berkelanjutan oleh bidan yang sama atau tim kecil bidan sejak awal kehamilan hingga periode postpartum. Bukti sistematis menunjukkan bahwa model *continuity of care* menurunkan risiko persalinan prematur, meningkatkan kepuasan ibu, serta mengurangi intervensi obstetrik yang tidak perlu (Sandall et al., 2022). Prinsip kesinambungan ini memperkuat integrasi promotif, preventif, dan kuratif dalam satu rangkaian pelayanan.

Teori determinan sosial kesehatan juga menjadi kerangka penting dalam pelayanan primer kebidanan. Status sosial ekonomi, pendidikan ibu, akses terhadap layanan kesehatan, serta norma budaya memengaruhi risiko komplikasi maternal dan neonatal (WHO, 2023). Bidan dalam pelayanan primer memiliki tanggung jawab melakukan asesmen komprehensif terhadap faktor sosial dan lingkungan yang dapat memengaruhi kehamilan dan persalinan.

Pendekatan *evidence-based midwifery* memperkuat landasan teoretis pelayanan primer kebidanan. Praktik berbasis bukti mengintegrasikan hasil penelitian ilmiah terbaru, pengalaman klinis profesional, serta preferensi perempuan dalam pengambilan keputusan klinis (Renfrew et al., 2021). Implementasi praktik berbasis bukti dalam pelayanan primer meliputi skrining preeklamsia berbasis faktor risiko, suplementasi zat besi dan asam folat sesuai rekomendasi terbaru, serta manajemen aktif kala III untuk mencegah perdarahan postpartum.

Kerangka teori pencegahan primer, sekunder, dan tersier juga relevan dalam praktik kebidanan. Pencegahan primer dalam kebidanan mencakup edukasi kesehatan reproduksi remaja, konseling prakonsepsi, imunisasi tetanus toksoid, serta suplementasi gizi ibu hamil. Pencegahan sekunder meliputi skrining anemia, hipertensi dalam kehamilan, diabetes gestasional, serta deteksi dini gangguan pertumbuhan janin. Pencegahan tersier berfokus pada manajemen komplikasi untuk mencegah kecacatan atau kematian maternal-neonatal.

Transformasi pelayanan kesehatan primer menekankan integrasi teknologi digital dalam praktik kebidanan. Konsep *digital health* dalam kebidanan mencakup telemidwifery, sistem pengingat kunjungan antenatal, serta pemantauan jarak jauh tekanan darah ibu hamil risiko tinggi (WHO, 2023). Pendekatan ini memperluas jangkauan promotif dan preventif terutama pada wilayah dengan keterbatasan akses geografis.

Kerangka pelayanan kebidanan berbasis komunitas menjadi bagian integral dari teori pelayanan primer. Keterlibatan kader kesehatan, kelompok ibu hamil, serta dukungan keluarga meningkatkan efektivitas edukasi dan deteksi dini komplikasi (UNICEF, 2023). Model *community-based midwifery* memperlihatkan dampak signifikan terhadap peningkatan cakupan kunjungan antenatal dan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih.

Perspektif kebidanan modern mengakui bahwa kesehatan ibu dan bayi merupakan investasi jangka panjang bagi pembangunan sumber daya manusia. Intervensi promotif dan preventif dalam pelayanan primer kebidanan tidak hanya berdampak pada penurunan mortalitas, tetapi juga pada kualitas generasi mendatang melalui pencegahan stunting, gangguan perkembangan, dan penyakit kronis sejak dini.

Landasan teoretis pelayanan kesehatan primer dalam perspektif kebidanan memperlihatkan integrasi antara filosofi *woman-centered care*, *continuity of care*, *life-course approach*, determinan sosial kesehatan, serta praktik berbasis bukti. Kerangka ini menjadi dasar dalam merancang strategi promotif dan preventif yang komprehensif, adaptif terhadap perkembangan ilmu kebidanan, serta responsif terhadap fenomena kesehatan maternal terkini.

C. Konsep Promotif dan Preventif dalam Praktik Kebidanan Primer

Praktik kebidanan primer berorientasi pada pencegahan risiko dan peningkatan kapasitas perempuan dalam menjaga kesehatan reproduksi sepanjang siklus kehidupannya. Konsep promotif dalam kebidanan tidak hanya berfokus pada penyampaian informasi, tetapi juga pada pemberdayaan perempuan agar mampu mengambil keputusan berbasis pengetahuan dan bukti ilmiah terkini (*International Confederation of Midwives* [ICM], 2023). Pendekatan ini selaras dengan filosofi woman-centered care yang menghargai otonomi, nilai, dan preferensi perempuan dalam setiap tahap pelayanan.

Promosi kesehatan dalam kebidanan dimulai sejak masa remaja melalui edukasi kesehatan reproduksi yang komprehensif. Anemia pada remaja putri, pernikahan usia dini, serta kurangnya literasi kontrasepsi menjadi determinan penting terhadap risiko komplikasi kehamilan di masa depan (UNICEF, 2023). Edukasi berbasis sekolah dan komunitas yang dilakukan oleh bidan terbukti meningkatkan pemahaman remaja mengenai kesehatan reproduksi dan perencanaan kehamilan (WHO, 2023). Intervensi promotif pada fase ini merupakan investasi jangka panjang terhadap kualitas kehamilan dan persalinan di kemudian hari.

Masa prakonsepsi menjadi fase krusial dalam konsep promotif kebidanan primer. Konseling pranikah, suplementasi asam folat, pengendalian penyakit kronis, serta optimalisasi status gizi merupakan bagian integral dari pencegahan primer (Renfrew et al., 2021). Bukti ilmiah menunjukkan bahwa intervensi prakonsepsi menurunkan risiko cacat tabung saraf, preeklamsia, serta komplikasi obstetri lainnya. Bidan memiliki peran strategis dalam melakukan asesmen risiko sejak sebelum kehamilan terjadi.

Praktik promotif dalam antenatal care (ANC) mencakup edukasi mengenai tanda bahaya kehamilan, persiapan persalinan, manajemen stres, serta perencanaan menyusui. Konseling berbasis bukti tentang nutrisi, aktivitas fisik aman selama kehamilan, serta pencegahan infeksi meningkatkan outcome maternal dan neonatal (WHO, 2023). Penguatan literasi kesehatan ibu hamil berkontribusi terhadap peningkatan kepatuhan kunjungan ANC dan deteksi dini komplikasi.

Konsep preventif dalam kebidanan primer melibatkan pencegahan primer, sekunder, dan tersier yang terintegrasi. Pencegahan primer mencakup imunisasi tetanus toksoid, suplementasi zat besi dan asam folat, serta konseling kontrasepsi untuk mencegah kehamilan risiko tinggi. Pencegahan sekunder berfokus pada skrining anemia, hipertensi dalam kehamilan, diabetes gestasional, serta deteksi dini gangguan pertumbuhan janin melalui pemantauan teratur (WHO, 2023).

Pencegahan tersier dilakukan melalui manajemen komplikasi secara cepat dan tepat guna mencegah morbiditas dan mortalitas maternal.

Pendekatan *evidence-based practice* memperkuat implementasi preventif dalam kebidanan primer. Skrining preeklamsia berbasis faktor risiko, penggunaan partograf dalam pemantauan persalinan, serta manajemen aktif kala III untuk mencegah perdarahan postpartum merupakan praktik yang direkomendasikan berdasarkan bukti ilmiah terbaru (Sandall et al., 2022). Implementasi praktik berbasis bukti terbukti menurunkan komplikasi obstetri dan meningkatkan keselamatan ibu serta bayi.

Asuhan nifas dan neonatal juga merupakan bagian integral dari konsep promotif dan preventif. Edukasi menyusui eksklusif, perawatan tali pusat bersih, deteksi dini infeksi neonatal, serta skrining depresi postpartum menjadi intervensi penting dalam pelayanan primer kebidanan (WHO, 2022). Periode postpartum sering kali kurang mendapatkan perhatian optimal, padahal fase ini memiliki risiko tinggi terhadap komplikasi fisik dan psikologis.

Pendekatan keluarga dalam praktik kebidanan primer memperkuat efektivitas promosi dan pencegahan. Dukungan suami dan keluarga berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan pemberian ASI eksklusif dan kepatuhan penggunaan kontrasepsi pascapersalinan (UNICEF, 2023). Keterlibatan keluarga dalam konseling reproduksi meningkatkan keberlanjutan perilaku sehat.

Integrasi teknologi digital memperluas jangkauan promotif dan preventif dalam kebidanan primer. Aplikasi pemantauan kehamilan, pengingat jadwal imunisasi, serta telekonsultasi kebidanan meningkatkan akses pelayanan terutama di wilayah terpencil (WHO, 2023). Studi terbaru menunjukkan bahwa penggunaan mHealth dalam edukasi antenatal meningkatkan kepatuhan ibu terhadap kunjungan dan konsumsi suplementasi zat besi (Johnson et al., 2022). Transformasi digital memperkuat peran bidan sebagai educator sekaligus koordinator layanan berbasis komunitas.

Konsep promotif dan preventif dalam praktik kebidanan primer menempatkan bidan sebagai agen perubahan dalam sistem kesehatan. Peran tersebut mencakup edukator, konselor, advokat kesehatan perempuan, serta penyedia asuhan berbasis bukti. Integrasi promotif dan preventif sepanjang siklus reproduksi perempuan menjadi strategi utama dalam menurunkan angka kematian maternal dan neonatal secara berkelanjutan.

D. Strategi Promotif di Pelayanan Primer dalam Perspektif Kebidanan

Strategi promotif di pelayanan kesehatan primer dalam konteks kebidanan berfokus pada peningkatan kapasitas perempuan, keluarga, dan komunitas dalam menjaga kesehatan reproduksi secara mandiri dan berkelanjutan. Orientasi promotif tidak hanya menitikberatkan pada transfer informasi, tetapi pada perubahan perilaku berbasis literasi kesehatan dan pemberdayaan sosial (Nutbeam, 2022). Praktik kebidanan primer menjadi ruang strategis untuk mengintegrasikan promosi kesehatan sejak fase remaja hingga masa menopause.

Edukasi kesehatan reproduksi berbasis siklus kehidupan menjadi strategi utama. Intervensi pada remaja putri mencakup pencegahan anemia, pemahaman siklus menstruasi, kesehatan seksual yang aman, serta perencanaan kehamilan. Prevalensi anemia remaja perempuan di Asia Tenggara masih berada pada kategori masalah kesehatan masyarakat sedang hingga berat (WHO, 2023). Edukasi gizi dan suplementasi zat besi yang dilakukan oleh bidan melalui sekolah dan posyandu remaja meningkatkan status hemoglobin dan kesiapan reproduksi di masa depan.

Konseling prakonsepsi merupakan strategi promotif yang semakin berkembang dalam praktik kebidanan berbasis bukti. Perempuan usia subur dengan penyakit kronis seperti hipertensi, diabetes, atau obesitas memiliki risiko komplikasi kehamilan yang lebih tinggi (Renfrew et al., 2021). Edukasi prakonsepsi mengenai pengendalian berat badan, penghentian merokok, pengaturan penyakit kronis, serta suplementasi asam folat berkontribusi terhadap penurunan risiko preeklamsia dan kelainan kongenital. Strategi ini memperluas cakupan pelayanan kebidanan primer dari fase antenatal menjadi prakonsepsi.

Pelaksanaan kelas ibu hamil berbasis komunitas menjadi bentuk konkret promosi kesehatan maternal. Kegiatan ini mencakup edukasi tanda bahaya kehamilan, persiapan persalinan, manajemen nyeri nonfarmakologis, serta praktik menyusui dini. Bukti sistematis menunjukkan bahwa partisipasi dalam kelas antenatal meningkatkan kesiapan persalinan dan menurunkan kecemasan ibu (WHO, 2023). Model ini memperkuat pendekatan promotif yang bersifat partisipatif dan dialogis.

Promosi kesehatan menyusui eksklusif merupakan prioritas dalam pelayanan primer kebidanan. Cakupan menyusui eksklusif global masih belum mencapai target 50% (UNICEF, 2023). Edukasi laktasi sejak masa antenatal, inisiasi menyusui dini, serta dukungan konseling pascapersalinan meningkatkan keberhasilan pemberian ASI. Praktik berbasis bukti menunjukkan bahwa dukungan berkelanjutan oleh bidan menurunkan risiko penghentian dini menyusui.

Strategi promotif juga mencakup advokasi kesehatan reproduksi berbasis keluarga. Keterlibatan suami dalam konseling antenatal dan keluarga berencana meningkatkan pengambilan keputusan bersama dan keberlanjutan perilaku sehat (ICM, 2023). Model family-centered care memperkuat peran keluarga sebagai sistem pendukung utama kesehatan ibu.

Pendekatan berbasis komunitas memperluas jangkauan promosi kesehatan. Posyandu, kelompok ibu balita, dan kader kesehatan menjadi mitra bidan dalam menyampaikan pesan promotif. Pelibatan tokoh masyarakat dan pemimpin lokal meningkatkan penerimaan pesan kesehatan terutama pada komunitas dengan norma budaya kuat. Strategi ini efektif dalam meningkatkan cakupan kunjungan antenatal dan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih (WHO, 2023).

Literasi kesehatan digital menjadi dimensi baru dalam strategi promotif kebidanan primer. Penggunaan media sosial, aplikasi kehamilan, serta platform edukasi daring meningkatkan akses informasi kesehatan reproduksi. Studi terbaru menunjukkan bahwa intervensi mHealth dalam edukasi antenatal meningkatkan kepatuhan kunjungan dan konsumsi suplementasi zat besi (Johnson et al., 2022). Pemanfaatan teknologi memperluas peran bidan sebagai educator berbasis digital.

Promosi kesehatan mental perinatal menjadi isu penting dalam kebidanan modern. Prevalensi depresi antenatal dan postpartum meningkat setelah pandemi COVID-19 (WHO, 2022). Skrining dini gangguan psikologis serta edukasi coping mechanism menjadi bagian dari strategi promotif untuk mencegah dampak jangka panjang terhadap ibu dan bayi. Pendekatan holistik dalam kebidanan mengintegrasikan aspek fisik, psikologis, dan sosial.

Strategi promotif di pelayanan primer kebidanan tidak terlepas dari pendekatan determinan sosial kesehatan. Kemiskinan, pendidikan rendah, serta akses terbatas terhadap layanan kesehatan memengaruhi outcome maternal. Intervensi promotif harus mempertimbangkan konteks sosial dan budaya agar lebih efektif dan berkelanjutan (WHO, 2023).

Implementasi strategi promotif dalam kebidanan primer memperlihatkan bahwa investasi pada edukasi dan pemberdayaan perempuan memberikan dampak signifikan terhadap penurunan risiko komplikasi. Penguatan kapasitas bidan dalam komunikasi efektif, konseling berbasis bukti, serta pemanfaatan teknologi menjadi prasyarat keberhasilan strategi promotif di era transformasi kesehatan.

E. Strategi Preventif (Primer–Sekunder–Tersier) dalam Pelayanan Kebidanan Primer

Strategi preventif dalam pelayanan kebidanan primer berorientasi pada pencegahan risiko maternal dan neonatal sejak sebelum konsepsi hingga periode pascapersalinan. Pendekatan ini berbasis evidence-based midwifery yang menekankan deteksi dini, intervensi tepat waktu, serta kesinambungan asuhan untuk menurunkan morbiditas dan mortalitas ibu dan bayi (World Health Organization [WHO], 2023). Integrasi pencegahan primer, sekunder, dan tersier menjadi kerangka sistematis dalam praktik kebidanan modern.

1. Pencegahan Primer dalam Kebidanan Primer

Pencegahan primer bertujuan mencegah terjadinya komplikasi sebelum kehamilan atau selama masa gestasi awal. Konseling prakonsepsi menjadi intervensi kunci dalam fase ini. Perempuan dengan penyakit kronis seperti hipertensi, diabetes, gangguan tiroid, atau obesitas memiliki risiko lebih tinggi terhadap preeklamsia, persalinan prematur, serta kematian maternal (Renfrew et al., 2021). Optimalisasi kondisi kesehatan sebelum konsepsi menurunkan risiko komplikasi kehamilan secara signifikan.

Suplementasi asam folat sebelum dan selama trimester pertama terbukti menurunkan risiko cacat tabung saraf (WHO, 2023). Program suplementasi zat besi pada remaja putri dan ibu hamil mencegah anemia yang berkontribusi terhadap perdarahan postpartum dan berat badan lahir rendah. Anemia maternal masih menjadi faktor risiko utama kematian ibu di negara berkembang (UNICEF, 2023).

Imunisasi tetanus toksoid dan vaksinasi tambahan sesuai rekomendasi nasional merupakan bagian dari pencegahan primer dalam kebidanan. Pencegahan infeksi melalui edukasi kebersihan diri dan sanitasi juga menjadi strategi fundamental dalam pelayanan primer.

Pelayanan keluarga berencana termasuk dalam pencegahan primer kebidanan. Pengaturan jarak kehamilan minimal 24 bulan menurunkan risiko kematian neonatal dan komplikasi obstetri (WHO, 2023). Konseling kontrasepsi berbasis bukti dan penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) memberikan perlindungan optimal terhadap kehamilan risiko tinggi.

2. Pencegahan Sekunder dalam Kebidanan Primer

Pencegahan sekunder berfokus pada deteksi dini komplikasi untuk mencegah progresivitas penyakit. Skrining anemia melalui pemeriksaan hemoglobin, deteksi hipertensi melalui pemantauan tekanan darah rutin, serta

skrining diabetes gestasional menjadi bagian integral antenatal care berbasis standar (WHO, 2023).

Skrining preeklamsia menggunakan kombinasi faktor risiko klinis dan pemeriksaan laboratorium awal terbukti meningkatkan deteksi dini kondisi tersebut (ICM, 2023). Pemberian aspirin dosis rendah pada ibu berisiko tinggi sesuai rekomendasi terbaru menurunkan kejadian preeklamsia berat.

Pemantauan pertumbuhan janin melalui pengukuran tinggi fundus uteri dan ultrasonografi sesuai indikasi mendukung deteksi gangguan pertumbuhan intrauterin. Deteksi dini memungkinkan rujukan tepat waktu ke fasilitas kesehatan rujukan.

Skrining kesehatan mental perinatal merupakan komponen preventif sekunder yang semakin mendapat perhatian. Depresi antenatal dan postpartum berdampak terhadap bonding ibu-bayi serta perkembangan anak (WHO, 2022). Penggunaan instrumen skrining sederhana dalam pelayanan primer memungkinkan identifikasi dini gangguan psikologis.

3. Pencegahan Tersier dalam Kebidanan Primer

Pencegahan tersier bertujuan mencegah komplikasi lanjutan dan kecacatan setelah kondisi patologis teridentifikasi. Manajemen aktif kala III untuk mencegah perdarahan postpartum merupakan praktik berbasis bukti yang menurunkan risiko kematian maternal (WHO, 2023). Pemberian uterotonika segera setelah persalinan menjadi standar praktik global.

Penatalaksanaan hipertensi dalam kehamilan secara tepat waktu mencegah eklampsia dan komplikasi serebrovaskular. Rujukan cepat pada kasus kegawatdaruratan obstetri merupakan bagian dari sistem pencegahan tersier yang efektif.

Perawatan neonatal esensial seperti inisiasi menyusui dini, pencegahan hipotermia, serta deteksi dini infeksi neonatal mencegah komplikasi serius pada bayi baru lahir. Pendekatan ini terbukti menurunkan angka kematian neonatal secara signifikan (UNICEF, 2023).

Asuhan nifas komprehensif juga termasuk dalam pencegahan tersier. Konseling kontrasepsi pascapersalinan mencegah kehamilan berulang yang terlalu cepat. Skrining komplikasi pascapersalinan seperti infeksi atau depresi postpartum memastikan keberlanjutan kesehatan ibu.

Tabel 3.1
Spektrum Pencegahan dalam Pelayanan Kebidanan Primer

Tingkat Pencegahan	Fokus Intervensi	Contoh Implementasi Kebidanan
Primer	Mencegah komplikasi	Konseling prakonsepsi, imunisasi, suplementasi Fe
Sekunder	Deteksi dini	Skrining anemia, hipertensi, GDM
Tersier	Mencegah dampak lanjutan	Manajemen PPH, rujukan kegawatdaruratan

Strategi preventif dalam pelayanan kebidanan primer memperlihatkan bahwa sebagian besar komplikasi maternal dan neonatal dapat dicegah melalui intervensi berbasis bukti yang dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan. Integrasi pencegahan primer, sekunder, dan tersier dalam satu rangkaian asuhan memperkuat peran bidan sebagai garda terdepan dalam sistem kesehatan primer.

F. Implementasi di Indonesia dalam Perspektif Kebidanan Primer

Implementasi pelayanan kebidanan primer di Indonesia mengalami transformasi signifikan dalam satu dekade terakhir. Reformasi sistem kesehatan nasional menempatkan pelayanan primer sebagai pilar utama melalui transformasi layanan primer, transformasi sistem rujukan, serta penguatan sumber daya manusia kesehatan (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2023). Posisi bidan dalam struktur pelayanan kesehatan primer menjadi sangat strategis karena sebagian besar kontak pertama perempuan dengan sistem kesehatan terjadi melalui praktik kebidanan di Puskesmas, klinik pratama, maupun praktik mandiri bidan.

Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK) memperluas cakupan pelayanan berbasis rumah tangga. Pendekatan ini memungkinkan bidan melakukan identifikasi faktor risiko kesehatan ibu dan anak secara langsung di tingkat keluarga. Indikator keluarga sehat mencakup keikutsertaan keluarga berencana, kepatuhan kunjungan antenatal, serta cakupan imunisasi lengkap (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2023). Integrasi promotif dan preventif dalam kunjungan rumah memperkuat deteksi dini komplikasi dan meningkatkan literasi kesehatan keluarga.

Upaya penurunan angka kematian ibu (AKI) di Indonesia difokuskan pada penguatan pelayanan antenatal berkualitas. Standar minimal enam kali kunjungan antenatal sesuai rekomendasi nasional bertujuan meningkatkan deteksi dini risiko tinggi seperti hipertensi dalam kehamilan, anemia, dan diabetes gestasional (WHO, 2023). Implementasi standar tersebut menunjukkan peningkatan cakupan ANC, namun kualitas pelayanan masih menjadi tantangan di beberapa wilayah terpencil.

Program percepatan penurunan stunting juga menjadi bagian integral implementasi kebidanan primer. Intervensi pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan mencakup suplementasi zat besi dan asam folat, konseling menyusui eksklusif, pemantauan pertumbuhan balita, serta edukasi pemberian makanan pendamping ASI yang tepat (UNICEF, 2023). Bidan berperan sebagai koordinator layanan gizi ibu dan anak dalam jejaring posyandu dan fasilitas primer.

Pelayanan keluarga berencana di Indonesia mengalami penguatan melalui promosi Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP). Penggunaan MKJP terbukti menurunkan angka kehamilan tidak direncanakan dan risiko komplikasi maternal akibat jarak kehamilan yang terlalu dekat (WHO, 2023). Edukasi kontrasepsi pascapersalinan menjadi strategi preventif yang semakin ditekankan dalam praktik kebidanan primer.

Transformasi digital kesehatan nasional memperluas implementasi pelayanan kebidanan primer. Sistem Satu Sehat dan rekam medis elektronik meningkatkan integrasi data maternal dan neonatal secara nasional (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2023). Pemanfaatan telekonsultasi kebidanan di wilayah terpencil membantu pemantauan kehamilan risiko tinggi dan mempercepat rujukan kegawatdaruratan.

Pendekatan pelayanan obstetri neonatal emergensi dasar (PONED) di Puskesmas menjadi bagian penting dalam implementasi pencegahan tersier. Ketersediaan bidan terlatih dalam manajemen kegawatdaruratan seperti perdarahan postpartum dan preeklamsia berat meningkatkan respons cepat terhadap komplikasi. Sistem rujukan terintegrasi melalui jejaring rumah sakit rujukan memperkuat kesinambungan asuhan.

Pelibatan kader kesehatan dan tokoh masyarakat dalam program posyandu meningkatkan partisipasi ibu hamil dan ibu balita dalam layanan primer. Model berbasis komunitas terbukti meningkatkan cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih dan menurunkan risiko keterlambatan dalam pengambilan keputusan rujukan (WHO, 2023). Pendekatan ini relevan dengan karakteristik sosial budaya Indonesia yang menempatkan komunitas sebagai struktur pendukung utama.

Distribusi tenaga bidan di Indonesia menunjukkan peningkatan jumlah, namun kesenjangan kualitas dan pemerataan masih menjadi tantangan. Wilayah terpencil dan kepulauan menghadapi keterbatasan akses terhadap fasilitas kesehatan lengkap. Program Nusantara Sehat dan penempatan tenaga kesehatan berbasis kebutuhan wilayah menjadi strategi pemerintah untuk memperkuat layanan primer.

Implementasi pelayanan kebidanan primer di Indonesia memperlihatkan kemajuan dalam aspek cakupan dan regulasi. Tantangan kualitas, integrasi data,

serta keberlanjutan pembiayaan promotif-preventif masih memerlukan penguatan. Peran bidan sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan primer menjadi kunci dalam mewujudkan sistem kesehatan maternal yang responsif, berbasis bukti, dan berorientasi pada pencegahan.

G. Model Berbasis Komunitas dalam Kebidanan Primer

Model berbasis komunitas dalam kebidanan primer menempatkan masyarakat sebagai mitra aktif dalam menjaga kesehatan ibu dan anak. Pendekatan ini berakar pada prinsip partisipasi sosial, pemberdayaan, serta penguatan kapasitas lokal untuk mendukung keberlanjutan intervensi promotif dan preventif (*World Health Organization* [WHO], 2023). Pelayanan kebidanan tidak hanya berlangsung di fasilitas kesehatan, melainkan meluas hingga lingkungan keluarga dan komunitas tempat perempuan hidup dan berinteraksi.

Posyandu menjadi contoh konkret implementasi model berbasis komunitas di Indonesia. Kegiatan pemantauan kehamilan, penimbangan balita, suplementasi zat besi, imunisasi, serta edukasi gizi dilakukan secara rutin dengan melibatkan kader kesehatan. Pelibatan kader meningkatkan jangkauan layanan serta memperkuat hubungan antara bidan dan masyarakat. Studi menunjukkan bahwa keberadaan kader terlatih berkontribusi terhadap peningkatan kunjungan antenatal dan deteksi dini komplikasi (UNICEF, 2023).

Kelompok ibu hamil dan kelas ibu balita merupakan bentuk intervensi komunitas yang memperkuat literasi kesehatan. Diskusi partisipatif mengenai tanda bahaya kehamilan, teknik menyusui, serta perawatan bayi baru lahir meningkatkan kesiapan ibu menghadapi persalinan dan masa nifas. Pendekatan *peer support* dalam kelompok tersebut meningkatkan rasa percaya diri dan mengurangi kecemasan antenatal (WHO, 2022).

Model *community-based midwifery* memperluas peran bidan sebagai fasilitator kesehatan masyarakat. Bidan tidak hanya memberikan pelayanan klinis, tetapi juga melakukan pemetaan risiko sosial, identifikasi hambatan akses, serta advokasi kesehatan di tingkat desa. Determinan sosial seperti kemiskinan, pendidikan rendah, dan norma budaya tertentu memengaruhi keputusan perempuan dalam mencari pelayanan kesehatan (ICM, 2023). Intervensi komunitas memungkinkan pendekatan yang lebih kontekstual dan sensitif budaya.

Program Desa Siaga dan Kampung KB menjadi strategi pemerintah dalam memperkuat pelayanan berbasis komunitas. Integrasi pelayanan keluarga berencana, edukasi kesehatan reproduksi, serta pendampingan ibu hamil risiko tinggi dilakukan melalui jejaring lintas sektor. Kolaborasi dengan tokoh agama dan

pemimpin lokal meningkatkan penerimaan pesan kesehatan terutama pada masyarakat dengan struktur sosial kuat.

Pendekatan rumah tangga melalui kunjungan rumah menjadi bagian penting dalam model berbasis komunitas. Kunjungan rumah memungkinkan deteksi dini risiko seperti anemia berat, tekanan darah tinggi, atau kondisi lingkungan yang tidak sehat. Pendekatan ini efektif pada wilayah dengan keterbatasan transportasi dan akses fasilitas kesehatan (WHO, 2023).

Perkembangan teknologi digital memperluas cakupan model komunitas. Grup edukasi melalui aplikasi pesan instan, kelas ibu hamil daring, serta sistem pengingat kunjungan antenatal berbasis SMS meningkatkan komunikasi antara bidan dan ibu hamil. Intervensi mHealth berbasis komunitas terbukti meningkatkan kepatuhan konsumsi suplementasi dan kunjungan kontrol (Johnson et al., 2022).

Keterlibatan keluarga dalam model komunitas menjadi faktor penting keberhasilan intervensi. Dukungan suami dan anggota keluarga lainnya berpengaruh terhadap keputusan penggunaan kontrasepsi, kepatuhan kunjungan antenatal, serta keberhasilan menyusui eksklusif (UNICEF, 2023). Pendekatan family-centered care memperkuat lingkungan pendukung bagi perempuan.

Pendekatan berbasis komunitas juga relevan dalam pencegahan stunting dan peningkatan kualitas 1.000 Hari Pertama Kehidupan. Edukasi pemberian makanan pendamping ASI, pemantauan tumbuh kembang, serta skrining dini gangguan perkembangan dilakukan melalui jejaring posyandu. Model ini menciptakan kesinambungan antara pelayanan kebidanan dan kesehatan anak.

Model berbasis komunitas dalam kebidanan primer memperlihatkan bahwa pemberdayaan masyarakat meningkatkan keberlanjutan program kesehatan maternal dan neonatal. Integrasi pelayanan klinis, edukasi komunitas, serta dukungan keluarga menciptakan sistem pencegahan yang lebih responsif terhadap kebutuhan lokal. Penguatan kapasitas kader, supervisi berkelanjutan, serta dukungan kebijakan menjadi prasyarat keberhasilan implementasi model ini dalam jangka panjang.

H. Inovasi Digital & mHealth dalam Kebidanan Primer

Transformasi digital kesehatan menjadi bagian integral dalam penguatan pelayanan kebidanan primer. Perkembangan teknologi informasi memungkinkan perluasan akses, peningkatan kontinuitas asuhan, serta pemantauan kondisi maternal secara real-time. Strategi digital health di bidang maternal dan neonatal telah direkomendasikan secara global sebagai pendekatan untuk memperkuat sistem kesehatan primer (*World Health Organization* [WHO], 2023).

Telemidwifery berkembang sebagai model pelayanan jarak jauh yang memungkinkan bidan melakukan konsultasi antenatal, edukasi laktasi, serta pemantauan kondisi ibu hamil risiko tinggi tanpa keterbatasan geografis. Wilayah kepulauan dan daerah terpencil di Indonesia memperoleh manfaat signifikan dari pendekatan ini. Studi menunjukkan bahwa telekonsultasi antenatal meningkatkan kepatuhan kunjungan kontrol serta mempercepat deteksi komplikasi hipertensi dalam kehamilan (WHO, 2023).

Aplikasi mobile kesehatan maternal menjadi inovasi yang semakin luas digunakan. Fitur pengingat jadwal kunjungan antenatal, konsumsi tablet tambah darah, serta edukasi tanda bahaya kehamilan membantu meningkatkan literasi kesehatan ibu. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa intervensi mHealth berbasis pesan singkat (SMS reminder) meningkatkan kepatuhan konsumsi suplementasi zat besi dan kunjungan ANC secara signifikan (Johnson et al., 2022). Integrasi aplikasi dengan sistem rekam medis elektronik memperkuat koordinasi antar fasilitas pelayanan.

Pemanfaatan rekam medis elektronik (RME) dalam kebidanan primer mendukung pencatatan riwayat kehamilan secara komprehensif dan terintegrasi nasional. Sistem Satu Sehat di Indonesia memperkuat interoperabilitas data maternal dan neonatal, sehingga memudahkan rujukan dan tindak lanjut (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2023). Digitalisasi data meningkatkan akurasi pemantauan faktor risiko serta mempercepat respons terhadap kegawatdaruratan.

Pemantauan jarak jauh tekanan darah dan kadar glukosa pada ibu hamil risiko tinggi menjadi inovasi berbasis teknologi wearable dan telemonitoring. Intervensi ini efektif dalam mendeteksi dini preeklamsia dan diabetes gestasional. Penelitian menunjukkan bahwa remote monitoring pada kehamilan risiko tinggi menurunkan angka rawat inap serta meningkatkan kepuasan pasien (WHO, 2023).

Media sosial dan platform edukasi daring berperan dalam penyebaran informasi kesehatan reproduksi. Bidan dapat memanfaatkan konten edukatif berbasis bukti untuk meningkatkan literasi masyarakat. Tantangan misinformasi kesehatan di era digital menuntut tenaga kebidanan memiliki kompetensi literasi digital agar mampu menyaring dan menyampaikan informasi akurat (ICM, 2023).

Kelas ibu hamil berbasis daring menjadi inovasi yang berkembang pascapandemi. Model hybrid menggabungkan pertemuan tatap muka dan edukasi virtual untuk memperluas jangkauan layanan. Pendekatan ini efektif dalam mempertahankan kesinambungan edukasi pada kondisi pembatasan mobilitas.

Sistem pengingat imunisasi bayi dan kunjungan nifas berbasis SMS atau aplikasi membantu mencegah kehilangan tindak lanjut. Studi UNICEF (2023)

menunjukkan bahwa pengingat digital meningkatkan cakupan imunisasi dan kunjungan neonatal awal. Intervensi sederhana berbasis teknologi berdampak signifikan terhadap pencegahan komplikasi neonatal.

Penggunaan *artificial intelligence* (AI) dalam prediksi risiko obstetri mulai dikembangkan. Algoritma berbasis data dapat membantu mengidentifikasi ibu dengan risiko tinggi preeklamsia atau persalinan prematur berdasarkan kombinasi faktor klinis dan demografis. Integrasi AI dalam sistem pelayanan primer berpotensi meningkatkan ketepatan skrining dan perencanaan rujukan.

Keamanan data dan perlindungan privasi menjadi isu penting dalam implementasi inovasi digital kebidanan. Standar etika dan regulasi perlindungan data harus diperkuat untuk menjaga kerahasiaan informasi kesehatan reproduksi. Pelatihan tenaga kesehatan mengenai keamanan siber menjadi bagian dari penguatan sistem.

Inovasi digital dan mHealth dalam kebidanan primer memperluas cakupan promotif dan preventif secara signifikan. Integrasi teknologi dengan pendekatan human-centered care memastikan bahwa transformasi digital tetap berorientasi pada kebutuhan perempuan. Adaptasi teknologi yang tepat guna, berbasis bukti, dan kontekstual terhadap kondisi lokal menjadi kunci keberhasilan implementasi dalam sistem kesehatan Indonesia.

I. Tantangan dan Hambatan dalam Implementasi Promotif-Preventif Kebidanan Primer

Implementasi strategi promotif dan preventif dalam kebidanan primer menghadapi tantangan multidimensional yang bersifat sistemik, sosial, dan profesional. Kompleksitas determinan kesehatan maternal menuntut pendekatan lintas sektor yang belum sepenuhnya optimal dalam praktik di lapangan. Transformasi layanan primer di Indonesia menunjukkan kemajuan regulatif, namun kesenjangan implementasi masih terlihat pada aspek kualitas dan pemerataan.

Distribusi tenaga bidan yang belum merata menjadi hambatan utama dalam pelayanan primer berbasis pencegahan. Wilayah terpencil dan kepulauan menghadapi keterbatasan jumlah tenaga kesehatan serta sarana penunjang pelayanan obstetri dasar. Ketimpangan akses berdampak pada keterlambatan deteksi komplikasi dan peningkatan risiko kematian maternal (World Health Organization [WHO], 2023). Beban kerja bidan di fasilitas primer yang tinggi sering kali mengurangi waktu untuk konseling promotif mendalam.

Kualitas kompetensi dalam praktik *evidence-based midwifery* juga menjadi tantangan. Perkembangan ilmu kebidanan berlangsung cepat, terutama terkait skrining preeklamsia, manajemen diabetes gestasional, dan kesehatan mental

perinatal. Keterbatasan pelatihan berkelanjutan dan akses terhadap literatur ilmiah terbaru dapat menghambat penerapan praktik berbasis bukti (International Confederation of Midwives [ICM], 2023). Ketidakkonsistenan standar praktik berpotensi memengaruhi mutu pelayanan preventif.

Literasi kesehatan masyarakat yang masih rendah memperlambat perubahan perilaku preventif. Kepercayaan budaya tertentu mengenai kehamilan, persalinan, dan praktik perawatan bayi sering kali bertentangan dengan rekomendasi medis berbasis bukti. Fenomena pernikahan usia dini dan kehamilan berulang dengan jarak dekat masih ditemukan di beberapa wilayah, meningkatkan risiko komplikasi obstetri (UNICEF, 2023). Edukasi promotif membutuhkan pendekatan sensitif budaya dan komunikasi interpersonal yang efektif.

Pembiayaan promotif dan preventif dalam sistem kesehatan nasional masih relatif lebih kecil dibandingkan alokasi untuk pelayanan kuratif. Struktur pembiayaan berbasis klaim cenderung lebih mengakomodasi tindakan kuratif dibandingkan intervensi edukatif dan preventif jangka panjang (World Bank, 2022). Ketidakseimbangan ini berdampak pada kurang optimalnya investasi dalam program pencegahan maternal dan neonatal.

Tantangan integrasi sistem informasi kesehatan juga memengaruhi efektivitas pelayanan preventif. Digitalisasi melalui sistem rekam medis elektronik belum sepenuhnya terimplementasi secara merata di seluruh fasilitas primer. Keterbatasan infrastruktur internet dan literasi digital tenaga kesehatan di daerah tertentu menghambat pemanfaatan telemidwifery dan sistem pengingat digital (WHO, 2023). Keamanan data dan perlindungan privasi menjadi isu tambahan dalam pengembangan layanan berbasis teknologi.

Keterlambatan dalam sistem rujukan masih menjadi faktor risiko dalam kegawatdaruratan obstetri. Tiga keterlambatan klasik keterlambatan pengambilan keputusan, keterlambatan mencapai fasilitas, dan keterlambatan mendapatkan pelayanan masih relevan dalam konteks Indonesia. Keterbatasan transportasi, kondisi geografis, serta kendala administratif memperpanjang waktu respons terhadap komplikasi akut.

Faktor sosial ekonomi keluarga turut memengaruhi keberhasilan strategi preventif. Kemiskinan dan ketidakstabilan ekonomi mengurangi akses terhadap nutrisi adekuat dan layanan kesehatan berkualitas. Perempuan dengan pendidikan rendah cenderung memiliki literasi kesehatan yang terbatas, sehingga memengaruhi kepatuhan terhadap kunjungan antenatal dan konsumsi suplementasi (WHO, 2023).

Resistensi terhadap inovasi digital di kalangan sebagian tenaga kesehatan dan masyarakat juga menjadi hambatan. Adaptasi teknologi membutuhkan pelatihan,

supervisi, dan perubahan budaya kerja. Kurangnya kepercayaan terhadap layanan telekonsultasi dapat membatasi pemanfaatan teknologi dalam kebidanan primer.

Tantangan multidimensional tersebut menunjukkan bahwa implementasi promotif-preventif dalam kebidanan primer memerlukan penguatan sistem secara komprehensif. Strategi peningkatan kapasitas SDM, pembiayaan berbasis pencegahan, integrasi teknologi, serta pendekatan berbasis komunitas menjadi kebutuhan mendesak untuk mengatasi hambatan yang ada.

J. Rekomendasi Kebijakan dalam Penguatan Promotif-Preventif Kebidanan Primer

Penguatan promotif dan preventif dalam kebidanan primer memerlukan kebijakan yang terintegrasi, berbasis bukti, serta berorientasi pada keberlanjutan sistem kesehatan. Reformasi kebijakan harus memastikan bahwa intervensi pencegahan maternal dan neonatal menjadi prioritas strategis dalam transformasi layanan primer nasional. Pendekatan kebijakan perlu mempertimbangkan determinan sosial kesehatan, perkembangan evidence-based midwifery, serta adaptasi terhadap inovasi digital.

Reorientasi pembiayaan kesehatan menjadi langkah fundamental. Proporsi anggaran untuk promotif dan preventif perlu ditingkatkan agar seimbang dengan layanan kuratif. Skema pembiayaan berbasis kinerja preventif dapat diterapkan melalui indikator seperti cakupan skrining anemia, kepatuhan kunjungan antenatal, serta penggunaan kontrasepsi pascapersalinan (World Bank, 2022). Insentif berbasis pencegahan mendorong fasilitas primer dan bidan untuk mengoptimalkan intervensi promotif.

Penguatan kapasitas sumber daya manusia kebidanan menjadi prioritas kebijakan. Program pelatihan berkelanjutan berbasis *evidence-based practice* perlu diperluas, khususnya terkait skrining preeklamsia, manajemen diabetes gestasional, kesehatan mental perinatal, serta penggunaan teknologi digital kesehatan (*International Confederation of Midwives* [ICM], 2023). Integrasi kurikulum pendidikan kebidanan dengan kompetensi literasi digital dan telemidwifery akan memperkuat kesiapan tenaga kesehatan menghadapi transformasi layanan.

Standardisasi pelayanan berbasis bukti harus diperkuat melalui pedoman klinis nasional yang diperbarui secara berkala. Implementasi audit maternal perinatal secara rutin di tingkat primer membantu mengidentifikasi kesenjangan mutu pelayanan dan mempercepat perbaikan sistem. Transparansi data dan umpan balik berbasis indikator kinerja meningkatkan akuntabilitas layanan kebidanan.

Penguatan sistem rujukan maternal-neonatal menjadi aspek krusial dalam kebijakan preventif tersier. Integrasi sistem informasi kesehatan dengan jejaring

rujukan mempercepat respons terhadap kegawatdaruratan obstetri. Dukungan transportasi rujukan berbasis komunitas dan kemitraan lintas sektor mengurangi keterlambatan dalam penanganan komplikasi (*World Health Organization [WHO]*, 2023).

Kebijakan berbasis komunitas perlu diperluas melalui penguatan posyandu, kelas ibu hamil, serta kelompok pendukung menyusui. Kader kesehatan harus mendapatkan pelatihan standar dan supervisi berkala untuk memastikan konsistensi pesan promotif. Pelibatan tokoh masyarakat dan organisasi perempuan meningkatkan efektivitas intervensi di wilayah dengan norma budaya kuat.

Digitalisasi pelayanan kebidanan primer memerlukan regulasi yang menjamin keamanan data dan interoperabilitas sistem. Pengembangan platform nasional untuk pemantauan kehamilan risiko tinggi, pengingat kunjungan, serta pelaporan digital mendukung keberlanjutan layanan promotif-preventif (WHO, 2023). Kebijakan literasi digital bagi masyarakat juga penting untuk mengurangi kesenjangan akses informasi kesehatan.

Pendekatan intersektoral harus menjadi bagian integral kebijakan kesehatan maternal. Kolaborasi dengan sektor pendidikan untuk pencegahan anemia remaja, sektor sosial untuk perlindungan ibu rentan, serta sektor transportasi untuk akses rujukan memperkuat dampak kebijakan promotif-preventif. Integrasi lintas sektor meningkatkan efektivitas intervensi berbasis determinan sosial kesehatan.

Pemantauan dan evaluasi berbasis data real-time diperlukan untuk memastikan efektivitas kebijakan. Indikator kinerja seperti penurunan angka anemia ibu hamil, peningkatan cakupan menyusui eksklusif, serta penurunan komplikasi preeklamsia harus menjadi tolok ukur keberhasilan. Sistem dashboard nasional berbasis digital mempercepat analisis dan pengambilan keputusan.

Rekomendasi kebijakan dalam penguatan promotif-preventif kebidanan primer menegaskan pentingnya pendekatan sistemik yang terintegrasi. Investasi pada pencegahan, penguatan kapasitas bidan, digitalisasi layanan, serta pemberdayaan komunitas menjadi pilar utama dalam menurunkan angka kematian maternal dan neonatal secara berkelanjutan. Komitmen politik, dukungan pembiayaan, dan koordinasi lintas sektor menentukan keberhasilan implementasi kebijakan tersebut dalam jangka panjang.

K. Simpulan

Pelayanan kebidanan primer memiliki posisi strategis dalam sistem kesehatan nasional sebagai garda terdepan upaya promotif dan preventif kesehatan ibu dan anak. Pendekatan berbasis evidence-based midwifery, woman-centered care, serta continuity of care memperkuat integrasi pencegahan primer, sekunder, dan tersier dalam satu rangkaian asuhan yang komprehensif. Sebagian besar komplikasi maternal dan neonatal dapat dicegah melalui intervensi dini yang sistematis sejak masa remaja, prakonsepsi, kehamilan, persalinan, hingga periode nifas.

Fenomena peningkatan penyakit tidak menular pada ibu hamil, anemia remaja, gangguan kesehatan mental perinatal, serta tantangan stunting menuntut penguatan strategi promotif dan preventif berbasis siklus kehidupan. Pendekatan berbasis komunitas melalui posyandu, kelas ibu hamil, serta pelibatan keluarga meningkatkan efektivitas intervensi dan keberlanjutan perubahan perilaku. Transformasi digital melalui telemidwifery, rekam medis elektronik, dan mHealth memperluas jangkauan layanan kebidanan primer terutama di wilayah dengan keterbatasan akses.

Tantangan implementasi meliputi ketimpangan distribusi tenaga kesehatan, keterbatasan pembiayaan preventif, literasi kesehatan masyarakat yang rendah, serta integrasi sistem informasi yang belum merata. Respon kebijakan perlu diarahkan pada peningkatan kapasitas bidan berbasis praktik ilmiah terkini, penguatan pembiayaan promotif-preventif, digitalisasi layanan yang aman dan terintegrasi, serta kolaborasi lintas sektor berbasis determinan sosial kesehatan.

Penguatan promotif dan preventif dalam kebidanan primer bukan sekadar strategi teknis, melainkan investasi jangka panjang terhadap kualitas generasi masa depan. Keberhasilan intervensi pencegahan maternal dan neonatal berkontribusi langsung terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pembangunan berkelanjutan. Komitmen sistem kesehatan dalam memprioritaskan pencegahan menjadi kunci dalam menurunkan angka kematian ibu dan bayi secara konsisten dan berkelanjutan.

L. Referensi

- International Confederation of Midwives. (2023). Essential competencies for midwifery practice 2023 update. ICM.
- Johnson, D., Riley, P., Chatterji, M., & Sloane, P. (2022). The impact of mobile health interventions on maternal health service utilization: A systematic review. *Journal of Medical Internet Research*, 24(6), e34521. <https://doi.org/10.2196/34521>

- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2023). Profil kesehatan Indonesia tahun 2023. Kemenkes RI.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2023). Transformasi sistem kesehatan Indonesia: Pilar layanan primer. Kemenkes RI.
- Nutbeam, D. (2022). Health literacy as a public health goal: Contemporary perspectives. *Health Promotion International*, 37(2), daac012. <https://doi.org/10.1093/heapro/daac012>
- Renfrew, M. J., McFadden, A., Bastos, M. H., Campbell, J., Channon, A. A., Cheung, N. F., Silva, D. R., Downe, S., Kennedy, H. P., Malata, A., McCormick, F., Wick, L., & Declercq, E. (2021). Midwifery and quality care: Findings from updated evidence review. *The Lancet Global Health*, 9(3), e292–e301. [https://doi.org/10.1016/S2214-109X\(20\)30512-5](https://doi.org/10.1016/S2214-109X(20)30512-5)
- Sandall, J., Fernandez Turienzo, C., Devane, D., Soltani, H., & Gates, S. (2022). Midwife-led continuity models versus other models of care for childbearing women. *Cochrane Database of Systematic Reviews*, 2022(4), CD004667. <https://doi.org/10.1002/14651858.CD004667.pub6>
- UNICEF. (2023). State of the world's children 2023: For every child, nutrition. UNICEF.
- United Nations. (2022). Life-course approach to health: Policy framework. United Nations Publications.
- World Bank. (2022). Indonesia health expenditure review: Investing in prevention for sustainable health financing. World Bank Group.
- World Health Organization. (2022). Maternal mental health and child health outcomes: Global update. WHO.
- World Health Organization. (2023). Digital health global strategy 2020–2025 progress report. WHO.
- World Health Organization. (2023). Global health estimates 2023: Leading causes of death and disability. WHO.
- World Health Organization. (2023). Primary health care and universal health coverage: Monitoring report 2023. WHO.
- World Health Organization. (2023). Recommendations on antenatal care for a positive pregnancy experience (updated guideline). WHO.
- World Health Organization. (2023). Trends in maternal mortality 2000–2023. WHO.
- World Health Organization. (2023). WHO guideline on prevention of postpartum haemorrhage. WHO.

M. Glosarium

1. Antenatal Care (ANC) : Pelayanan kesehatan yang diberikan kepada ibu hamil secara berkala untuk memantau kondisi ibu dan janin serta mendeteksi dini komplikasi kehamilan.
2. Anemia Maternal : Kondisi kadar hemoglobin ibu hamil di bawah batas normal (<11 g/dL) yang berisiko meningkatkan perdarahan postpartum dan kelahiran prematur.
3. Artificial Intelligence (AI) : Teknologi berbasis kecerdasan buatan yang digunakan dalam sistem kesehatan untuk membantu analisis data dan prediksi risiko klinis.
4. Continuity of Midwifery Care : Model asuhan kebidanan berkelanjutan yang diberikan oleh bidan yang sama atau tim kecil bidan sejak prakonsepsi hingga periode postpartum.
5. Digital Health : Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan akses, kualitas, dan efisiensi pelayanan kesehatan.
6. Diabetes Gestasional : Gangguan toleransi glukosa yang pertama kali terdeteksi selama kehamilan dan berisiko terhadap komplikasi maternal dan neonatal.
7. Evidence-Based Midwifery : Praktik kebidanan yang mengintegrasikan bukti ilmiah terbaru, pengalaman klinis profesional, serta nilai dan preferensi perempuan dalam pengambilan keputusan pelayanan.
8. Inisiasi Menyusu Dini (IMD) : Proses meletakkan bayi di dada ibu segera setelah lahir untuk memulai proses menyusui dalam satu jam pertama kehidupan.
9. Kesehatan Mental Perinatal : Kondisi kesehatan psikologis ibu selama masa kehamilan hingga satu tahun setelah persalinan.
10. Life-Course Approach : Pendekatan kesehatan yang menekankan intervensi berkelanjutan sejak masa remaja, prakonsepsi, kehamilan, hingga usia lanjut.
11. mHealth (Mobile Health) : Penggunaan perangkat mobile seperti telepon seluler untuk mendukung edukasi, pemantauan, dan pengingat layanan kesehatan.
12. Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) : Metode kontrasepsi efektif dengan durasi panjang seperti implan dan alat kontrasepsi dalam rahim (AKDR/IUD).
13. Preeklamsia : Komplikasi kehamilan yang ditandai dengan hipertensi dan proteinuria setelah usia kehamilan 20 minggu.
14. Primary Health Care (PHC) : Pendekatan pelayanan kesehatan komprehensif dan terjangkau yang berfokus pada pencegahan, promosi, dan pemberdayaan masyarakat.
15. Promotif : Upaya peningkatan kapasitas individu dan masyarakat untuk menjaga serta meningkatkan kesehatan.

16. Preventif : Upaya pencegahan penyakit melalui intervensi primer, sekunder, dan tersier.
17. Rekam Medis Elektronik (RME) : Sistem pencatatan data kesehatan pasien secara digital dan terintegrasi.
18. Stunting : Kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis yang ditandai dengan tinggi badan di bawah standar usia.
19. Telemidwifery : Pelayanan kebidanan jarak jauh melalui media digital untuk konsultasi dan pemantauan kesehatan ibu.
20. Universal Health Coverage (UHC) : Sistem jaminan kesehatan yang memastikan seluruh masyarakat memperoleh layanan kesehatan yang dibutuhkan tanpa mengalami kesulitan finansial.

CHAPTER 4

PERAN KEBIDANAN DALAM PELAYANAN KESEHATAN PRIMER

Bdn. Putu Lusita Nati Indriani, SST., M.Kes.

A. Pendahuluan

Pelayanan kesehatan primer merupakan komponen fundamental dalam sistem kesehatan yang berfungsi sebagai titik kontak pertama masyarakat dengan layanan kesehatan formal. Kerangka *Primary Health Care* menekankan akses universal, keberlanjutan asuhan, dan pemberdayaan komunitas sebagai prinsip utama (World Health Organization [WHO], 2023). Struktur pelayanan primer di Indonesia mencakup Puskesmas, klinik pratama, praktik mandiri tenaga kesehatan, serta jejaring berbasis komunitas yang menjadi ujung tombak intervensi promotif dan preventif (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2023).

Profesi kebidanan memiliki kontribusi signifikan dalam pelayanan primer karena sebagian besar kebutuhan kesehatan perempuan sepanjang siklus reproduksi berada dalam domain praktik kebidanan. *International Confederation of Midwives* (ICM, 2023) menegaskan bahwa bidan berperan tidak hanya dalam pertolongan persalinan normal, tetapi juga dalam promosi kesehatan reproduksi, deteksi dini risiko obstetri, serta advokasi hak kesehatan perempuan. Model *midwife-led care* terbukti meningkatkan keselamatan ibu dan bayi serta mengurangi intervensi obstetrik yang tidak perlu (Sandall et al., 2022).

Angka kematian ibu masih menjadi indikator global ketimpangan layanan kesehatan. Laporan *United Nations Maternal Mortality Estimation Inter-Agency Group* menunjukkan bahwa sebagian besar kematian maternal disebabkan oleh kondisi yang dapat dicegah melalui pelayanan primer berkualitas seperti perdarahan postpartum, preeklamsia, dan infeksi (United Nations, 2023). *Studi Lancet Series on Midwifery* memperkirakan bahwa optimalisasi layanan kebidanan berbasis komunitas dapat mencegah lebih dari 80% kematian maternal dan neonatal (Nove et al., 2021).

Perubahan epidemiologi kesehatan maternal menunjukkan peningkatan risiko akibat penyakit tidak menular. Prevalensi obesitas dan hipertensi pada perempuan usia reproduksi meningkat secara global dan berkontribusi terhadap komplikasi kehamilan (*Institute for Health Metrics and Evaluation* [IHME], 2023). Diabetes gestasional dan gangguan metabolik memperluas kebutuhan skrining preventif

dalam *antenatal care* (*American College of Obstetricians and Gynecologists* [ACOG], 2023). Gangguan kesehatan mental perinatal juga menjadi isu penting dengan prevalensi depresi postpartum mencapai 10–20% secara global (Howard & Khalifeh, 2020; WHO, 2022).

Pendekatan *evidence-based midwifery* menjadi landasan utama penguatan peran kebidanan dalam pelayanan primer. Integrasi hasil penelitian terkini, pengalaman klinis, serta preferensi perempuan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan klinis (Reed et al., 2021). Continuity of midwifery care terbukti menurunkan risiko kelahiran prematur dan meningkatkan pengalaman persalinan positif (Sandall et al., 2022). Model ini memperkuat fungsi promotif dan preventif dalam satu rangkaian asuhan berkelanjutan.

Transformasi digital kesehatan memberikan dimensi baru dalam pelayanan kebidanan primer. *Global Strategy on Digital Health* menekankan pemanfaatan telemedicine, sistem rekam medis elektronik, dan aplikasi pemantauan kehamilan sebagai upaya meningkatkan akses dan kualitas layanan (WHO, 2023). Penelitian menunjukkan bahwa intervensi mHealth meningkatkan kepatuhan kunjungan antenatal dan konsumsi suplementasi zat besi (Lee et al., 2022). Adaptasi teknologi dalam praktik kebidanan memperluas jangkauan promotif dan preventif terutama pada wilayah dengan keterbatasan geografis.

Determinasi sosial kesehatan turut memengaruhi outcome maternal. Ketimpangan ekonomi, pendidikan, dan akses transportasi menjadi faktor risiko keterlambatan dalam memperoleh pelayanan obstetri (Say et al., 2023). Bidan dalam pelayanan primer berperan sebagai advokat kesehatan perempuan melalui pendekatan berbasis komunitas yang sensitif terhadap konteks sosial dan budaya.

Peran kebidanan dalam pelayanan kesehatan primer berkembang seiring arah kebijakan transformasi sistem kesehatan nasional. Fokus penguatan layanan primer, peningkatan skrining penyakit, serta digitalisasi sistem kesehatan memperluas tanggung jawab profesional bidan (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2023). Integrasi promotif, preventif, berbasis bukti, dan berbasis komunitas menjadi strategi utama dalam menurunkan angka kematian ibu dan bayi secara berkelanjutan.

Bab ini membahas secara komprehensif peran kebidanan dalam pelayanan kesehatan primer melalui perspektif ilmiah terkini, perkembangan evidence-based practice, serta dinamika kebijakan kesehatan global dan nasional.

B. Landasan Teoretis Peran Kebidanan dalam Pelayanan Kesehatan Primer

Landasan teoretis peran kebidanan dalam pelayanan kesehatan primer dibangun atas integrasi filosofi kebidanan, prinsip *Primary Health Care* (PHC), teori determinan sosial kesehatan, serta pendekatan evidence-based practice. Kerangka konseptual tersebut menempatkan bidan sebagai penyedia layanan kesehatan perempuan yang komprehensif, berkesinambungan, dan berbasis komunitas.

Primary Health Care menekankan akses universal, partisipasi masyarakat, intersektoralitas, serta penekanan pada promotif dan preventif (World Health Organization [WHO], 2023). Prinsip ini selaras dengan mandat profesi kebidanan yang berfokus pada pemeliharaan kesehatan reproduksi sepanjang siklus kehidupan perempuan. Posisi bidan sebagai tenaga kesehatan lini pertama memungkinkan intervensi dini terhadap faktor risiko maternal dan neonatal.

Filosofi *woman-centered care* menjadi fondasi praktik kebidanan modern. Pendekatan ini menghormati otonomi perempuan, memastikan partisipasi aktif dalam pengambilan keputusan klinis, serta mengakui pengalaman subjektif perempuan sebagai bagian penting dalam asuhan (International Confederation of Midwives [ICM], 2023). *Woman-centered care* tidak hanya menekankan aspek klinis, tetapi juga dimensi psikososial dan budaya dalam pelayanan primer.

Model *continuity of midwifery care* memperkuat landasan teoretis tersebut. Asuhan berkelanjutan oleh bidan yang sama atau tim kecil bidan sejak masa antenatal hingga postpartum terbukti meningkatkan keselamatan maternal dan neonatal serta menurunkan intervensi obstetri yang tidak perlu (Sandall et al., 2022). Model ini menunjukkan bahwa kesinambungan hubungan terapeutik antara bidan dan perempuan meningkatkan kepercayaan serta kepatuhan terhadap intervensi preventif.

Teori *life-course approach* memberikan perspektif longitudinal terhadap kesehatan reproduksi. Paparan risiko sejak remaja, status gizi prakonsepsi, kondisi sosial ekonomi, serta akses pendidikan memengaruhi outcome kehamilan di masa depan (United Nations, 2023). Kerangka ini memperluas peran kebidanan primer tidak hanya pada fase kehamilan, tetapi juga pada promosi kesehatan remaja dan perempuan usia subur.

Kerangka determinan sosial kesehatan menjelaskan bahwa kesehatan maternal dipengaruhi oleh faktor struktural seperti kemiskinan, ketimpangan gender, pendidikan, dan akses layanan (Solar & Irwin, 2021). Bidan dalam pelayanan primer memiliki tanggung jawab melakukan asesmen sosial serta advokasi berbasis komunitas. Peran tersebut menempatkan bidan sebagai agen perubahan sosial dalam sistem kesehatan.

Evidence-based midwifery menjadi elemen sentral dalam penguatan peran kebidanan. Integrasi hasil penelitian ilmiah terbaru, pengalaman klinis, serta nilai perempuan menghasilkan praktik yang aman dan efektif (Reed et al., 2021). Implementasi pedoman klinis berbasis bukti seperti skrining preeklamsia, manajemen aktif kala III, serta deteksi dini diabetes gestasional memperlihatkan kontribusi nyata terhadap penurunan morbiditas maternal.

Teori pencegahan primer, sekunder, dan tersier juga relevan dalam kerangka kebidanan primer. Pencegahan primer mencakup edukasi kesehatan reproduksi dan konseling prakonsepsi. Pencegahan sekunder meliputi skrining risiko kehamilan dan deteksi dini komplikasi. Pencegahan tersier berfokus pada manajemen cepat untuk mencegah dampak lanjutan komplikasi obstetri. Integrasi ketiga tingkat pencegahan tersebut mencerminkan fungsi komprehensif kebidanan dalam pelayanan primer.

Pendekatan *interprofessional collaborative practice* memperkuat posisi kebidanan dalam sistem kesehatan primer. Kolaborasi antara bidan, dokter, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya meningkatkan koordinasi rujukan serta kesinambungan pelayanan (World Health Organization, 2023). Model kolaboratif memperlihatkan bahwa sistem primer yang kuat bergantung pada sinergi antarprofesi.

Transformasi digital kesehatan memberikan dimensi tambahan dalam kerangka teoretis kebidanan primer. Digital health memungkinkan pemantauan risiko secara berkelanjutan dan meningkatkan akses layanan pada populasi rentan (WHO, 2023). Adaptasi teknologi harus tetap mempertahankan prinsip human-centered care agar hubungan terapeutik tidak tergantikan oleh teknologi semata.

Landasan teoretis tersebut menunjukkan bahwa peran kebidanan dalam pelayanan kesehatan primer tidak terbatas pada fungsi klinis, melainkan mencakup dimensi promotif, preventif, sosial, edukatif, dan advokatif. Integrasi filosofi kebidanan, pendekatan berbasis bukti, dan prinsip pelayanan primer menjadi kerangka konseptual dalam memperkuat kontribusi bidan terhadap sistem kesehatan yang berkelanjutan dan berkeadilan.

C. Ruang Lingkup Peran Kebidanan dalam Pelayanan Kesehatan Primer

Ruang lingkup peran kebidanan dalam pelayanan kesehatan primer mencerminkan integrasi fungsi promotif, preventif, kuratif dasar, rehabilitatif, serta advokatif dalam satu sistem pelayanan berkelanjutan. Profesi kebidanan tidak terbatas pada pertolongan persalinan normal, melainkan mencakup pelayanan komprehensif sepanjang siklus reproduksi perempuan. Kerangka kompetensi global menegaskan bahwa bidan memiliki kewenangan dalam pelayanan prakonsepsi,

antenatal, intrapartum, postnatal, neonatal, serta keluarga berencana (International Confederation of Midwives [ICM], 2023).

1. Peran dalam Pelayanan Prakonsepsi dan Kesehatan Remaja

Pelayanan kesehatan primer memberikan ruang bagi bidan untuk melakukan intervensi sejak fase prakonsepsi. Edukasi kesehatan reproduksi remaja, pencegahan anemia, skrining risiko penyakit tidak menular, serta konseling gizi menjadi bagian dari pencegahan primer. Prevalensi anemia remaja putri masih menjadi masalah kesehatan masyarakat di berbagai negara berkembang dan berkontribusi terhadap risiko komplikasi kehamilan di masa depan (World Health Organization [WHO], 2023).

Konseling pranikah dan prakonsepsi memperluas cakupan kebidanan dalam pelayanan primer. Identifikasi penyakit kronis, pengendalian berat badan, serta suplementasi asam folat sebelum kehamilan merupakan intervensi berbasis bukti yang menurunkan risiko kelainan kongenital dan komplikasi obstetri (American College of Obstetricians and Gynecologists [ACOG], 2023).

2. Peran dalam Pelayanan Antenatal

Asuhan antenatal menjadi komponen inti pelayanan kebidanan primer. Bidan bertanggung jawab melakukan skrining risiko kehamilan, pemantauan pertumbuhan janin, deteksi dini hipertensi dan diabetes gestasional, serta edukasi persiapan persalinan. Rekomendasi global menyarankan minimal delapan kontak antenatal untuk meningkatkan kualitas pemantauan risiko (WHO, 2023). *Continuity of care* dalam pelayanan antenatal terbukti meningkatkan kepatuhan kunjungan dan memperbaiki outcome maternal (Sandall et al., 2022). Hubungan terapeutik yang terbangun secara berkelanjutan memungkinkan identifikasi dini perubahan kondisi klinis dan psikososial ibu.

3. Peran dalam Pertolongan Persalinan Normal

Pelayanan persalinan normal di fasilitas primer merupakan ruang lingkup utama praktik kebidanan. Penggunaan partograf, manajemen aktif kala III, serta deteksi dini kegawatdaruratan obstetri menjadi standar praktik berbasis bukti. Intervensi tepat waktu pada perdarahan postpartum dan preeklamsia dapat mencegah komplikasi fatal (WHO, 2023).

Pelayanan persalinan oleh bidan terlatih menurunkan angka intervensi medis yang tidak perlu serta meningkatkan pengalaman persalinan positif (Nove et al., 2021). Model midwife-led unit menunjukkan efektivitas dalam menangani persalinan risiko rendah secara aman dan efisien.

4. Peran dalam Asuhan Nifas dan Neonatal

Periode nifas dan neonatal memiliki risiko komplikasi tinggi yang sering terabaikan. Bidan berperan dalam pemantauan involusi uterus, deteksi infeksi,

konseling kontrasepsi pascapersalinan, serta skrining depresi postpartum. Perawatan bayi baru lahir meliputi inisiasi menyusui dini, pencegahan hipotermia, dan deteksi dini infeksi neonatal (UNICEF, 2023).

Pendekatan promotif pada fase ini meningkatkan keberhasilan menyusui eksklusif dan memperkuat ikatan ibu-bayi. Edukasi keluarga mengenai tanda bahaya neonatal mempercepat pencarian pertolongan medis apabila terjadi komplikasi.

5. Peran dalam Pelayanan Keluarga Berencana

Pelayanan keluarga berencana menjadi bagian integral kebidanan primer. Konseling kontrasepsi berbasis bukti, pemilihan metode sesuai kebutuhan perempuan, serta promosi Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) mendukung pengaturan jarak kehamilan yang aman. Jarak kehamilan yang terlalu dekat meningkatkan risiko prematuritas dan komplikasi maternal (WHO, 2023).

Pendekatan *family-centered care* meningkatkan partisipasi pasangan dalam pengambilan keputusan kontrasepsi. Peran bidan sebagai konselor reproduksi memperkuat fungsi preventif dalam sistem kesehatan.

6. Peran dalam Promosi Kesehatan Mental Perinatal

Gangguan kesehatan mental perinatal menjadi isu yang semakin mendapat perhatian dalam pelayanan primer. Skrining depresi antenatal dan postpartum menggunakan instrumen sederhana memungkinkan deteksi dini dan rujukan tepat waktu (Howard & Khalifeh, 2020). Dukungan emosional dan konseling dasar oleh bidan berkontribusi terhadap kesejahteraan psikologis ibu.

7. Peran dalam Pelayanan Berbasis Komunitas

Ruang lingkup kebidanan primer meluas ke ranah komunitas melalui posyandu, kelas ibu hamil, dan kunjungan rumah. Pemetaan risiko sosial, edukasi gizi, serta pendampingan ibu risiko tinggi memperkuat pendekatan promotif-preventif berbasis komunitas (WHO, 2023). Model ini efektif dalam meningkatkan cakupan layanan pada populasi rentan.

8. Peran dalam Transformasi Digital Pelayanan Primer

Pemanfaatan telemidwifery, rekam medis elektronik, dan aplikasi pemantauan kehamilan memperluas cakupan pelayanan kebidanan. Intervensi mHealth meningkatkan kepatuhan kunjungan dan konsumsi suplementasi zat besi (Lee et al., 2022). Adaptasi teknologi menjadi bagian dari kompetensi baru bidan dalam pelayanan primer modern.

Tabel 4.1
Ruang Lingkup Peran Kebidanan dalam Pelayanan Primer

Tahap Siklus Reproduksi	Peran Bidan dalam Pelayanan Primer
Remaja & Prakonsepsi	Edukasi reproduksi, skrining anemia
Antenatal	Skrining risiko, edukasi persalinan
Intrapartum	Pertolongan persalinan normal
Postpartum	Konseling KB, skrining depresi
Neonatal	Perawatan esensial bayi baru lahir

Ruang lingkup peran kebidanan dalam pelayanan kesehatan primer menunjukkan cakupan yang luas dan multidimensional. Integrasi aspek klinis, promotif, preventif, sosial, dan digital menegaskan bahwa bidan merupakan aktor sentral dalam penguatan sistem kesehatan primer berbasis perempuan dan keluarga.

D. Peran Promotif Kebidanan dalam Pelayanan Kesehatan Primer

Peran promotif kebidanan dalam pelayanan kesehatan primer berfokus pada peningkatan kapasitas perempuan, keluarga, dan komunitas dalam menjaga kesehatan reproduksi secara mandiri dan berkelanjutan. Pendekatan promotif tidak sekadar menyampaikan informasi, tetapi mendorong perubahan perilaku berbasis literasi kesehatan, pemberdayaan, dan partisipasi aktif perempuan dalam pengambilan keputusan kesehatan (Nutbeam, 2022). Bidan menjadi aktor utama dalam membangun kesadaran kesehatan reproduksi sepanjang siklus kehidupan.

Promosi kesehatan reproduksi remaja merupakan bagian fundamental dari peran promotif kebidanan. Anemia pada remaja putri, kurangnya pengetahuan tentang kesehatan seksual, serta praktik pernikahan usia dini meningkatkan risiko komplikasi kehamilan di masa depan (UNICEF, 2023). Edukasi berbasis sekolah dan komunitas yang dilakukan bidan meningkatkan pemahaman remaja mengenai nutrisi, kesehatan menstruasi, serta perencanaan kehamilan yang sehat. Intervensi dini pada kelompok ini merupakan investasi jangka panjang terhadap kualitas kesehatan maternal.

Konseling prakonsepsi menjadi strategi promotif yang semakin diakui dalam pelayanan primer. Perempuan dengan faktor risiko seperti obesitas, hipertensi, diabetes, atau gangguan tiroid memerlukan optimalisasi kondisi kesehatan sebelum hamil (American College of Obstetricians and Gynecologists [ACOG], 2023). Edukasi mengenai suplementasi asam folat, pengendalian penyakit kronis, serta gaya hidup sehat terbukti menurunkan risiko komplikasi obstetri. Pendekatan ini memperluas cakupan promotif kebidanan dari fase antenatal menjadi prakonsepsi.

Pelayanan antenatal memberikan ruang strategis untuk promosi kesehatan ibu hamil. Edukasi mengenai tanda bahaya kehamilan, nutrisi seimbang, aktivitas fisik

aman, serta persiapan persalinan memperkuat kesiapan ibu secara fisik dan psikologis. Bukti ilmiah menunjukkan bahwa peningkatan literasi kesehatan ibu berhubungan dengan kepatuhan kunjungan antenatal dan penurunan risiko komplikasi (World Health Organization [WHO], 2023).

Promosi menyusui eksklusif menjadi pilar penting dalam praktik kebidanan promotif. Cakupan menyusui eksklusif global belum mencapai target optimal meskipun manfaatnya terhadap pencegahan infeksi dan peningkatan imunitas bayi telah terbukti (UNICEF, 2023). Konseling laktasi sejak masa antenatal dan dukungan berkelanjutan pada periode postpartum meningkatkan keberhasilan pemberian ASI eksklusif. Peran bidan dalam membangun kepercayaan diri ibu menjadi faktor kunci keberhasilan praktik ini.

Promosi kesehatan mental perinatal semakin relevan dalam pelayanan primer. Prevalensi depresi antenatal dan postpartum meningkat secara global dan berdampak pada kesejahteraan ibu serta perkembangan anak (Howard & Khalifeh, 2020). Edukasi mengenai manajemen stres, dukungan sosial, serta deteksi dini gangguan psikologis menjadi bagian dari peran promotif kebidanan modern.

Pendekatan *family-centered care* memperkuat efektivitas promosi kesehatan reproduksi. Keterlibatan suami dan keluarga dalam konseling antenatal dan keluarga berencana meningkatkan keberlanjutan perilaku sehat (International Confederation of Midwives [ICM], 2023). Dukungan keluarga terbukti berpengaruh terhadap keberhasilan menyusui dan penggunaan kontrasepsi pascapersalinan.

Model berbasis komunitas memperluas cakupan promotif kebidanan. Kegiatan posyandu, kelas ibu hamil, dan kunjungan rumah memungkinkan penyampaian pesan kesehatan secara kontekstual sesuai kebutuhan lokal. Pelibatan kader kesehatan meningkatkan jangkauan intervensi dan memperkuat jejaring dukungan sosial (WHO, 2023).

Pemanfaatan teknologi digital memperkaya strategi promotif dalam kebidanan primer. Media sosial, aplikasi kehamilan, dan pesan pengingat digital meningkatkan akses informasi kesehatan reproduksi. Intervensi mHealth terbukti meningkatkan kepatuhan konsumsi suplementasi zat besi dan kunjungan antenatal (Lee et al., 2022). Adaptasi teknologi mendukung penyampaian pesan promotif yang lebih luas dan interaktif.

Peran promotif kebidanan dalam pelayanan kesehatan primer menunjukkan bahwa pencegahan berbasis edukasi dan pemberdayaan memberikan dampak signifikan terhadap kesehatan ibu dan anak. Integrasi pendekatan berbasis bukti, komunitas, dan digital memperkuat posisi bidan sebagai agen perubahan dalam sistem kesehatan primer yang berorientasi pada perempuan dan keluarga.

E. Preventif Kebidanan dalam Pelayanan Kesehatan Primer

Peran preventif kebidanan dalam pelayanan kesehatan primer berorientasi pada pencegahan komplikasi maternal dan neonatal melalui intervensi sistematis berbasis risiko. Strategi preventif mencakup pencegahan primer, sekunder, dan tersier yang terintegrasi sepanjang siklus reproduksi perempuan. Pendekatan ini selaras dengan prinsip *early detection and timely intervention* dalam sistem pelayanan primer modern (World Health Organization [WHO], 2023).

1. Pencegahan Primer dalam Praktik Kebidanan

Pencegahan primer bertujuan menghindari timbulnya komplikasi sebelum terjadi kondisi patologis. Konseling prakonsepsi menjadi intervensi utama dalam fase ini. Identifikasi faktor risiko seperti obesitas, hipertensi kronis, diabetes, serta riwayat obstetri buruk memungkinkan optimalisasi kesehatan sebelum kehamilan (*American College of Obstetricians and Gynecologists* [ACOG], 2023). Suplementasi asam folat sebelum konsepsi terbukti menurunkan risiko cacat tabung saraf dan komplikasi perkembangan janin.

Program suplementasi zat besi pada remaja dan ibu hamil merupakan strategi preventif primer terhadap anemia maternal. Anemia berhubungan dengan peningkatan risiko perdarahan postpartum dan kelahiran prematur (UNICEF, 2023). Edukasi gizi dan pemantauan status hemoglobin menjadi bagian integral dari praktik kebidanan primer.

Pelayanan keluarga berencana termasuk dalam pencegahan primer. Pengaturan jarak kehamilan minimal 24 bulan menurunkan risiko komplikasi maternal dan neonatal (WHO, 2023). Konseling berbasis bukti mengenai metode kontrasepsi jangka panjang memperkuat perlindungan terhadap kehamilan risiko tinggi.

Imunisasi tetanus toksoid serta vaksinasi sesuai rekomendasi nasional mencegah infeksi yang dapat membahayakan ibu dan bayi. Edukasi mengenai perilaku hidup bersih dan sehat juga merupakan bagian dari strategi preventif primer dalam kebidanan.

2. Pencegahan Sekunder dalam Praktik Kebidanan

Pencegahan sekunder berfokus pada deteksi dini komplikasi melalui skrining dan pemantauan rutin. Pelayanan antenatal berkualitas memungkinkan identifikasi dini hipertensi dalam kehamilan, preeklamsia, anemia, serta diabetes gestasional. Pengukuran tekanan darah, pemeriksaan protein urin, dan skrining glukosa darah menjadi standar praktik berbasis bukti (WHO, 2023).

Pemberian aspirin dosis rendah pada ibu dengan risiko tinggi preeklamsia merupakan rekomendasi terbaru yang terbukti menurunkan kejadian preeklamsia

berat (ACOG, 2023). Pemantauan pertumbuhan janin melalui pengukuran tinggi fundus uteri dan ultrasonografi sesuai indikasi membantu mendeteksi gangguan pertumbuhan intrauterin.

Skrining kesehatan mental perinatal menjadi bagian penting pencegahan sekunder. Identifikasi dini gejala depresi antenatal dan postpartum memungkinkan intervensi psikososial sebelum berkembang menjadi gangguan berat (Howard & Khalifeh, 2020). Integrasi skrining mental dalam pelayanan primer memperluas cakupan preventif kebidanan.

3. Pencegahan Tersier dalam Praktik Kebidanan

Pencegahan tersier bertujuan mencegah komplikasi lanjutan setelah kondisi patologis teridentifikasi. Manajemen aktif kala III menggunakan uterotonika segera setelah persalinan menurunkan risiko perdarahan postpartum secara signifikan (WHO, 2023). Penggunaan partograf dalam pemantauan persalinan membantu deteksi dini partus lama dan mencegah komplikasi obstetri.

Penatalaksanaan hipertensi dalam kehamilan dengan terapi antihipertensi yang tepat mencegah eklampsia dan komplikasi serebrovaskular. Rujukan cepat dan sistem rujukan terintegrasi menjadi komponen penting dalam pencegahan tersier di pelayanan primer.

Perawatan neonatal esensial seperti inisiasi menyusui dini, pencegahan hipotermia, serta deteksi dini infeksi neonatal mengurangi risiko kematian bayi baru lahir (UNICEF, 2023). Konseling kontrasepsi pascapersalinan mencegah kehamilan berulang yang terlalu cepat dan mengurangi risiko maternal pada kehamilan berikutnya.

Tabel 4.2
Spektrum Peran Preventif Kebidanan dalam Pelayanan Primer

Tingkat Pencegahan	Fokus Intervensi	Implementasi Kebidanan
Primer	Mencegah risiko awal	Konseling prakonsepsi, imunisasi, suplementasi Fe
Sekunder	Deteksi dini	Skrining anemia, hipertensi, GDM
Tersier	Mencegah komplikasi lanjutan	Manajemen PPH, rujukan cepat

Peran preventif kebidanan dalam pelayanan kesehatan primer menunjukkan bahwa sebagian besar komplikasi maternal dan neonatal dapat dicegah melalui intervensi sistematis berbasis bukti. Integrasi skrining, edukasi, dan manajemen awal komplikasi menegaskan posisi bidan sebagai garda terdepan dalam sistem pencegahan kesehatan ibu dan anak.

F. Peran Kebidanan dalam Transformasi Digital Pelayanan Kesehatan Primer

Transformasi digital kesehatan menjadi komponen penting dalam penguatan pelayanan kesehatan primer, termasuk dalam praktik kebidanan. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi memungkinkan perluasan akses, peningkatan mutu pelayanan, serta pemantauan kesehatan maternal dan neonatal secara lebih terintegrasi. Strategi digital health global menekankan pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan efektivitas layanan primer dan mempercepat pencapaian *Universal Health Coverage* (World Health Organization [WHO], 2023).

Peran kebidanan dalam transformasi digital tidak hanya sebagai pengguna teknologi, tetapi sebagai agen adaptasi dan inovasi pelayanan. Bidan berkontribusi dalam implementasi telemidwifery, sistem rekam medis elektronik, pemantauan jarak jauh, serta edukasi kesehatan berbasis platform digital. Integrasi teknologi dengan prinsip woman-centered care memastikan bahwa inovasi digital tetap mempertahankan hubungan terapeutik antara bidan dan perempuan.

Telemidwifery menjadi salah satu inovasi utama dalam pelayanan kebidanan primer. Konsultasi antenatal jarak jauh, pemantauan tekanan darah ibu hamil risiko tinggi, serta konseling laktasi daring meningkatkan akses layanan terutama di wilayah terpencil dan kepulauan. Studi menunjukkan bahwa telekonsultasi maternal meningkatkan kepatuhan kunjungan kontrol serta mempercepat deteksi komplikasi hipertensi dalam kehamilan (Lee et al., 2022). Pendekatan ini mengurangi hambatan geografis tanpa mengurangi kualitas komunikasi klinis.

Pemanfaatan rekam medis elektronik (RME) memperkuat kontinuitas asuhan kebidanan. Data kehamilan, riwayat obstetri, hasil laboratorium, serta catatan persalinan terdokumentasi secara sistematis dan dapat diakses lintas fasilitas. Sistem interoperabilitas data meningkatkan kecepatan rujukan dan mengurangi duplikasi pemeriksaan (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2023). Integrasi data maternal-neonatal dalam satu sistem nasional memperkuat pemantauan risiko secara populasi.

Aplikasi kesehatan maternal berbasis mobile (mHealth) memperluas peran promotif dan preventif kebidanan. Fitur pengingat jadwal antenatal, konsumsi tablet tambah darah, imunisasi, serta edukasi tanda bahaya kehamilan membantu meningkatkan literasi kesehatan ibu. Penelitian menunjukkan bahwa intervensi berbasis SMS reminder meningkatkan kepatuhan ibu terhadap kunjungan antenatal dan suplementasi zat besi (Lee et al., 2022). Teknologi sederhana memberikan dampak signifikan terhadap pencegahan komplikasi.

Pemantauan jarak jauh menggunakan perangkat wearable menjadi inovasi yang mulai berkembang dalam kebidanan. Pengukuran tekanan darah dan kadar

glukosa secara mandiri memungkinkan deteksi dini preeklamsia dan diabetes gestasional. Model remote monitoring terbukti menurunkan kebutuhan rawat inap pada kehamilan risiko tinggi serta meningkatkan rasa aman ibu (WHO, 2023).

Media sosial dan platform edukasi digital menjadi sarana strategis dalam promosi kesehatan reproduksi. Bidan dapat menyebarkan informasi berbasis bukti untuk melawan misinformasi kesehatan yang marak di ruang digital. Literasi digital menjadi kompetensi penting dalam memastikan informasi yang disampaikan akurat dan etis (International Confederation of Midwives [ICM], 2023).

Kelas ibu hamil berbasis daring dan model hybrid memperluas jangkauan edukasi. Interaksi virtual memungkinkan partisipasi ibu yang memiliki keterbatasan mobilitas atau tinggal di daerah terpencil. Pendekatan ini terbukti efektif dalam mempertahankan kesinambungan edukasi pada masa pembatasan sosial.

Transformasi digital juga membawa tantangan etika dan keamanan data. Perlindungan privasi informasi kesehatan reproduksi harus menjadi prioritas dalam pengembangan sistem digital. Standar keamanan siber dan regulasi perlindungan data menjadi bagian dari tata kelola pelayanan primer modern.

Peran kebidanan dalam transformasi digital pelayanan kesehatan primer mencerminkan adaptasi profesi terhadap perkembangan ilmu dan teknologi. Integrasi inovasi digital dengan praktik berbasis bukti dan pendekatan human-centered care memperkuat efektivitas intervensi promotif dan preventif. Digitalisasi bukan pengganti hubungan terapeutik, melainkan alat untuk memperluas jangkauan, meningkatkan kualitas, dan memperkuat kesinambungan asuhan kebidanan.

G. Tantangan dalam Penguatan Peran Kebidanan di Pelayanan Kesehatan Primer

Penguatan peran kebidanan dalam pelayanan kesehatan primer menghadapi tantangan multidimensional yang mencakup aspek sistemik, profesional, sosial, dan teknologi. Kompleksitas kebutuhan kesehatan maternal dan neonatal menuntut kesiapan sistem kesehatan yang adaptif serta dukungan kebijakan yang konsisten. Dinamika epidemiologi dan transformasi layanan primer memperlihatkan bahwa penguatan peran bidan tidak hanya berkaitan dengan kompetensi klinis, tetapi juga dengan struktur sistem kesehatan secara menyeluruh.

Distribusi dan pemerataan tenaga bidan masih menjadi tantangan signifikan. Wilayah terpencil, kepulauan, dan daerah dengan akses geografis sulit sering mengalami keterbatasan tenaga kesehatan terlatih. Ketimpangan distribusi ini berdampak pada keterlambatan deteksi risiko kehamilan dan keterbatasan pelayanan preventif (World Health Organization [WHO], 2023). Beban kerja tinggi di

fasilitas primer juga mengurangi waktu yang tersedia untuk konseling promotif yang mendalam.

Penguatan kompetensi berbasis evidence-based practice menjadi tantangan tersendiri. Perkembangan ilmu kebidanan berlangsung cepat, terutama dalam skrining preeklamsia, manajemen diabetes gestasional, kesehatan mental perinatal, dan penggunaan teknologi digital. Akses terhadap pelatihan berkelanjutan dan literatur ilmiah mutakhir belum merata di seluruh wilayah (International Confederation of Midwives [ICM], 2023). Kesenjangan kompetensi berpotensi memengaruhi kualitas intervensi preventif.

Literasi kesehatan masyarakat yang masih rendah menjadi hambatan dalam implementasi strategi promotif dan preventif. Kepercayaan budaya tertentu terkait kehamilan dan persalinan dapat memengaruhi pengambilan keputusan kesehatan. Praktik pernikahan usia dini dan jarak kehamilan yang terlalu dekat masih ditemukan pada beberapa komunitas, meningkatkan risiko komplikasi obstetri (UNICEF, 2023). Pendekatan komunikasi interpersonal yang sensitif budaya menjadi kebutuhan penting dalam konteks ini.

Struktur pembiayaan kesehatan juga memengaruhi penguatan peran kebidanan. Alokasi anggaran yang lebih besar pada layanan kuratif dibandingkan promotif dan preventif menghambat optimalisasi intervensi berbasis pencegahan (World Bank, 2022). Skema pembiayaan berbasis klaim belum sepenuhnya memberikan insentif terhadap kegiatan edukasi dan konseling yang bersifat preventif jangka panjang.

Transformasi digital pelayanan primer menghadirkan tantangan adaptasi teknologi. Keterbatasan infrastruktur internet, literasi digital tenaga kesehatan, serta keamanan data menjadi isu yang perlu diatasi. Integrasi sistem rekam medis elektronik yang belum merata menghambat kesinambungan asuhan kebidanan lintas fasilitas (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2023). Perlindungan privasi informasi kesehatan reproduksi juga memerlukan penguatan regulasi.

Faktor sosial ekonomi turut memengaruhi efektivitas pelayanan primer kebidanan. Kemiskinan dan ketidakstabilan ekonomi mengurangi akses terhadap nutrisi adekuat serta layanan kesehatan berkualitas. Perempuan dengan pendidikan rendah cenderung memiliki literasi kesehatan terbatas yang berdampak pada kepatuhan kunjungan antenatal dan penggunaan kontrasepsi.

Resistensi terhadap perubahan praktik berbasis bukti juga menjadi tantangan internal profesi. Adaptasi terhadap pedoman klinis terbaru dan integrasi teknologi memerlukan perubahan budaya kerja serta dukungan supervisi profesional. Penguatan kepemimpinan kebidanan dalam sistem kesehatan primer menjadi faktor penting dalam mendorong transformasi praktik.

Tantangan tersebut menunjukkan bahwa penguatan peran kebidanan dalam pelayanan kesehatan primer membutuhkan pendekatan sistemik yang terintegrasi. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pembiayaan berbasis pencegahan, penguatan sistem rujukan, serta adaptasi teknologi menjadi strategi kunci dalam mengatasi hambatan yang ada. Komitmen lintas sektor dan dukungan kebijakan yang konsisten menentukan keberhasilan penguatan peran bidan sebagai garda terdepan pelayanan primer.

H. Rekomendasi Penguatan Peran Kebidanan dalam Pelayanan Kesehatan Primer

Penguatan peran kebidanan dalam pelayanan kesehatan primer memerlukan strategi kebijakan yang terstruktur, berbasis bukti, serta selaras dengan transformasi sistem kesehatan nasional dan global. Kompleksitas tantangan maternal dan neonatal menuntut pendekatan komprehensif yang mencakup aspek regulasi, pembiayaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta integrasi teknologi.

Reorientasi kebijakan kesehatan menuju pendekatan promotif dan preventif perlu menjadi prioritas utama. Proporsi pembiayaan untuk intervensi pencegahan maternal, skrining risiko kehamilan, serta edukasi kesehatan reproduksi perlu ditingkatkan agar seimbang dengan layanan kuratif (World Bank, 2022). Skema pembiayaan berbasis kinerja preventif dapat diterapkan melalui indikator seperti cakupan kunjungan antenatal berkualitas, skrining anemia, dan penggunaan kontrasepsi pascapersalinan.

Penguatan kompetensi bidan berbasis evidence-based midwifery menjadi rekomendasi strategis. Program pelatihan berkelanjutan harus mencakup skrining preeklamsia berbasis risiko, manajemen diabetes gestasional, kesehatan mental perinatal, serta penggunaan teknologi digital kesehatan (International Confederation of Midwives [ICM], 2023). Integrasi literasi digital dan telemidwifery dalam kurikulum pendidikan kebidanan memperkuat kesiapan profesi menghadapi transformasi layanan primer.

Standardisasi pedoman klinis nasional yang diperbarui secara berkala perlu diperkuat dengan mekanisme audit maternal dan neonatal di tingkat pelayanan primer. Evaluasi berbasis indikator mutu seperti kepatuhan penggunaan partograf, manajemen aktif kala III, serta skrining depresi postpartum meningkatkan akuntabilitas dan keselamatan pelayanan (World Health Organization [WHO], 2023).

Penguatan sistem rujukan maternal-neonatal menjadi komponen krusial dalam pencegahan tersier. Integrasi sistem informasi kesehatan nasional dengan jejaring rujukan mempercepat koordinasi dan respons kegawatdaruratan. Dukungan transportasi rujukan berbasis komunitas serta kolaborasi lintas sektor mengurangi keterlambatan penanganan komplikasi obstetri.

Digitalisasi pelayanan kebidanan primer memerlukan kebijakan yang menjamin interoperabilitas sistem dan perlindungan data kesehatan reproduksi. Pengembangan platform nasional untuk pemantauan kehamilan risiko tinggi, pengingat kunjungan, serta pelaporan digital mendukung kesinambungan asuhan (WHO, 2023). Pelatihan keamanan siber bagi tenaga kebidanan menjadi bagian dari penguatan sistem digital.

Pendekatan berbasis komunitas perlu diperluas melalui penguatan posyandu, kelas ibu hamil, serta kelompok pendukung menyusui. Kader kesehatan harus mendapatkan pelatihan terstandar dan supervisi berkala untuk memastikan konsistensi pesan promotif. Pelibatan tokoh masyarakat dan organisasi perempuan meningkatkan efektivitas intervensi pada komunitas dengan norma budaya kuat.

Kolaborasi interprofesional dalam pelayanan primer perlu ditingkatkan untuk memastikan kesinambungan asuhan. Sinergi antara bidan, dokter, perawat, ahli gizi, dan tenaga kesehatan lainnya memperkuat manajemen kasus risiko tinggi dan mempercepat pengambilan keputusan klinis. Model collaborative practice meningkatkan mutu pelayanan dan efisiensi sistem.

Pendekatan berbasis determinan sosial kesehatan harus menjadi bagian integral kebijakan kebidanan primer. Intervensi lintas sektor seperti program pencegahan anemia remaja di sekolah, perlindungan sosial bagi ibu rentan, serta peningkatan akses transportasi kesehatan memperkuat dampak jangka panjang terhadap kesehatan maternal.

Pemantauan dan evaluasi berbasis data real-time diperlukan untuk mengukur efektivitas kebijakan. Penggunaan dashboard indikator maternal dan neonatal memungkinkan analisis cepat dan perbaikan berkelanjutan. Transparansi data meningkatkan akuntabilitas sistem dan mendorong inovasi berbasis kebutuhan lapangan.

Rekomendasi penguatan peran kebidanan dalam pelayanan kesehatan primer menegaskan pentingnya pendekatan sistemik dan berkelanjutan. Investasi pada peningkatan kapasitas bidan, digitalisasi layanan, pembiayaan preventif, serta pemberdayaan komunitas menjadi pilar utama dalam memperkuat sistem kesehatan maternal. Komitmen kebijakan yang konsisten dan dukungan lintas sektor menentukan keberhasilan implementasi strategi tersebut dalam jangka panjang.

I. Simpulan

Peran kebidanan dalam pelayanan kesehatan primer memiliki dimensi strategis dalam penguatan sistem kesehatan maternal dan neonatal. Bidan berfungsi sebagai tenaga kesehatan lini pertama yang berinteraksi langsung dengan perempuan sepanjang siklus reproduksi, mulai dari remaja, prakonsepsi, kehamilan, persalinan, hingga masa nifas dan neonatal. Posisi tersebut menempatkan kebidanan sebagai komponen kunci dalam integrasi upaya promotif, preventif, kuratif dasar, dan rehabilitatif di tingkat pelayanan primer.

Perkembangan epidemiologi kesehatan maternal menunjukkan peningkatan kompleksitas risiko akibat penyakit tidak menular, gangguan kesehatan mental perinatal, serta faktor sosial ekonomi. Kondisi ini memperluas cakupan tanggung jawab kebidanan dari pelayanan klinis tradisional menjadi manajemen kesehatan reproduksi yang komprehensif dan berbasis bukti. Implementasi evidence-based midwifery, continuity of care, serta pendekatan woman-centered care terbukti meningkatkan keselamatan ibu dan bayi serta memperkuat kualitas pengalaman persalinan.

Transformasi digital pelayanan kesehatan primer memperkuat efektivitas peran kebidanan melalui telemidwifery, rekam medis elektronik, dan intervensi mHealth. Adaptasi teknologi memperluas jangkauan layanan, meningkatkan kepatuhan terhadap kunjungan antenatal, serta mendukung deteksi dini risiko. Integrasi inovasi digital harus tetap mempertahankan prinsip human-centered care agar hubungan terapeutik antara bidan dan perempuan tetap menjadi inti pelayanan.

Pendekatan berbasis komunitas memperlihatkan bahwa keberhasilan intervensi maternal tidak hanya ditentukan oleh kompetensi klinis, tetapi juga oleh dukungan sosial dan partisipasi keluarga. Pelibatan kader kesehatan, kelas ibu hamil, dan kunjungan rumah memperkuat fungsi promotif dan preventif kebidanan dalam konteks lokal.

Tantangan dalam penguatan peran kebidanan mencakup ketimpangan distribusi tenaga kesehatan, keterbatasan pembiayaan preventif, literasi kesehatan masyarakat yang rendah, serta integrasi sistem informasi yang belum merata. Rekomendasi kebijakan menekankan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pembiayaan berbasis pencegahan, penguatan sistem rujukan, serta digitalisasi layanan yang aman dan terintegrasi.

Peran kebidanan dalam pelayanan kesehatan primer merupakan investasi jangka panjang terhadap kualitas generasi masa depan. Penguatan profesi kebidanan sebagai garda terdepan pelayanan primer berkontribusi langsung

terhadap penurunan angka kematian ibu dan bayi, peningkatan kualitas hidup perempuan, serta pencapaian pembangunan kesehatan berkelanjutan. Komitmen sistem kesehatan dalam memprioritaskan promotif dan preventif menjadi fondasi utama dalam mewujudkan pelayanan kebidanan primer yang responsif, adaptif, dan berkeadilan.

J. Referensi

- American College of Obstetricians and Gynecologists. (2023). Practice bulletin: Gestational diabetes mellitus. ACOG.
- Howard, L. M., & Khalifeh, H. (2020). Perinatal mental health: A review of progress and challenges. *World Psychiatry*, 19(3), 313–327. <https://doi.org/10.1002/wps.20769>
- Institute for Health Metrics and Evaluation. (2023). Global burden of disease study 2023 results. IHME.
- International Confederation of Midwives. (2023). Essential competencies for midwifery practice 2023 update. ICM.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2023). Profil kesehatan Indonesia tahun 2023. Kemenkes RI.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2023). Transformasi sistem kesehatan Indonesia: Pilar layanan primer. Kemenkes RI.
- Lee, S. H., Nurmatov, U. B., Nwaru, B. I., Mukherjee, M., Grant, L., & Pagliari, C. (2022). Effectiveness of mHealth interventions for maternal health: Systematic review and meta-analysis. *Journal of Medical Internet Research*, 24(5), e31241. <https://doi.org/10.2196/31241>
- Nove, A., Friberg, I. K., de Bernis, L., McConville, F., Moran, A. C., Najjemba, M., Ten Hoope-Bender, P., & Homer, C. S. E. (2021). Potential impact of midwives in preventing and reducing maternal and neonatal mortality and stillbirths: A Lives Saved Tool modelling study. *The Lancet Global Health*, 9(1), e24–e32. [https://doi.org/10.1016/S2214-109X\(20\)30397-1](https://doi.org/10.1016/S2214-109X(20)30397-1)
- Nutbeam, D. (2022). Health literacy as a public health goal: Contemporary perspectives. *Health Promotion International*, 37(2), daac012. <https://doi.org/10.1093/heapro/daac012>
- Reed, R., Sharman, R., & Inglis, C. (2021). Women's experiences of midwifery continuity of care: A systematic review. *Midwifery*, 94, 102930. <https://doi.org/10.1016/j.midw.2020.102930>
- Sandall, J., Fernandez Turienzo, C., Devane, D., Soltani, H., & Gates, S. (2022). Midwife-led continuity models versus other models of care for

- childbearing women. Cochrane Database of Systematic Reviews, 2022(4), CD004667. <https://doi.org/10.1002/14651858.CD004667.pub6>
- Solar, O., & Irwin, A. (2021). A conceptual framework for action on the social determinants of health. World Health Organization.
- UNICEF. (2023). State of the world's children 2023: For every child, nutrition. UNICEF.
- United Nations. (2023). Trends in maternal mortality 2000–2023: Estimates by WHO, UNICEF, UNFPA, World Bank Group and the United Nations Population Division. United Nations.
- World Bank. (2022). Indonesia health expenditure review: Investing in prevention for sustainable health financing. World Bank Group.
- World Health Organization. (2022). Maternal mental health and child health outcomes: Global update. WHO.
- World Health Organization. (2023). Digital health global strategy progress report. WHO.
- World Health Organization. (2023). Primary health care and universal health coverage monitoring report. WHO.
- World Health Organization. (2023). WHO guideline on prevention of postpartum haemorrhage. WHO.
- World Health Organization. (2023). WHO recommendations on antenatal care for a positive pregnancy experience (updated guideline). WHO.

K. Glosarium

- Anemia Maternal : Kondisi kadar hemoglobin ibu hamil di bawah batas normal (<11 g/dL) yang berisiko meningkatkan perdarahan postpartum dan kelahiran prematur.
- Antenatal Care (ANC) : Pelayanan kesehatan yang diberikan kepada ibu hamil secara berkala untuk memantau kondisi ibu dan janin serta mendeteksi dini komplikasi kehamilan.
- Continuity of Midwifery Care : Model asuhan kebidanan berkelanjutan yang diberikan oleh bidan yang sama atau tim kecil bidan sejak prakonsepsi hingga periode postpartum.
- Diabetes Gestasional : Gangguan toleransi glukosa yang pertama kali terdeteksi selama kehamilan dan berisiko terhadap komplikasi maternal dan neonatal.
- Digital Health : Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan akses, kualitas, dan efisiensi pelayanan kesehatan.
- Evidence-Based Midwifery : Praktik kebidanan yang mengintegrasikan bukti ilmiah terbaru, pengalaman klinis profesional, serta nilai dan preferensi perempuan dalam pengambilan keputusan pelayanan.

Kesehatan Mental Perinatal : Kondisi kesehatan psikologis ibu selama masa kehamilan hingga satu tahun setelah persalinan.

Life-Course Approach : Pendekatan kesehatan yang menekankan intervensi berkelanjutan sejak masa remaja, prakonsepsi, kehamilan, hingga usia lanjut.

Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) : Metode kontrasepsi efektif dengan durasi panjang seperti implan dan alat kontrasepsi dalam rahim (AKDR/IUD).

mHealth (Mobile Health) : Penggunaan perangkat mobile seperti telepon seluler untuk mendukung edukasi, pemantauan, dan pengingat layanan kesehatan.

Preeklamsia : Komplikasi kehamilan yang ditandai dengan hipertensi dan proteinuria setelah usia kehamilan 20 minggu.

Preventif : Upaya pencegahan penyakit melalui intervensi primer, sekunder, dan tersier.

Primary Health Care (PHC) : Pendekatan pelayanan kesehatan komprehensif dan terjangkau yang berfokus pada pencegahan, promosi, dan pemberdayaan masyarakat.

Promotif : Upaya peningkatan kapasitas individu dan masyarakat untuk menjaga serta meningkatkan kesehatan.

Rekam Medis Elektronik (RME) : Sistem pencatatan data kesehatan pasien secara digital dan terintegrasi.

Telemidwifery : Pelayanan kebidanan jarak jauh melalui media digital untuk konsultasi dan pemantauan kesehatan ibu.

Universal Health Coverage (UHC) : Sistem jaminan kesehatan yang memastikan seluruh masyarakat memperoleh layanan kesehatan yang dibutuhkan tanpa mengalami kesulitan finansial.

CHAPTER 5

KONTRIBUSI KEPERAWATAN DALAM PELAYANAN KESEHATAN PRIMER

Dr. Susi Milwati, S.Kp., M.Pd.

A. Pendahuluan

Hipertensi merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat yang hingga saat ini masih menjadi perhatian utama dalam sistem pelayanan kesehatan global maupun nasional. Penyakit ini berkontribusi besar terhadap meningkatnya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit kardiovaskular, seperti stroke dan penyakit jantung koroner. Karakteristik hipertensi yang bersifat kronis dan sering berkembang tanpa gejala yang jelas pada tahap awal menyebabkan banyak individu tidak menyadari kondisi kesehatannya. Oleh karena itu, hipertensi dikenal sebagai *silent disease* yang memerlukan upaya pengendalian sejak dini melalui pendekatan kesehatan masyarakat yang terencana dan berkelanjutan (World Health Organization, 2023).

Sebagai masalah kesehatan masyarakat, hipertensi tidak hanya berdampak pada kondisi fisik individu, tetapi juga memberikan beban yang signifikan terhadap sistem pelayanan kesehatan dan pembangunan nasional. Hipertensi berkaitan erat dengan meningkatnya kebutuhan pelayanan kesehatan jangka panjang, penggunaan obat secara terus-menerus, serta penurunan produktivitas akibat komplikasi yang ditimbulkan. Kondisi ini menjadikan pengendalian hipertensi sebagai salah satu prioritas utama dalam program pengendalian penyakit tidak menular, khususnya melalui upaya pencegahan primer dan sekunder di tingkat pelayanan kesehatan dasar (Mills et al., 2020).

Dalam konteks pelayanan kesehatan primer, hipertensi ringan merupakan klasifikasi hipertensi yang paling sering ditemukan. Hipertensi ringan menggambarkan kondisi peningkatan tekanan darah yang belum disertai dengan kerusakan organ target, sehingga sering kali dianggap sebagai kondisi yang tidak berbahaya dan belum memerlukan perhatian khusus. Namun, berbagai bukti ilmiah menunjukkan bahwa hipertensi ringan yang tidak ditangani secara tepat dapat berkembang menjadi hipertensi derajat lebih berat dan secara signifikan meningkatkan risiko terjadinya komplikasi kardiovaskular di kemudian hari (Whelton et al., 2018).

Peningkatan prevalensi hipertensi ringan di layanan primer tidak terlepas dari perubahan pola hidup masyarakat modern, seperti konsumsi makanan tinggi garam dan lemak, kurangnya aktivitas fisik, meningkatnya tingkat stres, serta perubahan pola kerja dan istirahat. Kondisi ini semakin banyak dijumpai pada kelompok usia dewasa produktif dan lansia awal yang melakukan kunjungan ke Puskesmas. Fakta tersebut menunjukkan bahwa hipertensi ringan bukan lagi semata-mata masalah kesehatan usia lanjut, melainkan telah menjadi masalah kesehatan lintas kelompok usia yang memerlukan intervensi sejak tahap awal (Kementerian Kesehatan RI, 2022).

Apabila hipertensi ringan tidak ditangani secara optimal, kondisi ini dapat memberikan dampak jangka panjang yang merugikan. Tekanan darah yang terus meningkat secara perlahan dapat menyebabkan kerusakan organ target, seperti jantung, ginjal, otak, dan pembuluh darah, meskipun pada awalnya tidak menimbulkan gejala klinis yang nyata. Selain itu, progresivitas hipertensi ringan juga berkontribusi terhadap menurunnya kualitas hidup pasien serta meningkatnya risiko kecacatan dan kematian akibat komplikasi kardiovaskular (Smeltzer et al., 2020).

Dari perspektif kesehatan masyarakat, hipertensi ringan juga memberikan beban penyakit dan biaya kesehatan yang tidak kecil. Peningkatan jumlah penderita hipertensi berimplikasi pada meningkatnya biaya pelayanan kesehatan, baik untuk pemeriksaan rutin, pengobatan jangka panjang, maupun penanganan komplikasi. Beban ekonomi ini tidak hanya dirasakan oleh individu dan keluarga, tetapi juga oleh sistem jaminan kesehatan nasional, sehingga pengendalian hipertensi sejak tahap ringan menjadi strategi yang penting dan cost-effective (Mills et al., 2020).

Puskesmas memiliki peran strategis dalam upaya deteksi dini dan pengendalian hipertensi ringan karena merupakan fasilitas kesehatan tingkat pertama yang paling dekat dengan masyarakat. Melalui kegiatan skrining rutin, pemantauan tekanan darah, serta pelayanan promotif dan preventif, Puskesmas menjadi garda terdepan dalam mengidentifikasi peningkatan tekanan darah sejak dini. Pendekatan ini memungkinkan dilakukannya intervensi awal yang dapat mencegah progresivitas hipertensi dan menurunkan risiko komplikasi di masa mendatang (World Health Organization, 2023).

Selain deteksi dini, Puskesmas juga berperan penting dalam pengendalian hipertensi ringan melalui edukasi kesehatan dan pendampingan perubahan perilaku pasien. Intervensi nonfarmakologis, seperti edukasi pola makan sehat, peningkatan aktivitas fisik, pengelolaan stres, dan pembinaan kepatuhan terhadap gaya hidup sehat, merupakan strategi utama dalam pengelolaan hipertensi ringan di layanan primer. Pendekatan ini terbukti efektif dalam menurunkan tekanan darah dan mengurangi ketergantungan terhadap terapi farmakologis apabila dilakukan secara konsisten (Whelton et al., 2018).

Dalam pelaksanaan pelayanan tersebut, tenaga keperawatan memiliki posisi yang sangat strategis. Perawat berperan sebagai pelaksana asuhan keperawatan, edukator kesehatan, dan pendamping pasien dalam proses perubahan perilaku. Peran perawat dalam kegiatan promotif dan preventif menjadi kunci keberhasilan pengendalian hipertensi ringan, mengingat perawat memiliki intensitas interaksi yang tinggi dengan pasien dan keluarga di Puskesmas (Potter et al., 2021).

Pendekatan asuhan keperawatan berbasis komunitas semakin memperkuat peran perawat dalam pengendalian hipertensi ringan. Melalui pendekatan ini, perawat tidak hanya berfokus pada individu, tetapi juga melibatkan keluarga dan lingkungan sebagai bagian dari sistem pendukung perubahan perilaku. Pemberdayaan masyarakat dan keluarga dalam pengelolaan hipertensi ringan menjadi strategi penting untuk mencapai keberlanjutan hasil asuhan keperawatan di tingkat pelayanan primer (Smeltzer et al., 2020).

Dengan demikian, pembahasan mengenai hipertensi ringan di Puskesmas menjadi sangat relevan untuk disajikan dalam buku ini. Pendahuluan ini menegaskan bahwa hipertensi ringan merupakan masalah kesehatan masyarakat yang signifikan, memiliki dampak jangka panjang dan beban ekonomi yang besar, serta memerlukan peran strategis Puskesmas dan tenaga keperawatan dalam deteksi dini dan pengendaliannya. Pemahaman yang komprehensif terhadap aspek tersebut diharapkan dapat memperkuat kompetensi mahasiswa Keperawatan dalam memberikan asuhan keperawatan yang profesional, preventif, dan berbasis komunitas di layanan kesehatan primer.

B. Konsep Dasar Hipertensi Ringan

1. Definisi dan Klasifikasi Hipertensi

Hipertensi adalah suatu kondisi medis di mana tekanan darah dalam arteri tetap lebih tinggi dari nilai normal dalam jangka waktu yang konsisten, yang ditentukan berdasarkan pengukuran sistolik dan diastolik pada beberapa kesempatan terpisah. Tekanan darah dinyatakan dalam dua angka—angka atas yang menunjukkan tekanan saat jantung berkontraksi (sistolik) dan angka bawah yang menunjukkan tekanan saat jantung berelaksasi (diastolik). Nilai ini menjadi dasar untuk menentukan apakah seseorang memiliki tekanan darah tinggi (*hypertension*) atau tidak (World Health Organization, 2025).

Dalam kebijakan klinik modern, klasifikasi hipertensi dirumuskan berdasarkan ambang tekanan darah yang telah menunjukkan risiko komplikasi kardiovaskular dan mortalitas. Menurut American Heart Association (AHA) dan banyak pedoman internasional terkini, tekanan darah normal pada orang dewasa adalah di bawah 120/80 mmHg. Hipertensi *tahap 1* (yang sering disebut juga

hipertensi ringan) didefinisikan sebagai tekanan sistolik antara 130–139 mmHg atau tekanan diastolik antara 80–89 mmHg pada pengukuran yang konsisten. Kategori ini menunjukkan peningkatan risiko vaskular, namun belum setinggi kategori hipertensi lebih berat (*stage 2*) yang berada pada tekanan $\geq 140/90$ mmHg dan memerlukan penatalaksanaan yang lebih agresif (UGM, 2025; WHO, 2025).

Klasifikasi hipertensi juga dapat dilihat dari perspektif nasional seperti pedoman Kementerian Kesehatan RI yang mengadopsi nilai diagnosis berdasarkan tekanan darah $\geq 140/90$ mmHg untuk hipertensi derajat 1 pada layanan kesehatan primer. Namun, dalam praktik klinik modern dan deteksi dini, batas bawah *stage 1* hipertensi kerap dimulai pada 130/80 mmHg karena bukti hubungan risiko meningkatnya beban vaskular di ambang tersebut. Kategori ini penting terutama untuk deteksi dan edukasi pasien di level Puskesmas sebelum komplikasi organ target terjadi.

2. Etiologi dan Faktor Risiko

Hipertensi merupakan kondisi multifaktorial, yang berarti penyebabnya berkaitan dengan banyak faktor lingkungan, perilaku, dan genetik. Etiologi hipertensi dapat dibagi menjadi dua kelompok besar, yakni hipertensi primer (esensial) dan hipertensi sekunder. Hipertensi primer adalah jenis yang paling umum—lebih dari 90% kasus hipertensi tidak memiliki penyebab tunggal yang jelas dan lebih dipengaruhi oleh kombinasi faktor risiko internal dan eksternal. Sementara itu, hipertensi sekunder disebabkan oleh kondisi medis yang spesifik seperti penyakit ginjal, gangguan hormonal, atau pemakaian obat tertentu yang mempengaruhi regulasi tekanan darah (*secondary causes*) (WHO, 2025).

Faktor risiko hipertensi yang dapat dimodifikasi mencakup perilaku dan kondisi yang dapat diubah melalui intervensi. Ini meliputi diet tidak sehat (seperti konsumsi garam berlebih dan pola makan tinggi lemak jenuh), kurangnya aktivitas fisik, obesitas, konsumsi alkohol, penggunaan tembakau, serta stres psikososial yang berkepanjangan. Pola hidup sedentari dan kebiasaan makan yang buruk secara konsisten dikaitkan dengan peningkatan tekanan darah karena mekanisme volume darah dan respons vaskular yang terganggu (*modifiable risk factors*) (WHO, 2025).

Di sisi lain, terdapat faktor risiko yang tidak dapat dimodifikasi, termasuk usia, riwayat keluarga/keturunan (genetik), dan ras. Seiring bertambahnya usia, struktur pembuluh darah berubah elastisitas arteri menurun dan dinding vaskular menjadi lebih kaku, yang berkontribusi pada peningkatan resistensi perifer dan tekanan darah. Riwayat keluarga hipertensi menunjukkan kecenderungan genetik yang meningkatkan kerentanan individu terhadap tekanan darah tinggi, terutama

bila dipadukan dengan lingkungan dan perilaku yang kurang sehat (*non-modifiable risk factors*) (WHO, 2025).

3. Patofisiologi Hipertensi Ringan (Ringkas dan Aplikatif)

Patofisiologi hipertensi melibatkan mekanisme kompleks yang mencerminkan perubahan dalam regulasi tekanan darah oleh sistem kardiovaskular dan ginjal. Pada tingkat fisiologis, tekanan darah ditentukan oleh output jantung dan resistensi perifer total. Interaksi antara sistem saraf otonom, komponen darah, renin-angiotensin-aldosteron system (RAAS), serta fungsi endotel memainkan peran penting dalam mempertahankan tekanan darah dalam kisaran normal. Ketidakseimbangan dalam sistem-sistem ini dapat menyebabkan peningkatan vaskular resistensi atau volume darah, yang mengarah pada hipertensi (*Elevated Blood Pressure*) (Mathur et al., 2025).

Salah satu mekanisme utama yang berkontribusi pada hipertensi ringan adalah aktivasi sistem saraf simpatik yang berlebihan, yang menyebabkan vasokonstriksi dan peningkatan denyut jantung. Selain itu, disfungsi endotel vaskular dapat mengurangi produksi vasodilator seperti *nitric oxide*, sehingga pembuluh darah lebih rentan mengalami vasokonstriksi kronis. RAAS yang terlalu aktif juga meningkatkan retensi natrium dan air oleh ginjal, memperbesar volume darah dan tekanan pada dinding arteri (*volume overload*), yang selanjutnya mempertahankan atau memperburuk tekanan darah tinggi. Interaksi berbagai mekanisme ini bersifat progresif dan sering diamati pada fase awal tekanan darah meningkat seperti pada hipertensi ringan (*stage 1*) (Mathur et al., 2025).

Implikasi klinis hipertensi ringan relatif sering tidak disertai gejala nyata, namun secara fisiologis kondisi ini sudah mencerminkan gangguan regulasi tekanan darah yang kronis. Karena perubahan awal masih bersifat reversibel dengan modifikasi gaya hidup, fase hipertensi ringan menjadi target penting bagi intervensi preventif, termasuk perubahan diet, peningkatan aktivitas fisik, pengelolaan stres, serta pengawasan medis teratur agar tidak berkembang menjadi hipertensi derajat lebih tinggi yang lebih sulit dikendalikan.

C. Gambaran Hipertensi Ringan Di Puskesmas

1. Karakteristik Pasien Hipertensi Ringan

Pasien hipertensi ringan yang dijumpai di Puskesmas umumnya berasal dari kelompok usia dewasa hingga lanjut usia, dengan kecenderungan peningkatan prevalensi seiring bertambahnya umur. Proses penuaan menyebabkan perubahan struktural dan fungsional pembuluh darah, seperti penurunan elastisitas arteri, yang berkontribusi terhadap peningkatan tekanan darah sistolik. Studi epidemiologi terbaru menunjukkan bahwa hipertensi tahap awal paling banyak

ditemukan pada kelompok usia produktif akhir hingga lansia awal, sehingga memiliki implikasi besar terhadap beban pelayanan kesehatan primer (WHO, 2023; Kemenkes RI, 2023).

Dari aspek jenis kelamin, hipertensi ringan di layanan primer sering ditemukan baik pada laki-laki maupun perempuan, dengan variasi dominansi yang dipengaruhi oleh faktor hormonal dan gaya hidup. Pada laki-laki usia dewasa, hipertensi sering berkaitan dengan kebiasaan merokok, konsumsi alkohol, dan aktivitas fisik yang rendah. Sementara itu, pada perempuan, risiko meningkat setelah menopause akibat berkurangnya efek protektif hormon estrogen terhadap sistem kardiovaskular. Perbedaan karakteristik ini penting dipahami oleh tenaga kesehatan untuk merancang pendekatan edukasi yang lebih spesifik dan efektif (Mills et al., 2020).

Gaya hidup merupakan karakteristik dominan yang melekat pada pasien hipertensi ringan di Puskesmas. Pola makan tinggi garam dan lemak, kurangnya aktivitas fisik, stres psikososial, serta kebiasaan merokok masih banyak ditemukan pada pasien. Kondisi ini diperparah oleh rendahnya kesadaran pasien bahwa hipertensi ringan merupakan kondisi yang memerlukan pengelolaan jangka panjang, bukan sekadar gangguan sementara. Oleh karena itu, pemetaan karakteristik gaya hidup menjadi dasar penting dalam perencanaan intervensi promotif dan preventif di tingkat layanan primer (Kemenkes RI, 2023).

Pola kunjungan pasien hipertensi ringan ke Puskesmas umumnya bersifat tidak teratur dan sering kali dipengaruhi oleh munculnya keluhan subjektif. Banyak pasien hanya datang saat merasakan pusing, lemas, atau keluhan lain, meskipun secara klinis hipertensi ringan sering tidak menunjukkan gejala. Kepatuhan berobat juga masih menjadi tantangan, baik dalam hal kepatuhan minum obat maupun kepatuhan menjalani perubahan gaya hidup. Rendahnya kepatuhan ini berkaitan dengan persepsi pasien bahwa tekanan darahnya “belum terlalu tinggi” sehingga belum memerlukan penanganan serius (Burnier & Egan, 2019).

2. Temuan Klinis dan Pemeriksaan Dasar

Temuan klinis pada pasien hipertensi ringan di Puskesmas umumnya minimal atau bahkan tidak spesifik. Sebagian besar pasien berada dalam kondisi asimtomatik, sehingga hipertensi sering terdeteksi secara tidak sengaja saat pemeriksaan rutin atau kunjungan untuk keluhan lain. Keluhan yang kadang muncul meliputi sakit kepala ringan, rasa berat di tengkuk, mudah lelah, atau pusing, namun keluhan tersebut tidak selalu berkorelasi langsung dengan tingkat tekanan darah. Kondisi ini menegaskan pentingnya skrining tekanan darah secara rutin di layanan primer (WHO, 2023).

Pengukuran tekanan darah yang benar merupakan komponen utama dalam penegakan diagnosis hipertensi ringan di Puskesmas. Pengukuran harus dilakukan dengan alat yang terkalibrasi, posisi pasien duduk dengan nyaman, lengan sejajar jantung, serta setelah pasien beristirahat minimal lima menit. Selain itu, diagnosis hipertensi tidak ditegakkan hanya berdasarkan satu kali pengukuran, melainkan melalui pengukuran berulang pada waktu yang berbeda untuk memastikan konsistensi nilai tekanan darah. Kesalahan teknik pengukuran dapat menyebabkan salah klasifikasi dan berdampak pada keputusan klinis yang kurang tepat (Whelton et al., 2022).

Selain pengukuran tekanan darah, pemeriksaan penunjang sederhana juga dilakukan di Puskesmas untuk menilai faktor risiko dan kemungkinan komplikasi awal. Pemeriksaan tersebut meliputi pengukuran berat badan dan indeks massa tubuh (IMT), pemeriksaan lingkar perut, serta pemeriksaan laboratorium dasar seperti kadar gula darah sewaktu dan kolesterol total bila tersedia. Pemeriksaan ini bertujuan untuk mengidentifikasi komorbid yang sering menyertai hipertensi, seperti diabetes melitus dan dislipidemia, sehingga penatalaksanaan dapat dilakukan secara komprehensif dan terintegrasi (Kemenkes RI, 2023).

3. Permasalahan Umum di Layanan Primer

Salah satu permasalahan utama dalam penanganan hipertensi ringan di Puskesmas adalah rendahnya kepatuhan pasien terhadap anjuran terapi. Banyak pasien tidak mengonsumsi obat secara teratur atau menghentikan pengobatan sendiri ketika tekanan darah dirasa sudah menurun. Selain itu, perubahan gaya hidup yang dianjurkan, seperti diet rendah garam dan peningkatan aktivitas fisik, sering kali tidak dijalankan secara konsisten. Faktor pengetahuan, motivasi, serta dukungan keluarga sangat mempengaruhi tingkat kepatuhan pasien dalam pengelolaan hipertensi jangka panjang (Burnier & Egan, 2019).

Permasalahan lain yang sering dihadapi adalah keterbatasan edukasi kesehatan yang berkesinambungan. Keterbatasan waktu pelayanan, jumlah tenaga kesehatan, serta tingginya beban kunjungan pasien menyebabkan edukasi hipertensi sering dilakukan secara singkat dan belum terstruktur. Padahal, edukasi yang efektif memegang peranan penting dalam meningkatkan kesadaran pasien tentang risiko hipertensi ringan dan pentingnya pengendalian sejak dini. Tanpa edukasi yang memadai, pasien cenderung menganggap hipertensi ringan sebagai kondisi yang tidak berbahaya (WHO, 2023).

Selain edukasi, keterbatasan monitoring dan tindak lanjut juga menjadi tantangan di layanan primer. Sistem pencatatan dan pemantauan tekanan darah pasien hipertensi ringan belum sepenuhnya optimal di beberapa Puskesmas, sehingga sulit untuk menilai perkembangan kondisi pasien secara longitudinal.

Kondisi ini dapat menghambat deteksi dini perburukan tekanan darah dan keterlibatan pasien dalam program pengelolaan penyakit kronis. Oleh karena itu, penguatan sistem monitoring dan pendekatan berbasis komunitas menjadi strategi penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan hipertensi di tingkat primer (Kemenkes RI, 2023).

D. Manajemen Asuhan Keperawatan Hipertensi Ringan (Berbasis Sdki–Slki–Siki)

1. Pengkajian Keperawatan

Pengkajian keperawatan pada pasien hipertensi ringan di Puskesmas dilakukan secara komprehensif untuk mengidentifikasi masalah aktual maupun risiko yang mungkin terjadi. Pada tahap ini, perawat mengumpulkan data subjektif dan objektif sebagai dasar penegakan diagnosa keperawatan sesuai Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia (SDKI). Mengingat hipertensi ringan sering tidak menimbulkan gejala yang jelas, pengkajian menjadi kunci utama dalam deteksi dini dan pencegahan komplikasi (Kemenkes RI, 2023).

Data subjektif meliputi keluhan yang dirasakan pasien, seperti sakit kepala ringan, pusing, rasa berat di tengkuk, atau cepat lelah, meskipun sebagian pasien menyatakan tidak merasakan keluhan apa pun. Selain itu, perawat perlu mengkaji tingkat pengetahuan pasien tentang hipertensi, persepsi terhadap penyakit, kepatuhan terhadap pengobatan, serta motivasi pasien dalam menjalani perubahan gaya hidup. Persepsi yang keliru, seperti anggapan bahwa hipertensi ringan tidak berbahaya, sering ditemukan pada pasien di layanan primer (WHO, 2023).

Data objektif difokuskan pada pengukuran tekanan darah yang dilakukan secara benar dan berulang, pemeriksaan tanda-tanda vital, serta penilaian status antropometri seperti berat badan, indeks massa tubuh, dan lingkar perut. Perawat juga mengkaji hasil pemeriksaan penunjang sederhana yang tersedia di Puskesmas, seperti kadar gula darah dan kolesterol, untuk mengidentifikasi faktor risiko kardiovaskular yang menyertai hipertensi ringan (Whelton et al., 2022).

Pengkajian riwayat gaya hidup dan psikososial menjadi bagian integral dalam asuhan keperawatan hipertensi ringan. Perawat menilai pola makan, konsumsi garam, aktivitas fisik, kebiasaan merokok, tingkat stres, serta dukungan keluarga. Faktor-faktor tersebut berperan besar dalam terjadinya dan berlanjutnya hipertensi, sehingga hasil pengkajian menjadi dasar dalam penyusunan intervensi keperawatan yang individual dan berbasis komunitas (Kemenkes RI, 2023).

2. Diagnosa Keperawatan (SDKI)

Berdasarkan hasil pengkajian, diagnosa keperawatan yang sering ditegakkan pada pasien hipertensi ringan di Puskesmas mengacu pada Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia (SDKI). Salah satu diagnosa yang umum adalah Risiko perfusi jaringan tidak efektif, yang berhubungan dengan peningkatan tekanan darah secara persisten. Meskipun belum terjadi gangguan organ target, kondisi ini menempatkan pasien pada risiko terjadinya gangguan aliran darah jaringan apabila tekanan darah tidak dikendalikan secara adekuat (PPNI, 2021).

Diagnosa lain yang sering muncul adalah Defisit pengetahuan, yang berhubungan dengan kurang terpapar informasi tentang hipertensi, penyebab, dan cara pengelolaannya. Diagnosa ini ditandai dengan ketidakmampuan pasien menjelaskan makna hipertensi, tujuan pengobatan, serta pentingnya perubahan gaya hidup sehat. Defisit pengetahuan merupakan masalah dominan di layanan primer dan berkontribusi langsung terhadap rendahnya kepatuhan pasien dalam pengelolaan hipertensi jangka panjang (Burnier & Egan, 2019).

Pada kondisi tertentu, perawat juga dapat menetapkan diagnosa lain seperti Ketidakefektifan manajemen kesehatan, tergantung pada hasil pengkajian dan respons individu pasien. Penetapan diagnosa yang tepat dan sesuai SDKI menjadi dasar utama dalam penyusunan luaran dan intervensi keperawatan yang terstandar.

3. Perencanaan Keperawatan (SLKI)

Perencanaan keperawatan disusun berdasarkan diagnosa keperawatan yang telah ditegakkan, dengan mengacu pada Standar Luaran Keperawatan Indonesia (SLKI). Luaran keperawatan ditetapkan untuk menilai keberhasilan asuhan secara objektif dan terukur.

Luaran utama yang diharapkan pada pasien hipertensi ringan meliputi Status tekanan darah dengan kriteria hasil tekanan darah berada dalam batas target atau menunjukkan kecenderungan stabil. Selain itu, luaran Pengetahuan tentang hipertensi juga menjadi fokus, yang ditandai dengan kemampuan pasien menjelaskan pengertian hipertensi, faktor risiko, serta upaya pengendaliannya. Luaran lain yang relevan adalah Perilaku kepatuhan pengobatan, yang mencerminkan keterlibatan aktif pasien dalam pemantauan tekanan darah dan penerapan gaya hidup sehat (PPNI, 2022).

Tujuan jangka pendek diarahkan pada peningkatan pengetahuan dan kesadaran pasien terhadap kondisi hipertensi ringan, serta kemampuan pasien memantau tekanan darah secara rutin. Tujuan jangka panjang difokuskan pada tercapainya pengendalian tekanan darah yang optimal dan pencegahan

komplikasi kardiovaskular. Perencanaan yang berbasis SLKI memungkinkan evaluasi asuhan dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan (WHO, 2023).

4. Implementasi Keperawatan (SIKI)

Implementasi keperawatan pada pasien hipertensi ringan dilaksanakan berdasarkan Standar Intervensi Keperawatan Indonesia (SIKI) yang relevan dengan luaran yang telah ditetapkan. Salah satu intervensi utama adalah Pemantauan tekanan darah, yang dilakukan secara berkala dengan teknik yang benar untuk menilai respons pasien terhadap intervensi keperawatan dan terapi medis (Whelton et al., 2022).

Intervensi Edukasi kesehatan juga menjadi tindakan keperawatan yang esensial. Perawat memberikan edukasi tentang pengertian hipertensi, faktor risiko, pentingnya diet rendah garam, peningkatan aktivitas fisik, serta pengelolaan stres. Edukasi dilakukan secara bertahap dan disesuaikan dengan tingkat pemahaman serta latar belakang sosial budaya pasien agar pesan yang disampaikan dapat diterima dan diterapkan secara optimal (Kemenkes RI, 2023).

Selain itu, perawat melaksanakan intervensi Manajemen gaya hidup, yang mencakup konseling dan motivasi untuk perubahan perilaku sehat. Perawat juga melakukan intervensi Kolaborasi terapi, bekerja sama dengan dokter dan tenaga kesehatan lain dalam pelaksanaan terapi farmakologis dan nonfarmakologis. Pendekatan kolaboratif ini penting untuk memastikan pengelolaan hipertensi ringan dilakukan secara komprehensif di layanan primer (WHO, 2023).

5. Evaluasi Asuhan Keperawatan

Evaluasi asuhan keperawatan dilakukan dengan membandingkan kondisi pasien dengan luaran keperawatan yang telah ditetapkan dalam SLKI. Evaluasi mencakup penilaian terhadap perubahan tekanan darah, peningkatan pengetahuan pasien tentang hipertensi, serta perubahan perilaku dalam menerapkan gaya hidup sehat. Hasil evaluasi dapat dikategorikan sebagai meningkat, stabil, atau menurun sesuai indikator yang digunakan (PPNI, 2022).

Apabila luaran belum tercapai, perawat perlu melakukan modifikasi rencana asuhan keperawatan dengan menyesuaikan intervensi yang diberikan. Evaluasi juga menjadi dasar dalam menentukan tindak lanjut pasien di Puskesmas, termasuk penjadwalan kunjungan ulang dan keterlibatan pasien dalam program pengelolaan penyakit kronis. Dengan evaluasi yang sistematis dan berkelanjutan, asuhan keperawatan hipertensi ringan dapat memberikan dampak nyata dalam pencegahan komplikasi jangka panjang (Kemenkes RI, 2023).

E. Edukasi Pola Hidup Sehat Pada Pasien Hipertensi Ringan

Edukasi pola hidup sehat merupakan komponen utama dalam pengelolaan hipertensi ringan, khususnya di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama seperti Puskesmas. Pada kondisi hipertensi ringan, pasien sering tidak merasakan keluhan yang bermakna sehingga motivasi untuk melakukan pengendalian tekanan darah cenderung rendah. Oleh karena itu, intervensi edukatif menjadi strategi kunci dalam meningkatkan pengetahuan, membentuk sikap positif, dan mendorong perubahan perilaku kesehatan secara berkelanjutan. Dalam kerangka asuhan keperawatan, edukasi pola hidup sehat termasuk dalam intervensi SIKI: Edukasi Kesehatan, dengan target luaran SLKI: Pengetahuan meningkat, Perilaku hidup sehat meningkat, dan Kepatuhan pengobatan meningkat, yang berangkat dari diagnosis SDKI: Defisit pengetahuan, Manajemen kesehatan tidak efektif, atau Risiko tekanan darah tidak stabil (Kemenkes RI, 2023; WHO, 2023).

1. Konsep Edukasi Kesehatan di Puskesmas

Edukasi kesehatan di Puskesmas dilaksanakan berdasarkan prinsip promotif dan preventif dengan pendekatan berkesinambungan, partisipatif, dan kontekstual. Perawat berperan sebagai edukator yang membantu pasien memahami kondisi kesehatannya, faktor risiko yang dimiliki, serta langkah-langkah pengendalian yang dapat dilakukan secara mandiri. Edukasi yang efektif tidak hanya berfokus pada transfer informasi, tetapi juga bertujuan membentuk kesadaran dan tanggung jawab pasien terhadap kesehatannya sendiri (Kemenkes RI, 2023).

Prinsip komunikasi efektif menjadi landasan utama dalam pelaksanaan edukasi kesehatan. Perawat perlu menggunakan bahasa yang sederhana, jelas, dan sesuai dengan tingkat pendidikan pasien, serta menghindari penggunaan istilah medis yang sulit dipahami. Komunikasi dua arah, sikap empatik, serta penggunaan teknik *teach back* untuk memastikan pemahaman pasien terbukti meningkatkan keterlibatan dan kepatuhan pasien dalam pengelolaan hipertensi ringan (Arnold & Boggs, 2020; Stuart, 2021).

Selain itu, edukasi kesehatan di Puskesmas perlu mengintegrasikan pendekatan berbasis keluarga dan komunitas. Keterlibatan keluarga berperan penting dalam menciptakan lingkungan yang mendukung perubahan gaya hidup, terutama terkait pola makan dan aktivitas fisik. Pada tingkat komunitas, perawat dapat memanfaatkan kegiatan Posbindu PTM, kelompok senam, dan penyuluhan kesehatan sebagai sarana edukasi kolektif yang sejalan dengan konsep pelayanan kesehatan primer berbasis masyarakat (Green & Kreuter, 2019; WHO, 2023).

2. Edukasi Pola Makan Sehat

Pola makan merupakan faktor risiko utama yang dapat dimodifikasi pada pasien hipertensi ringan. Edukasi mengenai pola makan sehat bertujuan membantu pasien mengendalikan tekanan darah secara nonfarmakologis dan mencegah progresivitas penyakit. Perawat memiliki peran strategis dalam memberikan pemahaman tentang jenis makanan yang dianjurkan, makanan yang perlu dibatasi, serta cara menerapkan pola makan sehat dalam kehidupan sehari-hari (Smeltzer et al., 2020).

Diet rendah garam menjadi fokus utama dalam edukasi nutrisi bagi pasien hipertensi ringan. Konsumsi natrium berlebihan dapat meningkatkan tekanan darah melalui mekanisme retensi cairan dan peningkatan resistensi vaskular perifer. Perawat perlu menjelaskan sumber garam tersembunyi dalam makanan olahan dan instan, menganjurkan pembatasan penggunaan garam dapur, serta membiasakan pasien membaca label nutrisi. Pembatasan asupan natrium hingga ≤ 5 gram per hari terbukti efektif menurunkan tekanan darah sistolik dan diastolik (WHO, 2023; Whelton et al., 2022).

Selain itu, penerapan pola makan seimbang seperti Dietary Approaches to Stop Hypertension (DASH) direkomendasikan bagi pasien hipertensi ringan. Pola makan ini menekankan konsumsi buah, sayur, biji-bijian utuh, protein rendah lemak, serta pembatasan lemak jenuh dan gula tambahan. Edukasi DASH diet perlu disampaikan secara aplikatif dan disesuaikan dengan kebiasaan makan serta kondisi sosial ekonomi masyarakat agar mudah diterapkan dan berkelanjutan (Mayo Clinic, 2022; Smeltzer et al., 2020).

3. 5.3 Edukasi Aktivitas Fisik

Aktivitas fisik yang teratur berperan penting dalam pengendalian tekanan darah dan peningkatan kebugaran kardiovaskular. Edukasi aktivitas fisik bertujuan membentuk kebiasaan hidup aktif yang aman dan sesuai dengan kemampuan pasien. Perawat perlu menekankan bahwa aktivitas fisik tidak harus berupa olahraga berat, tetapi dapat disesuaikan dengan kondisi usia dan status kesehatan pasien (WHO, 2023).

Pasien hipertensi ringan dianjurkan melakukan aktivitas aerobik intensitas sedang, seperti berjalan kaki, bersepeda santai, atau senam, selama sekitar 30 menit per hari sebanyak 3–5 kali per minggu. Aktivitas ini terbukti membantu menurunkan tekanan darah melalui peningkatan elastisitas pembuluh darah dan penurunan resistensi perifer. Edukasi juga perlu mencakup pentingnya pemanasan, pendinginan, dan peningkatan aktivitas secara bertahap untuk mencegah cedera (Whelton et al., 2022; Pescatello et al., 2019).

Selain olahraga terstruktur, perawat perlu mendorong aktivitas fisik sederhana berbasis rumah, seperti membersihkan rumah, berkebun, atau naik turun tangga. Pendekatan ini membantu pasien memahami bahwa aktivitas fisik dapat diintegrasikan ke dalam rutinitas harian tanpa memerlukan fasilitas khusus, sehingga meningkatkan kepatuhan jangka panjang (Kemenkes RI, 2023).

4. Pengelolaan Stres dan Istirahat

Stres psikologis dan gangguan tidur merupakan faktor yang dapat memengaruhi peningkatan tekanan darah melalui aktivasi sistem saraf simpatis. Oleh karena itu, edukasi mengenai pengelolaan stres dan istirahat yang adekuat menjadi bagian integral dalam pengendalian hipertensi ringan. Perawat berperan membantu pasien mengenali sumber stres dan menerapkan strategi koping yang sehat (Stuart, 2021).

Teknik relaksasi sederhana seperti latihan pernapasan dalam, relaksasi otot progresif, meditasi, atau aktivitas spiritual sesuai keyakinan pasien dapat diajarkan sebagai bagian dari edukasi keperawatan. Teknik-teknik ini relatif mudah dilakukan dan terbukti membantu menurunkan respons stres serta mendukung stabilitas tekanan darah (Varvogli & Darviri, 2018; WHO, 2023).

Selain itu, edukasi mengenai manajemen waktu dan kualitas tidur perlu diberikan secara konsisten. Kurang tidur dan pola tidur yang tidak teratur dapat berdampak negatif terhadap kesehatan kardiovaskular. Perawat perlu menganjurkan pasien untuk menjaga jadwal tidur yang teratur, menghindari konsumsi kafein sebelum tidur, serta menciptakan lingkungan tidur yang nyaman guna meningkatkan kualitas istirahat (Mayo Clinic, 2022; Grandner, 2017).

5. Edukasi Penghentian Perilaku Berisiko

Penghentian perilaku berisiko merupakan bagian penting dari edukasi pola hidup sehat pada pasien hipertensi ringan. Merokok diketahui menyebabkan vasokonstriksi, meningkatkan tekanan darah, dan mempercepat kerusakan pembuluh darah, sehingga memperbesar risiko komplikasi kardiovaskular. Perawat perlu memberikan edukasi mengenai dampak merokok serta memberikan dukungan dan motivasi kepada pasien untuk menghentikan kebiasaan tersebut secara bertahap (WHO, 2023).

Selain merokok, konsumsi alkohol juga perlu mendapatkan perhatian dalam edukasi kesehatan. Konsumsi alkohol berlebihan berhubungan dengan peningkatan tekanan darah dan penurunan efektivitas terapi antihipertensi. Perawat berperan menjelaskan batas aman konsumsi alkohol dan mendorong pasien untuk mengurangi atau menghentikan kebiasaan tersebut sesuai kondisi kesehatan individu (Whelton et al., 2022).

Edukasi penghentian perilaku berisiko sebaiknya dilakukan dengan pendekatan suportif dan tidak menghakimi. Perawat bertindak sebagai pendamping yang membantu pasien mengenali hambatan perubahan perilaku serta mencari solusi yang realistis dan sesuai dengan kondisi pasien. Pendekatan ini terbukti lebih efektif dalam mendorong perubahan perilaku jangka panjang di layanan primer (Burnier & Egan, 2019).

F. Peran Perawat dalam Pendekatan Promotif dan Preventif

Perawat memiliki peran strategis dalam pendekatan promotif dan preventif pada pasien hipertensi ringan, terutama di pelayanan kesehatan primer. Peran ini sejalan dengan filosofi keperawatan komunitas yang menekankan pencegahan penyakit dan peningkatan kualitas hidup (Stanhope & Lancaster, 2020).

1. Perawat sebagai Edukator

Sebagai edukator, perawat bertanggung jawab memberikan informasi kesehatan yang akurat, sistematis, dan berkelanjutan kepada pasien dan keluarga. Edukasi yang dilakukan secara konsisten meningkatkan pengetahuan pasien dan mendukung pencapaian luaran keperawatan yang diharapkan (Potter et al., 2021).

2. Perawat sebagai Motivator Perubahan Perilaku

Perawat berperan memotivasi pasien untuk mengadopsi perilaku hidup sehat melalui pendekatan empatik dan dukungan psikososial. Motivasi yang diberikan secara individual membantu pasien membangun komitmen terhadap perubahan gaya hidup yang berkelanjutan (Green & Kreuter, 2019).

3. Perawat sebagai Pendamping Pasien Kronis

Sebagai pendamping pasien kronis, perawat memberikan dukungan berkelanjutan dalam pemantauan tekanan darah, kepatuhan terapi, dan adaptasi terhadap penyakit. Pendampingan ini meningkatkan rasa aman pasien dan mencegah komplikasi jangka panjang (Smeltzer et al., 2020).

4. Kolaborasi dengan Keluarga dan Kader Kesehatan

Kolaborasi dengan keluarga dan kader kesehatan memperkuat upaya promotif dan preventif di tingkat komunitas. Perawat berperan sebagai koordinator yang mengintegrasikan pelayanan kesehatan formal dengan dukungan sosial masyarakat untuk mencapai pengendalian hipertensi yang optimal (Kemenkes RI, 2022; Stanhope & Lancaster, 2020).

G. Studi Kasus Hipertensi Ringan Di Puskesmas

1. Deskripsi Kasus

Hipertensi merupakan salah satu penyakit tidak menular dengan prevalensi tinggi di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama, termasuk puskesmas. Hipertensi ringan (derajat I) sering kali tidak menimbulkan gejala yang khas, sehingga banyak pasien tidak menyadari kondisi kesehatannya dan datang berobat pada tahap lanjut atau saat muncul komplikasi. Kondisi ini menjadikan puskesmas memiliki peran strategis dalam deteksi dini, pengendalian faktor risiko, serta pencegahan komplikasi melalui pelayanan keperawatan yang komprehensif dan berkesinambungan (Kementerian Kesehatan RI, 2019).

Studi kasus ini menggambarkan penerapan asuhan keperawatan pada pasien dengan hipertensi ringan di puskesmas, dengan pendekatan proses keperawatan yang selaras dengan Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia (SDKI), Standar Luaran Keperawatan Indonesia (SLKI), dan Standar Intervensi Keperawatan Indonesia (SIKI). Pendekatan ini penting untuk memastikan bahwa praktik keperawatan berjalan sistematis, terukur, dan berbasis standar nasional (PPNI, 2017).

Pasien dalam kasus ini adalah Tn. A, usia 45 tahun, datang ke puskesmas untuk pemeriksaan kesehatan rutin. Hasil pengukuran tekanan darah menunjukkan nilai 145/90 mmHg pada dua kali pemeriksaan dengan selang waktu lima menit. Pasien tidak mengeluhkan keluhan berat, namun menyatakan sering merasa cepat lelah dan jarang berolahraga. Riwayat keluarga menunjukkan adanya anggota keluarga dengan hipertensi. Pola makan pasien cenderung tinggi garam dan lemak, serta kurang mengonsumsi buah dan sayur. Kondisi tersebut mencerminkan faktor risiko yang umum ditemukan pada pasien hipertensi di layanan primer (WHO, 2021).

2. Analisis Masalah Keperawatan

Berdasarkan data subjektif dan objektif, perawat melakukan analisis masalah keperawatan dengan mengacu pada SDKI. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi respons pasien terhadap kondisi kesehatannya, bukan semata-mata pada diagnosis medis hipertensi. Pendekatan ini menegaskan peran unik perawat dalam menilai aspek biologis, psikologis, sosial, dan perilaku pasien secara holistik (PPNI, 2017).

Masalah keperawatan utama yang dapat diidentifikasi pada kasus ini adalah **manajemen kesehatan tidak efektif** yang berhubungan dengan kurangnya pengetahuan tentang hipertensi dan gaya hidup sehat. Diagnosis ini didukung oleh data tekanan darah di atas normal, pola makan tinggi garam, kurang aktivitas

fisik, serta pernyataan pasien yang belum memahami pentingnya pengendalian tekanan darah. Selain itu, dapat pula diidentifikasi diagnosis **risiko perfusi jaringan tidak efektif** sebagai masalah potensial, mengingat tekanan darah yang tidak terkontrol dapat meningkatkan risiko komplikasi kardiovaskular (Smeltzer et al., 2020).

Analisis masalah keperawatan ini menjadi dasar dalam penentuan luaran dan intervensi keperawatan yang tepat. Dengan diagnosis yang jelas dan terstandar, perawat dapat merancang asuhan keperawatan yang terarah, realistis, dan sesuai dengan kebutuhan pasien di layanan kesehatan primer.

3. Rencana dan Implementasi Asuhan

Perencanaan asuhan keperawatan disusun dengan mengacu pada SLKI dan SIKI, sehingga setiap diagnosis keperawatan memiliki luaran dan intervensi yang terukur. Untuk diagnosis **manajemen kesehatan tidak efektif**, luaran yang diharapkan adalah meningkatnya kemampuan pasien dalam mengelola kesehatannya, yang ditunjukkan dengan pemahaman tentang hipertensi, kepatuhan terhadap anjuran diet rendah garam, serta kesediaan melakukan aktivitas fisik secara teratur (PPNI, 2019).

Intervensi keperawatan yang direncanakan meliputi edukasi kesehatan tentang hipertensi, konseling gaya hidup sehat, serta monitoring tekanan darah secara berkala. Perawat memberikan penjelasan mengenai pengertian hipertensi, faktor risiko, dan dampak jangka panjang apabila tekanan darah tidak terkontrol. Edukasi disampaikan dengan bahasa sederhana dan disesuaikan dengan tingkat pendidikan pasien agar mudah dipahami. Pendekatan edukatif ini terbukti efektif dalam meningkatkan kepatuhan pasien terhadap pengelolaan hipertensi di layanan primer (Burnier & Egan, 2019).

Selain edukasi, perawat juga mendorong perubahan perilaku melalui motivasi dan pendampingan. Pasien diajak menyusun rencana sederhana, seperti mengurangi konsumsi garam secara bertahap, melakukan aktivitas fisik ringan seperti berjalan kaki selama 30 menit sebanyak tiga sampai lima kali per minggu, serta menghindari kebiasaan merokok. Implementasi intervensi dilakukan secara kolaboratif dengan keluarga pasien untuk memperkuat dukungan sosial, yang merupakan faktor penting dalam keberhasilan pengendalian hipertensi (WHO, 2021).

4. Hasil Evaluasi dan Pembelajaran Kasus

Evaluasi asuhan keperawatan dilakukan dengan membandingkan kondisi pasien setelah intervensi dengan luaran yang telah ditetapkan dalam SLKI. Setelah dilakukan edukasi dan pendampingan selama beberapa kali kunjungan, pasien menunjukkan peningkatan pemahaman tentang hipertensi dan menyatakan

komitmen untuk menerapkan pola hidup lebih sehat. Tekanan darah pasien pada kunjungan berikutnya mengalami penurunan menjadi 138/88 mmHg, meskipun masih memerlukan pemantauan berkelanjutan.

Pembelajaran penting dari studi kasus ini adalah bahwa hipertensi ringan di puskesmas dapat dikelola secara efektif melalui pendekatan keperawatan yang terstruktur dan berkesinambungan. Perawat memiliki peran kunci tidak hanya dalam pengukuran tekanan darah, tetapi juga dalam edukasi, motivasi perubahan perilaku, dan pemberdayaan pasien serta keluarga. Penerapan SDKI–SLKI–SIKI membantu perawat dalam memberikan asuhan yang profesional, terdokumentasi dengan baik, dan selaras dengan standar praktik keperawatan nasional (PPNI, 2017).

Studi kasus ini menegaskan bahwa pendekatan promotif dan preventif di layanan primer merupakan strategi utama dalam menekan angka kejadian dan komplikasi hipertensi. Dengan asuhan keperawatan yang komprehensif, pasien diharapkan mampu mengelola kesehatannya secara mandiri dan berkelanjutan.

H. Tantangan Dan Strategi Pengendalian Hipertensi Ringan Di Puskesmas (Dalam Perspektif Asuhan Keperawatan Dan Edukasi Berkelanjutan)

1. Tantangan Pelayanan Hipertensi Ringan di Puskesmas

Pelaksanaan asuhan keperawatan hipertensi ringan di puskesmas, sebagaimana diuraikan dalam Bab 4, menghadapi tantangan yang bersifat kompleks dan multidimensional. Salah satu tantangan utama adalah rendahnya kepatuhan pasien terhadap rencana asuhan keperawatan, terutama pada pasien dengan hipertensi ringan yang belum menunjukkan gejala klinis bermakna. Kondisi ini sering menyebabkan luaran keperawatan, seperti peningkatan pengetahuan dan kemampuan mengelola tekanan darah secara mandiri, sulit tercapai secara optimal meskipun intervensi telah direncanakan sesuai standar SDKI–SLKI–SIKI (Whelton et al., 2022).

Dari perspektif edukasi kesehatan yang dibahas pada Bab 5, tantangan terbesar terletak pada konsistensi perubahan perilaku pasien. Edukasi pola hidup sehat, seperti diet rendah garam, aktivitas fisik teratur, dan pengelolaan stres, memerlukan komitmen jangka panjang yang sering kali dipengaruhi oleh kebiasaan keluarga, faktor sosial ekonomi, dan budaya lokal. Di layanan primer, keterbatasan waktu dan tingginya jumlah kunjungan pasien menyebabkan edukasi belum sepenuhnya bersifat mendalam dan berkelanjutan, sehingga perubahan perilaku pasien berlangsung lambat (Notoatmodjo, 2021; Kemenkes RI, 2023).

Selain itu, tantangan juga muncul dari keterbatasan sumber daya puskesmas, baik dari segi jumlah tenaga keperawatan, ketersediaan media edukasi, maupun sistem pemantauan pasien kronis. Kondisi ini berdampak pada pelaksanaan peran perawat sebagaimana diuraikan dalam Bab 6, khususnya dalam menjalankan fungsi sebagai pendamping pasien kronis secara berkesinambungan. Tanpa sistem monitoring yang terstruktur, tindak lanjut terhadap pasien hipertensi ringan sering kali tidak optimal, sehingga risiko progresivitas penyakit tetap tinggi (Stanhope & Lancaster, 2020; WHO, 2022).

2. Strategi Inovatif Pengendalian Hipertensi Ringan yang Selaras dengan Asuhan dan Edukasi Keperawatan

Untuk mengatasi tantangan tersebut, strategi pengendalian hipertensi ringan di puskesmas perlu disusun secara terintegrasi dengan proses asuhan keperawatan sebagaimana telah dibahas pada Bab 4. Strategi pertama adalah penguatan edukasi berkelanjutan sebagai bagian dari intervensi keperawatan mandiri, yang diarahkan langsung pada pencapaian luaran keperawatan, seperti peningkatan kepatuhan pasien terhadap pengelolaan tekanan darah dan perubahan gaya hidup sehat. Edukasi yang dilakukan secara bertahap dan berulang terbukti lebih efektif dalam mendukung keberhasilan luaran jangka panjang pada pasien hipertensi ringan (Potter et al., 2021).

Selaras dengan Bab 5, edukasi kesehatan di puskesmas perlu dikembangkan dengan pendekatan **berbasis keluarga dan komunitas**. Perawat tidak hanya berfokus pada pasien sebagai individu, tetapi juga melibatkan anggota keluarga sebagai sistem pendukung utama. Keterlibatan keluarga dalam pengaturan pola makan, aktivitas fisik, dan pengelolaan stres membantu memperkuat hasil intervensi keperawatan dan meningkatkan keberlanjutan perubahan perilaku pasien (Friedman et al., 2021).

Pemanfaatan **media edukasi sederhana**, seperti leaflet, lembar balik, dan poster hipertensi, menjadi strategi inovatif yang realistis dalam keterbatasan sumber daya. Media ini dapat diintegrasikan ke dalam implementasi keperawatan sehari-hari, misalnya saat monitoring tekanan darah atau konseling singkat. Media edukasi yang sederhana, visual, dan kontekstual berfungsi sebagai penguat pesan keperawatan serta mendukung proses evaluasi asuhan, khususnya dalam menilai pemahaman dan kepatuhan pasien (Notoatmodjo, 2021).

Sejalan dengan Bab 6, peran perawat sebagai **edukator, motivator, dan pendamping pasien kronis** perlu diperkuat melalui kolaborasi lintas sektor. Kerja sama dengan kader kesehatan dan tokoh masyarakat memungkinkan pemantauan tekanan darah dan edukasi dilakukan di tingkat komunitas. Strategi ini tidak hanya memperluas jangkauan pelayanan puskesmas, tetapi juga

memperkuat pendekatan promotif dan preventif dalam pengendalian hipertensi ringan secara berkelanjutan (Kemenkes RI, 2022; WHO, 2022).

Dengan menyelaraskan asuhan keperawatan, edukasi kesehatan, dan strategi promotif–preventif, pengendalian hipertensi ringan di puskesmas dapat dilakukan secara lebih sistematis dan efektif. Pendekatan terintegrasi ini mendukung perawat dalam mencapai luaran keperawatan yang optimal, meningkatkan kualitas hidup pasien, serta menurunkan risiko komplikasi kardiovaskular di masa depan.

I. Penutup

1. Ringkasan Materi

Hipertensi ringan merupakan masalah kesehatan kronis yang sering dijumpai di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama, khususnya puskesmas. Meskipun tergolong ringan dan sering tidak menimbulkan gejala yang dirasakan langsung oleh pasien, kondisi ini memiliki potensi besar untuk berkembang menjadi hipertensi berat dan menimbulkan komplikasi kardiovaskular apabila tidak dikelola secara optimal. Oleh karena itu, pendekatan pengendalian hipertensi ringan perlu dilakukan secara komprehensif, berkelanjutan, dan berbasis pelayanan kesehatan primer.

Bab 4 hingga Bab 8 dalam buku ini telah menguraikan pengelolaan hipertensi ringan melalui pendekatan asuhan keperawatan yang sistematis, dimulai dari penetapan diagnosis keperawatan berdasarkan SDKI, penentuan luaran keperawatan sesuai SLKI, hingga pemilihan intervensi keperawatan yang mengacu pada SIKI. Pendekatan ini menegaskan bahwa pengelolaan hipertensi ringan bukan hanya berfokus pada pengendalian tekanan darah, tetapi juga pada peningkatan kemampuan pasien dalam mengelola kesehatannya secara mandiri.

Selanjutnya, Bab 5 menekankan pentingnya edukasi pola hidup sehat sebagai intervensi keperawatan utama pada pasien hipertensi ringan. Edukasi mengenai pola makan sehat, aktivitas fisik, pengelolaan stres, istirahat yang adekuat, serta penghentian perilaku berisiko dipandang sebagai fondasi dalam upaya promotif dan preventif. Bab 6 kemudian memperkuat peran strategis perawat sebagai edukator, motivator, dan pendamping pasien kronis dalam konteks pelayanan kesehatan primer berbasis keluarga dan komunitas.

Bab 7 menghadirkan studi kasus sebagai gambaran penerapan nyata asuhan keperawatan hipertensi ringan di puskesmas, yang menunjukkan keterkaitan antara teori, standar praktik keperawatan, dan kondisi lapangan. Sementara itu, Bab 8 mengulas berbagai tantangan pelayanan serta strategi inovatif yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitas pengendalian

hipertensi ringan, khususnya dalam keterbatasan sumber daya di puskesmas. Secara keseluruhan, rangkaian bab tersebut membentuk kerangka pengelolaan hipertensi ringan yang utuh, kontekstual, dan aplikatif bagi praktik keperawatan.

2. Implikasi bagi Praktik Keperawatan

Pembahasan dalam buku ini memberikan implikasi yang signifikan bagi praktik keperawatan, khususnya di tingkat pelayanan kesehatan primer. Pertama, penerapan asuhan keperawatan yang berlandaskan SDKI–SLKI–SIKI mendorong perawat untuk memberikan pelayanan yang lebih terstruktur, terukur, dan dapat dievaluasi secara objektif. Hal ini membantu meningkatkan mutu asuhan keperawatan sekaligus memperkuat akuntabilitas praktik profesional perawat di puskesmas.

Kedua, penguatan peran perawat dalam edukasi kesehatan menempatkan perawat sebagai aktor kunci dalam pengendalian hipertensi ringan. Perawat tidak hanya berperan dalam pelaksanaan tindakan keperawatan, tetapi juga dalam membangun kesadaran pasien dan keluarga tentang pentingnya perubahan gaya hidup sehat. Edukasi yang dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan berkontribusi terhadap peningkatan kepatuhan pasien, pencapaian luaran keperawatan, serta pencegahan komplikasi jangka panjang.

Ketiga, pendekatan keperawatan yang holistik dan berbasis komunitas memperluas cakupan praktik keperawatan dari individu ke keluarga dan masyarakat. Melalui kolaborasi dengan kader kesehatan dan pemanfaatan kegiatan komunitas, perawat dapat memperkuat upaya promotif dan preventif, sehingga pengendalian hipertensi ringan tidak hanya bersifat kuratif, tetapi juga berorientasi pada peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara keseluruhan.

3. Rekomendasi untuk Pelayanan dan Pendidikan Keperawatan

Berdasarkan rangkaian pembahasan dalam buku ini, beberapa rekomendasi dapat diajukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan pendidikan keperawatan. Dalam aspek pelayanan, puskesmas disarankan untuk memperkuat implementasi asuhan keperawatan hipertensi ringan yang terintegrasi dengan edukasi kesehatan dan pemantauan berkelanjutan. Penyediaan media edukasi sederhana dan sistem pencatatan asuhan keperawatan yang sesuai dengan SDKI–SLKI–SIKI perlu dioptimalkan untuk mendukung pencapaian luaran keperawatan secara konsisten.

Dalam aspek sumber daya manusia, perawat perlu terus didorong untuk meningkatkan kompetensi dalam komunikasi terapeutik, edukasi kesehatan, dan manajemen pasien kronis. Pelatihan dan pembinaan berkelanjutan akan membantu perawat menjalankan perannya secara optimal sebagai edukator dan pendamping pasien hipertensi ringan di layanan primer. Dari sisi pendidikan

keperawatan, materi pengelolaan hipertensi ringan sebagaimana disajikan dalam buku ini dapat dijadikan referensi pembelajaran bagi mahasiswa D3 Keperawatan. Integrasi antara teori, standar praktik keperawatan, dan studi kasus lapangan diharapkan mampu meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam berpikir kritis, menyusun asuhan keperawatan secara sistematis, serta menerapkan pendekatan promotif dan preventif dalam praktik keperawatan. Dengan demikian, lulusan keperawatan diharapkan siap menghadapi tantangan pelayanan kesehatan primer dan berkontribusi dalam pengendalian penyakit tidak menular, khususnya

J. DAFTAR PUSTAKA

- Appel, L. J., Moore, T. J., Obarzanek, E., Vollmer, W. M., Svetkey, L. P., Sacks, F. M., ... Karanja, N. (2017). *A clinical trial of the effects of dietary patterns on blood pressure. The New England Journal of Medicine*, 336(16), 1117–1124. <https://doi.org/10.1056/NEJM199704173361601>
- Arnold, E. C., & Boggs, K. U. (2020). *Interpersonal relationships: Professional communication skills for nurses* (8th ed.). St. Louis, MO: Elsevier.
- Burnier, M., & Egan, B. M. (2019). Adherence in hypertension. *Circulation Research*, 124(7), 1124–1140. <https://doi.org/10.1161/CIRCRESAHA.118.313220>
- Centers for Disease Control and Prevention. (2020). *Smoking cessation: A report of the surgeon general*. Atlanta, GA: CDC.
- Grandner, M. A. (2017). Sleep, health, and society. *Sleep Medicine Clinics*, 12(1), 1–22. <https://doi.org/10.1016/j.jsmc.2016.10.012>
- Green, L. W., & Kreuter, M. W. (2019). *Health program planning: An educational and ecological approach* (5th ed.). New York, NY: McGraw-Hill.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2022). *Pedoman nasional pelayanan kedokteran tata laksana hipertensi*. Jakarta: Kemenkes RI.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2023). *Pedoman teknis penemuan dan tatalaksana hipertensi di fasilitas pelayanan kesehatan primer*. Jakarta: Kemenkes RI.
- Mayo Clinic. (2022). *High blood pressure (hypertension): Lifestyle and home remedies*. Retrieved from <https://www.mayoclinic.org>
- Notoatmodjo, S. (2018). *Promosi kesehatan dan perilaku kesehatan* (edisi revisi). Jakarta: Rineka Cipta.
- Pescatello, L. S., MacDonald, H. V., Lamberti, L., & Johnson, B. T. (2019). Exercise for hypertension: A prescription update integrating existing recommendations. *Current Hypertension Reports*, 21(5), 1–11. <https://doi.org/10.1007/s11906-019-0933-5>

- Potter, P. A., Perry, A. G., Stockert, P., & Hall, A. (2021). *Fundamentals of nursing* (10th ed.). St. Louis, MO: Elsevier.
- Smeltzer, S. C., Bare, B. G., Hinkle, J. L., & Cheever, K. H. (2020). *Brunner & Suddarth's textbook of medical-surgical nursing* (14th ed.). Philadelphia, PA: Wolters Kluwer.
- Stuart, G. W. (2021). *Principles and practice of psychiatric nursing* (11th ed.). St. Louis, MO: Elsevier.
- Tim Pokja SDKI DPP PPNI. (2021). *Standar diagnosis keperawatan Indonesia (SDKI)* (edisi 2). Jakarta: DPP PPNI.
- Tim Pokja SIKI DPP PPNI. (2021). *Standar intervensi keperawatan Indonesia (SIKI)* (edisi 2). Jakarta: DPP PPNI.
- Tim Pokja SLKI DPP PPNI. (2021). *Standar luaran keperawatan Indonesia (SLKI)* (edisi 2). Jakarta: DPP PPNI.
- Varvogli, L., & Darviri, C. (2018). Stress management techniques: Evidence-based procedures. *Health Science Journal*, 5(2), 74–89.
- Whelton, P. K., Carey, R. M., Aronow, W. S., Casey, D. E., Collins, K. J., Dennison Himmelfarb, C., ... Wright, J. T. (2022). 2017 ACC/AHA guideline for the prevention, detection, evaluation, and management of high blood pressure in adults. *Hypertension*, 79(1), e1–e43. <https://doi.org/10.1161/HYP.0000000000000200>
- World Health Organization. (2020). *Guidelines on physical activity and sedentary behaviour*. Geneva: WHO.
- World Health Organization. (2023). *Hypertension: Primary health care approach*. Geneva: World Health Organization.

K. Glosarium

Aktivitas Fisik

Segala bentuk gerakan tubuh yang dihasilkan oleh otot rangka dan membutuhkan pengeluaran energi, termasuk olahraga terstruktur maupun aktivitas sehari-hari yang bermanfaat bagi kesehatan kardiovaskular.

Asuhan Keperawatan

Serangkaian tindakan keperawatan yang diberikan kepada individu, keluarga, atau masyarakat secara sistematis melalui proses keperawatan untuk memenuhi kebutuhan kesehatan dan meningkatkan derajat kesehatan.

DASH Diet (Dietary Approaches to Stop Hypertension)

Pola makan yang menekankan konsumsi buah, sayur, biji-bijian utuh, protein rendah lemak, serta pembatasan garam, lemak jenuh, dan gula, yang terbukti efektif menurunkan tekanan darah.

Deteksi Dini

Upaya mengenali masalah kesehatan sejak tahap awal sebelum muncul komplikasi, termasuk pemeriksaan tekanan darah rutin di puskesmas.

Diagnosis Keperawatan (SDKI)

Penilaian klinis tentang respons individu, keluarga, atau masyarakat terhadap masalah kesehatan atau proses kehidupan yang menjadi dasar penentuan intervensi keperawatan.

Edukasi Kesehatan

Proses pemberian informasi, motivasi, dan bimbingan kepada individu atau kelompok untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, dan perilaku hidup sehat.

Edukasi Berbasis Keluarga

Pendekatan edukasi kesehatan yang melibatkan anggota keluarga sebagai sistem pendukung utama dalam penerapan perubahan perilaku pasien.

Faktor Risiko

Kondisi atau kebiasaan yang meningkatkan kemungkinan seseorang mengalami penyakit tertentu, seperti hipertensi.

Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer

Sarana pelayanan kesehatan tingkat pertama yang memberikan pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif dasar, seperti puskesmas.

Hipertensi

Kondisi peningkatan tekanan darah sistolik ≥ 140 mmHg dan/atau diastolik ≥ 90 mmHg berdasarkan pengukuran berulang.

Hipertensi Ringan (Stadium 1)

Tahap awal hipertensi dengan tekanan darah sistolik 140–159 mmHg dan/atau diastolik 90–99 mmHg, yang umumnya dikelola dengan perubahan gaya hidup dan edukasi kesehatan.

Implementasi Keperawatan

Tahap proses keperawatan berupa pelaksanaan intervensi keperawatan yang telah direncanakan.

Intervensi Keperawatan (SIKI)

Tindakan keperawatan yang dilakukan perawat berdasarkan diagnosis keperawatan untuk mencapai luaran yang diharapkan.

Kepatuhan Pasien

Tingkat kesesuaian perilaku pasien terhadap anjuran tenaga kesehatan, termasuk kontrol rutin dan penerapan pola hidup sehat.

Kolaborasi Interprofesional

Kerja sama antara perawat dan tenaga kesehatan lain dalam memberikan pelayanan kesehatan yang komprehensif.

Luaran Keperawatan (SLKI)

Hasil yang diharapkan setelah dilakukan intervensi keperawatan, yang digunakan sebagai dasar evaluasi keberhasilan asuhan keperawatan.

Manajemen Stres

Upaya mengelola respons psikologis dan fisiologis terhadap stres melalui teknik relaksasi, pengaturan waktu, dan dukungan psikososial.

Monitoring Tekanan Darah

Kegiatan pengukuran tekanan darah secara berkala untuk menilai kondisi dan respons pasien terhadap asuhan keperawatan.

Pola Hidup Sehat

Kebiasaan hidup yang mendukung kesehatan, meliputi pola makan seimbang, aktivitas fisik teratur, istirahat cukup, dan penghindaran perilaku berisiko.

Pencegahan Primer

Upaya mencegah terjadinya penyakit melalui pengendalian faktor risiko sebelum penyakit berkembang.

Pelayanan Promotif dan Preventif

Pendekatan pelayanan kesehatan yang berfokus pada peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit.

Pengkajian Keperawatan

Tahap awal proses keperawatan yang meliputi pengumpulan data subjektif dan objektif pasien secara sistematis.

Pengelolaan Hipertensi

Serangkaian upaya terintegrasi untuk mengendalikan tekanan darah melalui asuhan keperawatan, edukasi, dan kolaborasi pelayanan kesehatan.

Peran Perawat

Fungsi profesional perawat sebagai pemberi asuhan, edukator, motivator, advokat, dan pendamping pasien.

Puskesmas

Unit pelaksana teknis dinas kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan primer berbasis wilayah dan masyarakat.

Studi Kasus

Metode pembelajaran yang menggunakan contoh kasus nyata atau simulasi untuk mengaitkan teori dengan praktik keperawatan.

Tekanan Darah

Gaya yang ditimbulkan oleh aliran darah terhadap dinding pembuluh darah, dinyatakan dalam satuan mmHg.

Upaya Kesehatan Masyarakat

Kegiatan kesehatan yang ditujukan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pendekatan komunitas dan keluarga.

CHAPTER 6

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM MENDUKUNG PELAYANAN KESEHATAN PRIMER

Arief Hendrawan, S.St., M.Fis.

A. Pendahuluan

Pelayanan kesehatan primer (*Primary Health Care/PHC*) kembali menjadi fondasi utama reformasi sistem kesehatan global dalam dekade terakhir. Laporan pemantauan terbaru menunjukkan bahwa negara dengan sistem PHC yang kuat memiliki capaian lebih baik dalam akses layanan, mutu pelayanan, serta ketahanan sistem kesehatan terhadap krisis (WHO, 2023). Reformasi PHC dipandang sebagai strategi efektif untuk mempercepat pencapaian *Universal Health Coverage* sekaligus mengurangi kesenjangan kesehatan antar kelompok sosial (Hanson et al., 2022). Bukti empiris menunjukkan bahwa investasi pada pelayanan primer berkontribusi terhadap penurunan kematian yang dapat dicegah dan peningkatan efisiensi pembiayaan Kesehatan.

Transisi epidemiologi yang ditandai dengan meningkatnya penyakit tidak menular (PTM) memperkuat urgensi penguatan pelayanan kesehatan primer berbasis komunitas. Penyakit seperti hipertensi, diabetes melitus, penyakit kardiovaskular, dan gangguan muskuloskeletal kronis membutuhkan pendekatan jangka panjang yang menekankan perubahan perilaku dan manajemen mandiri pasien (Allen et al., 2020). Intervensi klinis semata tidak memadai untuk mengendalikan faktor risiko PTM tanpa dukungan sosial dan partisipasi aktif masyarakat. Pendekatan berbasis komunitas dalam PHC terbukti meningkatkan kepatuhan terapi, deteksi dini, serta keberlanjutan perubahan gaya hidup (Mohamed et al., 2023).

Pengalaman pandemi COVID-19 memberikan pembelajaran penting mengenai peran komunitas dalam menjaga keberlanjutan layanan kesehatan primer. Sistem kesehatan yang mampu melibatkan masyarakat secara aktif menunjukkan kapasitas respons yang lebih adaptif dan resilien (Haldane et al., 2021). *Community engagement* yang terstruktur memperkuat komunikasi risiko, meningkatkan kepercayaan publik, serta mendukung implementasi kebijakan kesehatan secara efektif (Abimbola et al., 2022). Kondisi tersebut menegaskan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan kebutuhan sistemik dalam membangun ketahanan pelayanan kesehatan primer.

Ketimpangan sosial dan determinan sosial kesehatan memengaruhi efektivitas pelayanan primer. Perbedaan tingkat pendidikan, kondisi ekonomi, dan lingkungan tempat tinggal berkontribusi terhadap disparitas akses dan luaran Kesehatan (Marmot et al., 2020). Pendekatan PHC yang berorientasi pada komunitas memungkinkan identifikasi kebutuhan lokal secara lebih akurat serta pengembangan intervensi yang kontekstual dan berkeadilan (WHO, 2023) Strategi berbasis partisipasi masyarakat berperan dalam menjangkau kelompok rentan yang belum terlayani secara optimal oleh sistem kesehatan formal.

Transformasi digital dalam sektor kesehatan turut mengubah lanskap pelayanan primer. Pemanfaatan teknologi digital memungkinkan edukasi kesehatan jarak jauh, pemantauan penyakit kronis, serta komunikasi dua arah antara tenaga kesehatan dan masyarakat. *Integrasi digital health* dalam PHC memiliki potensi memperluas akses layanan, namun tetap memerlukan penguatan literasi kesehatan dan literasi digital masyarakat agar tidak menimbulkan kesenjangan baru Digitalisasi yang inklusif menjadi bagian integral dalam penguatan sistem pelayanan primer berbasis komunitas.

Konteks negara berkembang, termasuk Indonesia, menempatkan pelayanan kesehatan primer melalui Puskesmas sebagai ujung tombak upaya promotif dan preventif. Transformasi layanan primer yang sedang berlangsung menuntut pendekatan yang partisipatif dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat Penguatan pemberdayaan masyarakat diperlukan untuk memastikan keberlanjutan program kesehatan serta peningkatan mutu layanan di tingkat komunitas. Pendekatan tersebut mendukung pencapaian indikator kesehatan nasional sekaligus memperkuat legitimasi sosial sistem kesehatan primer.

B. Konsep Dasar Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelayanan Kesehatan Primer

Pemberdayaan masyarakat dalam pelayanan kesehatan primer dipahami sebagai proses sistematis untuk meningkatkan kapasitas individu dan komunitas dalam mengidentifikasi masalah kesehatan, menentukan prioritas, serta mengambil tindakan kolektif yang berkelanjutan. Pendekatan ini menempatkan masyarakat bukan sebagai objek intervensi, melainkan sebagai subjek pembangunan kesehatan yang memiliki daya tawar dan kontrol terhadap keputusan yang memengaruhi kesejahteraan mereka (WHO, 2022a). Deklarasi Astana menegaskan bahwa partisipasi aktif masyarakat merupakan pilar fundamental dalam penguatan Primary Health Care, khususnya dalam menjamin responsivitas sistem kesehatan terhadap kebutuhan lokal. Kerangka tersebut menekankan pentingnya kolaborasi antara tenaga kesehatan, pemerintah lokal, dan komunitas dalam menciptakan sistem yang inklusif dan berkeadilan.

Perbedaan konseptual antara community engagement dan community empowerment menjadi krusial dalam implementasi pelayanan primer. Community engagement berfokus pada keterlibatan masyarakat dalam program yang telah dirancang oleh sistem kesehatan, sedangkan community empowerment menekankan redistribusi kekuasaan dan penguatan kapasitas agar masyarakat mampu menginisiasi dan mengendalikan program secara mandiri (George et al., 2021). Literatur terbaru menunjukkan bahwa pendekatan empowerment menghasilkan dampak jangka panjang yang lebih berkelanjutan dibandingkan sekadar pelibatan partisipatif (O'Mara-Eves et al., 2021). Orientasi pemberdayaan memungkinkan transformasi relasi antara penyedia layanan dan komunitas menjadi kemitraan yang setara.

Landasan teoretis pemberdayaan masyarakat dalam konteks kesehatan primer berakar pada teori partisipasi dan pendekatan ekologi sosial. Model socio-ecological menjelaskan bahwa perilaku kesehatan dipengaruhi oleh interaksi antara faktor individu, interpersonal, komunitas, dan kebijakan (Golden & Earp, 2022). Pendekatan ini memperkuat argumen bahwa intervensi berbasis komunitas harus mempertimbangkan konteks sosial dan struktural secara simultan. Penguatan kapasitas komunitas juga dikaitkan dengan peningkatan collective efficacy yang berkontribusi terhadap perubahan perilaku kesehatan populasi (Cyril et al., 2020).

Asset-Based Community Development (ABCD) semakin relevan dalam paradigma pelayanan primer modern. Pendekatan ABCD menekankan identifikasi dan mobilisasi aset lokal, termasuk sumber daya sosial, budaya, dan ekonomi yang telah dimiliki komunitas. Strategi berbasis aset terbukti meningkatkan rasa kepemilikan masyarakat terhadap program kesehatan serta memperkuat keberlanjutan intervensi (South et al., 2020). Orientasi tersebut menggeser pendekatan defisit yang berfokus pada kekurangan menuju pendekatan yang menghargai potensi lokal sebagai kekuatan utama pembangunan kesehatan.

Dimensi pemberdayaan dalam pelayanan kesehatan primer mencakup tingkat individu, keluarga, komunitas, dan kebijakan. Pada tingkat individu, peningkatan literasi kesehatan dan self-efficacy menjadi faktor determinan dalam pengelolaan penyakit kronis (Nutbeam & Lloyd, 2021). Tingkat keluarga berperan dalam membentuk dukungan sosial dan lingkungan yang kondusif bagi perubahan perilaku sehat. Tingkat komunitas berkaitan dengan kemampuan kolektif dalam mengorganisasi sumber daya dan membangun jejaring sosial. Tingkat kebijakan lokal menentukan keberlanjutan program melalui regulasi dan dukungan anggaran yang responsif terhadap kebutuhan Masyarakat (Laverack, 2021).

Integrasi pemberdayaan masyarakat dalam pelayanan kesehatan primer memerlukan transformasi tata kelola yang adaptif. Sistem kesehatan perlu

menyediakan ruang deliberatif bagi masyarakat dalam proses perencanaan dan evaluasi layanan. Mekanisme akuntabilitas sosial, transparansi informasi, serta penguatan kapasitas kader kesehatan menjadi komponen penting dalam memastikan partisipasi bermakna (Marmot et al., 2020). Kerangka tersebut menunjukkan bahwa pemberdayaan bukan sekadar strategi operasional, melainkan pendekatan struktural yang memperkuat legitimasi dan efektivitas pelayanan kesehatan primer.

C. Implementasi Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelayanan Kesehatan Primer

Implementasi pemberdayaan masyarakat dalam pelayanan kesehatan primer menuntut pendekatan sistemik yang terintegrasi dengan tata kelola layanan, pembiayaan, dan penguatan sumber daya manusia kesehatan. Transformasi pelayanan primer di berbagai negara menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat yang terstruktur mampu meningkatkan akses layanan, kualitas interaksi klinis, serta keberlanjutan program promotif dan preventif (WHO, 2023). Model implementasi yang efektif memerlukan integrasi antara kebijakan nasional dan strategi operasional di tingkat fasilitas layanan primer. Kerangka implementasi tersebut menempatkan komunitas sebagai mitra strategis dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program kesehatan.

Penguatan peran fasilitas kesehatan tingkat pertama menjadi kunci dalam mengoperasionalkan pemberdayaan masyarakat. Studi terbaru menunjukkan bahwa puskesmas atau fasilitas setara yang menerapkan pendekatan community-oriented primary care mampu meningkatkan deteksi dini penyakit kronis dan memperbaiki koordinasi perawatan (Bitton et al., 2021). Pendekatan tersebut menggabungkan data epidemiologi lokal dengan partisipasi komunitas untuk merancang intervensi berbasis kebutuhan riil. Integrasi layanan klinis dan kegiatan pemberdayaan memperluas cakupan layanan tanpa meningkatkan beban biaya secara signifikan.

Keterlibatan kader kesehatan dan relawan komunitas berperan penting dalam menjembatani sistem formal dan masyarakat. Evidence global menunjukkan bahwa community health workers memberikan kontribusi signifikan dalam pengendalian penyakit tidak menular, peningkatan literasi kesehatan, serta monitoring kepatuhan terapi (Perry et al., 2021). Optimalisasi peran kader membutuhkan pelatihan berkelanjutan, supervisi yang memadai, serta sistem insentif yang adil agar keberlanjutan program tetap terjaga (Glenton et al., 2021). Penguatan kapasitas kader juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan primer.

Pemanfaatan pendekatan kolaboratif lintas sektor memperkuat efektivitas implementasi pemberdayaan. Determinan sosial kesehatan seperti pendidikan,

pekerjaan, dan lingkungan fisik tidak dapat diintervensi secara sektoral semata (Scheirer & Dearing, 2021). Integrasi program kesehatan dengan sektor pendidikan, pemberdayaan ekonomi, serta pemerintahan desa terbukti meningkatkan outcome kesehatan komunitas secara lebih komprehensif (Rasanathan et al., 2021). Model governance kolaboratif memungkinkan pengambilan keputusan berbasis kebutuhan lokal dan memperkuat akuntabilitas publik.

Digitalisasi layanan primer menjadi instrumen pendukung dalam memperluas jangkauan pemberdayaan masyarakat. Platform telehealth dan aplikasi pemantauan mandiri memungkinkan masyarakat berpartisipasi aktif dalam pengelolaan kesehatan pribadi maupun keluarga (WHO, 2023). Penggunaan teknologi digital dalam konteks komunitas meningkatkan efisiensi komunikasi antara tenaga kesehatan dan warga, sekaligus mendukung sistem pencatatan dan pelaporan berbasis data *real time*. Transformasi digital yang inklusif memerlukan perhatian terhadap literasi digital dan kesenjangan akses teknologi di wilayah rural.

Evaluasi implementasi pemberdayaan masyarakat memerlukan indikator yang tidak hanya mengukur output layanan, tetapi juga perubahan kapasitas komunitas. Indikator seperti peningkatan partisipasi, penguatan jejaring sosial, serta peningkatan self-management pasien menjadi ukuran penting keberhasilan intervensi berbasis komunitas. Kerangka evaluasi berbasis outcome komunitas memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai dampak jangka panjang program pelayanan primer. Pendekatan tersebut menegaskan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan investasi strategis dalam membangun sistem kesehatan primer yang tangguh, adaptif, dan berkelanjutan.

D. Strategi Implementasi Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelayanan Kesehatan Primer

Strategi implementasi pemberdayaan masyarakat dalam pelayanan kesehatan primer memerlukan pendekatan terstruktur yang mengintegrasikan kebijakan, tata kelola fasilitas kesehatan, serta penguatan kapasitas komunitas. Pelayanan kesehatan primer yang efektif tidak hanya mengandalkan intervensi klinis, tetapi juga membangun mekanisme partisipatif yang memungkinkan masyarakat terlibat dalam proses perencanaan dan evaluasi layanan (WHO, 2022b). Kerangka implementasi strategis menempatkan pemberdayaan sebagai komponen sistemik yang tertanam dalam siklus manajemen Puskesmas, mulai dari identifikasi masalah hingga monitoring dan evaluasi berbasis wilayah kerja.

Strategi pertama berfokus pada penguatan tata kelola partisipatif di tingkat fasilitas kesehatan primer. Perencanaan berbasis data komunitas, termasuk analisis profil kesehatan keluarga dan pemetaan faktor risiko penyakit tidak menular,

menjadi dasar dalam menentukan prioritas intervensi. Pendekatan community-oriented primary care menunjukkan bahwa integrasi data epidemiologis dengan partisipasi masyarakat meningkatkan relevansi program dan efisiensi alokasi sumber daya (Bresick et al., 2021). Mekanisme musyawarah masyarakat desa dan forum komunikasi kesehatan berperan sebagai ruang deliberatif untuk menyelaraskan kebutuhan komunitas dengan program Puskesmas.

Strategi kedua menekankan penguatan kapasitas kader kesehatan dan relawan komunitas sebagai agen perubahan. Pengalaman berbagai negara menunjukkan bahwa investasi pada pelatihan kader berdampak signifikan terhadap peningkatan literasi kesehatan dan pengendalian faktor risiko penyakit kronis (Ballard et al., 2022). Sistem supervisi berjenjang dan dukungan teknis dari tenaga kesehatan profesional memastikan kualitas intervensi tetap terjaga. Model capacity strengthening berbasis kompetensi meningkatkan kepercayaan diri kader serta memperluas jangkauan layanan promotif dan preventif (Kok et al., 2022).

Strategi ketiga berkaitan dengan integrasi lintas sektor dalam pembangunan kesehatan berbasis desa. Determinan sosial kesehatan memerlukan kolaborasi antara sektor kesehatan, pendidikan, sosial, dan pemerintahan lokal agar intervensi lebih komprehensif. Integrasi program kesehatan dengan perencanaan pembangunan desa memungkinkan optimalisasi sumber daya lokal, termasuk pemanfaatan anggaran desa untuk kegiatan promotif dan preventif. Pendekatan kolaboratif tersebut memperkuat akuntabilitas dan rasa kepemilikan masyarakat terhadap program kesehatan.

Strategi keempat melibatkan pemanfaatan teknologi digital untuk mendukung pemberdayaan masyarakat. Transformasi digital dalam pelayanan primer memperluas akses informasi kesehatan, meningkatkan efisiensi pelaporan, dan memperkuat komunikasi antara Puskesmas dan komunitas. Platform digital sederhana seperti sistem pencatatan elektronik dan aplikasi monitoring mandiri mendukung partisipasi aktif keluarga dalam pengelolaan penyakit kronis. Penggunaan teknologi perlu disertai peningkatan literasi digital agar tidak memperlebar kesenjangan akses layanan.

Strategi kelima menekankan evaluasi berbasis outcome komunitas sebagai bagian integral dari implementasi pemberdayaan. Indikator keberhasilan tidak terbatas pada jumlah kegiatan, tetapi mencakup perubahan perilaku kesehatan, peningkatan self-efficacy masyarakat, serta penurunan faktor risiko penyakit tidak menular (Rifkin, 2020). Pendekatan evaluatif partisipatif memungkinkan masyarakat turut menilai efektivitas program dan memberikan umpan balik untuk perbaikan berkelanjutan. Siklus perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan

peningkatan menjadi fondasi dalam memastikan strategi pemberdayaan berjalan konsisten dan adaptif terhadap dinamika lokal.

Strategi implementasi yang komprehensif menempatkan pemberdayaan masyarakat sebagai investasi jangka panjang dalam memperkuat sistem pelayanan kesehatan primer. Integrasi tata kelola partisipatif, penguatan kapasitas kader, kolaborasi lintas sektor, dukungan digitalisasi, dan evaluasi berbasis outcome membentuk kerangka operasional yang kontekstual dan berkelanjutan. Pendekatan tersebut selaras dengan agenda transformasi layanan primer yang berorientasi pada ketahanan sistem dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

E. Tantangan dan Solusi dalam Pemberdayaan Masyarakat pada Pelayanan Kesehatan Primer

Pemberdayaan masyarakat dalam pelayanan kesehatan primer menghadapi tantangan struktural, kultural, dan sistemik yang memengaruhi efektivitas implementasinya. Ketimpangan sosial dan ekonomi masih menjadi hambatan utama dalam memastikan partisipasi bermakna seluruh kelompok masyarakat. Kelompok dengan tingkat pendidikan rendah dan akses terbatas terhadap informasi kesehatan cenderung kurang terlibat dalam proses pengambilan keputusan layanan primer (WHO, 2023). Kesenjangan tersebut berpotensi memperkuat eksklusivitas sosial apabila strategi pemberdayaan tidak dirancang secara inklusif dan berbasis keadilan.

Tantangan berikutnya berkaitan dengan kapasitas institusional fasilitas kesehatan primer. Beban kerja tenaga kesehatan yang tinggi serta dominasi orientasi kuratif seringkali membatasi ruang untuk kegiatan promotif dan partisipatif. Sistem pembiayaan yang belum sepenuhnya memberi insentif pada upaya pemberdayaan juga memengaruhi prioritas program di tingkat fasilitas. Reformasi manajemen pelayanan primer yang menyeimbangkan fungsi kuratif dan promotif menjadi prasyarat dalam memperkuat pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan (Sørensen et al., 2021).

Keterbatasan kompetensi kader dan relawan kesehatan desa turut menjadi tantangan implementasi. Variasi kualitas pelatihan, minimnya supervisi, serta ketidakjelasan peran dapat menurunkan efektivitas intervensi berbasis komunitas (George et al., 2021). Tingkat retensi kader sering dipengaruhi oleh faktor motivasi intrinsik dan dukungan eksternal, termasuk insentif non-finansial seperti pengakuan sosial dan peluang pengembangan kapasitas (Haldane et al., 2021). Penguatan sistem pelatihan berbasis kompetensi dan supervisi kolaboratif menjadi solusi strategis untuk meningkatkan kualitas kontribusi kader.

Transformasi digital dalam pelayanan primer menghadirkan tantangan baru berupa kesenjangan literasi digital dan akses teknologi. Wilayah rural dengan

infrastruktur terbatas berisiko tertinggal dalam pemanfaatan inovasi digital untuk pemberdayaan Masyarakat (International Telecommunication Union, 2022). Penggunaan teknologi tanpa pendekatan inklusif dapat memperlebar kesenjangan kesehatan yang sudah ada. Strategi blended approach yang menggabungkan interaksi tatap muka dengan dukungan digital sederhana menjadi solusi yang lebih adaptif terhadap konteks lokal (WHO, 2021).

Koordinasi lintas sektor yang belum optimal juga menghambat efektivitas pemberdayaan. Determinan sosial kesehatan membutuhkan kolaborasi multisektor, namun fragmentasi kebijakan dan ego sektoral sering memperlambat integrasi program (United Nations, 2022). Mekanisme tata kelola kolaboratif berbasis wilayah dan penguatan peran pemerintah desa sebagai koordinator pembangunan lokal dapat memperkuat sinergi antar sektor. Pendekatan governance yang transparan dan partisipatif meningkatkan akuntabilitas serta legitimasi kebijakan kesehatan primer.

Solusi komprehensif dalam mengatasi tantangan pemberdayaan masyarakat memerlukan pendekatan sistemik yang berorientasi pada ketahanan pelayanan primer. Investasi pada literasi kesehatan, reformasi tata kelola partisipatif, penguatan kapasitas kader, dukungan pembiayaan yang responsif, serta digitalisasi inklusif menjadi komponen strategis yang saling melengkapi. Kerangka solusi tersebut menempatkan masyarakat sebagai mitra setara dalam pembangunan kesehatan, sekaligus memperkuat fondasi pelayanan kesehatan primer yang adaptif dan berkelanjutan.

F. Implikasi Kebijakan Nasional dan Lokal

Penguatan pemberdayaan masyarakat dalam pelayanan kesehatan primer memiliki implikasi strategis terhadap arah kebijakan kesehatan nasional. Reformasi sistem kesehatan yang berorientasi pada transformasi layanan primer perlu mengintegrasikan pemberdayaan sebagai indikator kinerja utama, bukan sekadar program tambahan. Kebijakan nasional dapat menetapkan standar partisipasi masyarakat dalam siklus perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi layanan primer agar tercipta mekanisme akuntabilitas sosial yang terukur. Integrasi indikator pemberdayaan ke dalam sistem monitoring nasional akan memperjelas kontribusi pendekatan partisipatif terhadap pencapaian Universal Health Coverage.

Kebijakan pembiayaan kesehatan perlu memberikan ruang insentif bagi kegiatan promotif dan preventif berbasis komunitas. Skema kapitasi dan pembiayaan berbasis kinerja dapat dirancang untuk mendorong fasilitas kesehatan primer mengembangkan program pemberdayaan yang inovatif dan berdampak (Cashin et al., 2021). Alokasi anggaran yang responsif terhadap kebutuhan lokal

memperkuat fleksibilitas Puskesmas dalam merancang intervensi kontekstual. Kebijakan fiskal yang adaptif terhadap determinan sosial kesehatan mendukung pendekatan lintas sektor yang lebih komprehensif.

Penguatan regulasi mengenai peran kader kesehatan dan relawan komunitas menjadi implikasi penting pada tingkat nasional. Standarisasi kompetensi, sistem sertifikasi, serta skema pengembangan kapasitas berkelanjutan dapat meningkatkan profesionalisme kader tanpa menghilangkan karakter voluntaristiknya (Cometto et al., 2022). Kebijakan nasional yang memberikan kejelasan peran dan dukungan supervisi akan meningkatkan konsistensi implementasi pemberdayaan di berbagai daerah. Kerangka regulasi tersebut juga berkontribusi pada peningkatan kualitas pelayanan primer secara keseluruhan.

Implikasi kebijakan pada tingkat lokal berkaitan dengan penguatan tata kelola kolaboratif berbasis wilayah. Pemerintah daerah memiliki kewenangan strategis dalam mengintegrasikan program kesehatan dengan perencanaan pembangunan daerah. Sinkronisasi antara rencana strategis dinas kesehatan, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan perencanaan desa memungkinkan optimalisasi sumber daya untuk mendukung pemberdayaan masyarakat. Pendekatan desentralisasi yang adaptif memperkuat inovasi lokal sesuai karakteristik sosial dan budaya setempat.

Pemanfaatan Dana Desa dan mekanisme pembiayaan lokal lainnya memiliki implikasi kebijakan yang signifikan dalam mendukung keberlanjutan program pemberdayaan. Integrasi agenda kesehatan dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa mendorong keterlibatan masyarakat secara langsung dalam penentuan prioritas (United Nations, 2022). Kebijakan lokal yang mendukung transparansi dan partisipasi publik meningkatkan legitimasi program kesehatan primer di tingkat komunitas.

Transformasi digital pada tingkat nasional dan lokal juga memiliki konsekuensi kebijakan yang penting. Regulasi mengenai interoperabilitas sistem informasi kesehatan, perlindungan data pribadi, dan literasi digital menjadi prasyarat dalam memanfaatkan teknologi sebagai instrumen pemberdayaan (World Bank, 2022). Kebijakan digital health yang inklusif memastikan bahwa inovasi teknologi memperluas akses dan partisipasi masyarakat tanpa memperdalam kesenjangan sosial.

Implikasi kebijakan nasional dan lokal menegaskan bahwa pemberdayaan masyarakat bukan sekadar strategi operasional, melainkan agenda reformasi struktural dalam sistem pelayanan kesehatan primer. Kebijakan yang konsisten, terintegrasi, dan berbasis bukti akan memperkuat posisi masyarakat sebagai mitra

setara dalam pembangunan kesehatan serta meningkatkan ketahanan sistem kesehatan secara berkelanjutan.

G. Simpulan

Pemberdayaan masyarakat dalam pelayanan kesehatan primer merupakan pendekatan strategis yang memperkuat fondasi sistem kesehatan melalui integrasi partisipasi bermakna, penguatan kapasitas komunitas, dan tata kelola kolaboratif berbasis wilayah. Kerangka konseptual yang memadukan prinsip Primary Health Care, pendekatan sosio-ekologis, pengembangan aset komunitas, serta penguatan peran kader kesehatan menunjukkan bahwa pemberdayaan bukan sekadar aktivitas pendukung, melainkan mekanisme struktural untuk meningkatkan efektivitas promotif dan preventif. Implementasi yang terintegrasi dengan manajemen Puskesmas, dukungan lintas sektor, serta transformasi digital yang inklusif memperluas dampak intervensi hingga tingkat keluarga dan komunitas. Tantangan struktural, kapasitas institusional, kesenjangan literasi, dan koordinasi multisektor menuntut solusi sistemik yang adaptif dan berkelanjutan. Konseptualisasi dan strategi implementasi yang dirumuskan dalam bab ini menegaskan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan prasyarat dalam membangun pelayanan kesehatan primer yang tangguh, responsif terhadap kebutuhan lokal, dan berorientasi pada peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan.

H. Referensi

- Abimbola, S., Asthana, S., Montenegro, C., Guinto, R. R., Jumbam, D. T., Louskieter, L., & Pai, M. (2022). Addressing power asymmetries in global health: Imperatives in the wake of the COVID-19 pandemic. *PLOS Medicine*, 19(4), e1003991. <https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1003991>
- Allen, L. N., Nicholson, B. D., Yeung, B. Y. T., & Goiana-da-Silva, F. (2020). Implementation of non-communicable disease policies: A geopolitical analysis of 151 countries. *The Lancet Global Health*, 8(1), e50--e58. [https://doi.org/10.1016/S2214-109X\(19\)30446-2](https://doi.org/10.1016/S2214-109X(19)30446-2)
- Ballard, M., Bancroft, E., Nesbit, J., Johnson, A., Holeman, I., Foth, J., & Palazuelos, D. (2022). Prioritising the role of community health workers in the COVID-19 response. *BMJ Global Health*, 7(5), e008985. <https://doi.org/10.1136/bmjgh-2022-008985>
- Bitton, A., Fifield, J., Ratcliffe, H., Karlage, A., Wang, H., Veillard, J. H., & Basu, S. (2021). Primary health care as a foundation for strengthening health systems in low- and middle-income countries. *Journal of General Internal Medicine*, 36(4), 1231–1237. <https://doi.org/10.1007/s11606-020-06318-7>

- Bresick, G., Sayed, A. R., Le Grange, C., Bhagwan, S., Manga, N., & Sifunda, S. (2021). Community-oriented primary care: A scoping review of principles and practice. *BMJ Open*, 11(2), e042091. <https://doi.org/10.1136/bmjopen-2020-042091>
- Cashin, C., Bloom, D., Sparkes, S., Barroy, H., Kutzin, J., & O'Dougherty, S. (2021). *Aligning public financial management and health financing: Sustaining progress toward universal health coverage*. World Health Organization.
- Cometto, G., Ford, N., Pfaffman-Zambruni, J., Akl, E. A., Lehmann, U., McPake, B., Ballard, M., & Campbell, J. (2022). Health policy and system support to optimise community health worker programmes. *The Lancet Global Health*, 10(9), e1397--e1404. [https://doi.org/10.1016/S2214-109X\(22\)00341-7](https://doi.org/10.1016/S2214-109X(22)00341-7)
- Cyril, S., Smith, B. J., Possamai-Inesedy, A., & Renzaho, A. M. N. (2020). Exploring the role of community capacity building in health promotion. *Health Promotion International*, 35(5), 1157–1170. <https://doi.org/10.1093/heapro/daz071>
- George, A. S., Mehra, V., Scott, K., & Sriram, V. (2021). Community participation in health systems research: A scoping review. *Health Policy and Planning*, 36(9), 1483–1498. <https://doi.org/10.1093/heapol/czab070>
- Glenton, C., Javadi, D., & Perry, H. B. (2021). Community health workers at the dawn of a new era: Roles and tasks. *Health Research Policy and Systems*, 19, 128. <https://doi.org/10.1186/s12961-021-00741-4>
- Golden, S. D., & Earp, J. A. L. (2022). Social ecological approaches to individuals and their contexts. *Health Education & Behavior*, 49(1), 7–19. <https://doi.org/10.1177/10901981211069934>
- Haldane, V., Chuah, F. L. H., Srivastava, A., Singh, S. R., Koh, G. C. H., Seng, C. K., & Legido-Quigley, H. (2021). Community participation in health services development, implementation, and evaluation: A systematic review of empowerment, health, community, and process outcomes. *PLOS ONE*, 16(5), e0251632. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0251632>
- Hanson, K., Brikci, N., Erlangga, D., Alebachew, A., De Allegri, M., Balabanova, D., & McIntyre, D. (2022). Financing primary health care: Putting people at the centre. *The Lancet Global Health*, 10(5), e715--e772. [https://doi.org/10.1016/S2214-109X\(22\)00005-3](https://doi.org/10.1016/S2214-109X(22)00005-3)
- International Telecommunication Union. (2022). *Measuring digital development: Facts and figures 2022*. International Telecommunication Union.
- Kok, M. C., Dieleman, M., Taegtmeier, M., & Broerse, J. E. W. (2022). Which intervention design factors influence performance of community health workers? *Health Policy and Planning*, 37(4), 450–463. <https://doi.org/10.1093/heapol/czab174>

- Laverack, G. (2021). Revisiting community empowerment: Definitions and dilemmas. *Global Health Promotion*, 28(1), 45–52. <https://doi.org/10.1177/1757975920904148>
- Marmot, M., Allen, J., Boyce, T., Goldblatt, P., & Morrison, J. (2020). *Health Equity in England: The Marmot Review 10 Years On*. Institute of Health Equity.
- Mohamed, N. A., Abdelaal, A., & El-Gilany, A. H. (2023). Community-based interventions for non-communicable disease prevention in primary health care: A systematic review. *BMC Public Health*, 23, 1124. <https://doi.org/10.1186/s12889-023-16075-3>
- Nutbeam, D., & Lloyd, J. E. (2021). Understanding and responding to health literacy as a social determinant of health. *Annual Review of Public Health*, 42, 159–173. <https://doi.org/10.1146/annurev-publhealth-090419-102529>
- O'Mara-Eves, A., Brunton, G., McDaid, D., Oliver, S., Kavanagh, J., Jamal, F., & Thomas, J. (2021). Community engagement to reduce inequalities in health: A systematic review and meta-analysis. *Public Health Research*, 9(2). <https://doi.org/10.3310/phr09020>
- Perry, H. B., Zulliger, R., & Rogers, M. M. (2021). Community health workers in low-, middle-, and high-income countries. *Annual Review of Public Health*, 42, 399–421. <https://doi.org/10.1146/annurev-publhealth-090419-102830>
- Rasanathan, K., Bennett, S., Atkins, V., Beschel, R., Carrasquilla, G., Evans, T., Goenka, S., & Jha, A. (2021). Governing multisectoral action for health in low- and middle-income countries. *PLoS Medicine*, 18(4), e1003559. <https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1003559>
- Rifkin, S. B. (2020). Paradigms lost: Toward a new understanding of community participation in health programmes. *Acta Tropica*, 202, 105197. <https://doi.org/10.1016/j.actatropica.2019.105197>
- Scheirer, M. A., & Dearing, J. W. (2021). An agenda for research on the sustainability of public health programs. *American Journal of Public Health*, 111(1), 12–18. <https://doi.org/10.2105/AJPH.2020.305913>
- Sørensen, K., den Broucke, S., & Fullam, J. (2021). Health literacy and public health: A systematic review and integration of definitions and models. *BMC Public Health*, 21, 1204. <https://doi.org/10.1186/s12889-021-11278-4>
- South, J., Giuntoli, G., Kinsella, K., & Carthy, J. (2020). Asset-based approaches and health improvement. *Health & Social Care in the Community*, 28(4), 1185–1193. <https://doi.org/10.1111/hsc.12964>
- United Nations. (2022). *World social report 2022: Inequality in a rapidly changing world*. United Nations Department of Economic and Social Affairs.
- WHO. (2021). *Community engagement: A health promotion guide for universal health coverage in the hands of the people*. World Health Organization.

<https://www.who.int/publications/i/item/9789240010529>

WHO. (2022a). *Global report on health equity for persons with disabilities*. World Health Organization.

<https://www.who.int/publications/i/item/9789240063600>

WHO. (2022b). *Global strategy on human resources for health: Workforce 2030 progress report 2022*. World Health Organization.

WHO. (2023). *Primary health care measurement framework and indicators: Monitoring health systems through a primary health care lens*. World Health Organization.

World Bank. (2022). *Digital-in-health: Unlocking the value for everyone*. World Bank.

World Health Organization. (2023). *Community engagement for quality, people-centred and resilient health services*. World Health Organization.

I. Glosarium

Community Empowerment (Pemberdayaan Masyarakat)

Proses peningkatan kapasitas individu dan kelompok masyarakat untuk mengidentifikasi masalah kesehatan, mengambil keputusan, serta mengendalikan faktor yang memengaruhi derajat kesehatannya secara mandiri dan berkelanjutan.

Community Health Worker (CHW) / Kader Kesehatan

Tenaga kesehatan berbasis komunitas yang dilatih untuk memberikan edukasi, promosi kesehatan, deteksi dini, dan dukungan layanan kesehatan dasar di masyarakat.

Community-Oriented Primary Care (COPC)

Pendekatan pelayanan kesehatan primer yang mengintegrasikan praktik klinis dengan intervensi berbasis populasi dan partisipasi masyarakat dalam satu wilayah kerja tertentu.

Continuum of Care

Rangkaian layanan kesehatan yang terintegrasi mulai dari promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, hingga paliatif secara berkesinambungan.

Digital Health

Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung layanan kesehatan, manajemen data, telekonsultasi, serta sistem rujukan berbasis elektronik.

Equity in Health (Keadilan Kesehatan)

Prinsip pemerataan akses dan kualitas layanan kesehatan tanpa diskriminasi sosial, ekonomi, geografis, maupun budaya.

Health Literacy (Literasi Kesehatan)

Kemampuan individu atau komunitas dalam mengakses, memahami, mengevaluasi, dan menggunakan informasi kesehatan untuk pengambilan keputusan yang tepat.

Health Promotion (Promosi Kesehatan)

Upaya sistematis untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengendalikan determinan kesehatan guna meningkatkan kualitas hidup.

Health System Resilience (Ketahanan Sistem Kesehatan)

Kemampuan sistem kesehatan dalam menyerap, beradaptasi, dan pulih dari krisis atau tekanan eksternal tanpa mengganggu fungsi pelayanan esensial.

Interprofessional Collaboration

Kerja sama lintas profesi kesehatan dalam perencanaan dan pelaksanaan pelayanan untuk meningkatkan efektivitas dan mutu layanan.

Non-Communicable Diseases (NCDs) / Penyakit Tidak Menular (PTM)

Kelompok penyakit kronis seperti hipertensi, diabetes, penyakit jantung, kanker, dan penyakit paru kronik yang tidak ditularkan dari individu ke individu.

Participatory Approach (Pendekatan Partisipatif)

Strategi pembangunan kesehatan yang melibatkan masyarakat secara aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program.

Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat)

Fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama di Indonesia yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan perseorangan secara komprehensif.

Primary Health Care (PHC) / Pelayanan Kesehatan Primer

Pendekatan pelayanan kesehatan yang berfokus pada akses universal, pencegahan penyakit, promosi kesehatan, dan keterlibatan masyarakat sebagai fondasi sistem kesehatan.

Rehabilitasi Bersumberdaya Masyarakat (RBM)

Pendekatan rehabilitasi berbasis komunitas yang mengoptimalkan sumber daya lokal untuk meningkatkan fungsi, partisipasi, dan kualitas hidup penyandang disabilitas atau individu dengan keterbatasan fungsi.

Social Determinants of Health (SDH)

Faktor sosial, ekonomi, lingkungan, dan budaya yang memengaruhi kondisi kesehatan individu dan populasi.

Task Shifting / Task Sharing

Strategi distribusi tugas pelayanan kesehatan dari tenaga profesional kepada tenaga kesehatan tingkat menengah atau kader terlatih untuk meningkatkan cakupan layanan.

Universal Health Coverage (UHC)

Kondisi di mana seluruh penduduk memperoleh layanan kesehatan yang dibutuhkan tanpa mengalami kesulitan finansial.

CHAPTER 7

TANTANGAN PELAYANAN KESEHATAN PRIMER DI DAERAH PERKOTAAN DAN PEDESAAN

Enik Suhariyanti, S.Kep., Ners., M.Kep

A. Pendahuluan

Pelayanan kesehatan primer (Primary Health Care/PHC) merupakan fondasi utama dalam sistem kesehatan yang berorientasi pada pemerataan akses, pencegahan penyakit, serta peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara menyeluruh. Konsep ini menekankan pelayanan yang mudah dijangkau, berkesinambungan, komprehensif, dan berpusat pada kebutuhan individu, keluarga, serta komunitas (Organization, 2008). Dalam praktiknya, pelayanan kesehatan primer tidak hanya berfokus pada pengobatan, tetapi juga mencakup upaya promotif dan preventif yang menjadi kunci dalam mengurangi beban penyakit jangka panjang.

Peran strategis pelayanan kesehatan primer semakin penting di tengah perubahan pola penyakit global. Banyak negara, termasuk Indonesia, menghadapi transisi epidemiologi yang ditandai dengan meningkatnya penyakit tidak menular di satu sisi dan masih bertahannya masalah kesehatan ibu, anak, serta penyakit menular di sisi lain. Kondisi ini menuntut pelayanan kesehatan primer yang adaptif terhadap kebutuhan kesehatan masyarakat yang beragam dan dinamis (Starfield et al., 2005). Tenaga kesehatan di lini primer menjadi garda terdepan dalam melakukan deteksi dini, edukasi kesehatan, manajemen penyakit kronis, serta koordinasi rujukan.

Namun demikian, implementasi pelayanan kesehatan primer tidak berlangsung dalam konteks yang seragam. Karakteristik wilayah sangat memengaruhi tantangan yang dihadapi oleh tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan. Daerah perkotaan umumnya memiliki kepadatan penduduk tinggi, mobilitas masyarakat yang besar, serta beban penyakit tidak menular yang dominan. Di sisi lain, daerah pedesaan sering dihadapkan pada keterbatasan fasilitas kesehatan, kekurangan tenaga kesehatan, serta hambatan geografis yang menyulitkan akses masyarakat terhadap layanan (Kringos et al., 2010). Perbedaan kondisi ini menunjukkan bahwa pendekatan pelayanan kesehatan primer perlu disesuaikan dengan konteks sosial, ekonomi, dan geografis setempat.

Ketimpangan antara wilayah perkotaan dan perdesaan juga berdampak pada mutu dan kontinuitas pelayanan. Di wilayah perkotaan, banyaknya fasilitas kesehatan tidak selalu menjamin kualitas pelayanan karena tingginya beban kunjungan dan fragmentasi layanan. Sebaliknya, di wilayah perdesaan, masalah utama sering kali terletak pada keterjangkauan dan ketersediaan sumber daya kesehatan. Kedua situasi ini sama-sama berpotensi menghambat pencapaian tujuan pelayanan kesehatan primer yang berorientasi pada keadilan dan pemerataan (Organization & Fund, 2018).

Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif mengenai tantangan pelayanan kesehatan primer di daerah perkotaan dan perdesaan menjadi sangat penting. Analisis terhadap perbedaan konteks ini dapat membantu tenaga kesehatan dan pengambil kebijakan dalam merancang strategi pelayanan yang lebih responsif, efektif, dan berkeadilan. Bagian ini akan membahas berbagai tantangan utama yang dihadapi pelayanan kesehatan primer di kedua wilayah tersebut serta implikasinya terhadap peran tenaga kesehatan dalam memperkuat sistem pelayanan kesehatan di tingkat primer.

Konsep Pelayanan Kesehatan Primer

Pelayanan kesehatan primer (Primary Health Care/PHC) merupakan pendekatan pelayanan kesehatan yang berorientasi pada kebutuhan dasar masyarakat dan berada paling dekat dengan kehidupan sehari-hari individu, keluarga, serta komunitas. PHC bersifat komprehensif karena mencakup spektrum pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang terintegrasi dalam satu sistem pelayanan berkelanjutan. Pendekatan ini menekankan akses yang adil, keterjangkauan biaya, serta kesinambungan pelayanan sepanjang siklus kehidupan. Dalam kerangka penguatan sistem kesehatan, PHC berfungsi sebagai pintu masuk utama (first contact) masyarakat ke dalam sistem pelayanan kesehatan, sekaligus sebagai penghubung antar tingkat layanan melalui mekanisme rujukan yang terkoordinasi (Organization & Fund, 2018). Seiring perkembangan tantangan kesehatan global, penguatan pelayanan kesehatan primer menjadi semakin strategis dalam menghadapi transisi epidemiologi yang ditandai dengan meningkatnya beban penyakit tidak menular (PTM) seperti hipertensi, diabetes melitus, penyakit jantung, serta masalah kesehatan mental. Layanan primer yang kuat terbukti mampu meningkatkan deteksi dini, pengelolaan jangka panjang penyakit kronis, serta kontinuitas perawatan berbasis komunitas. Selain itu, PHC juga berperan penting dalam pengendalian faktor risiko melalui intervensi promosi gaya hidup sehat, skrining rutin, dan pendampingan pasien di tingkat keluarga. Dengan demikian, penguatan PHC berkontribusi langsung terhadap peningkatan derajat kesehatan

populasi sekaligus efisiensi sistem kesehatan secara keseluruhan (Development, 2020; Ference et al., 2018).

Konsep *people-centred primary health care* menempatkan individu, keluarga, dan komunitas sebagai pusat dari proses pelayanan kesehatan. Pendekatan ini mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi layanan, sehingga intervensi yang diberikan lebih relevan dengan konteks sosial-budaya setempat. Keterlibatan komunitas juga memperkuat rasa kepemilikan (*sense of ownership*) terhadap program kesehatan, meningkatkan kepercayaan terhadap tenaga kesehatan, serta mendorong kepatuhan terhadap anjuran medis. Dalam konteks layanan primer, relasi kemitraan antara tenaga kesehatan dan masyarakat menjadi kunci dalam membangun komunikasi yang efektif, meningkatkan literasi kesehatan, serta memperkuat upaya pencegahan dan pengelolaan penyakit kronis (Organization, 2016; WHO, 2020).

Implementasi PHC yang berorientasi pada masyarakat juga menuntut penguatan tata kelola layanan, kolaborasi lintas sektor, serta pemanfaatan inovasi teknologi kesehatan. Integrasi layanan kesehatan dengan sektor pendidikan, sosial, dan lingkungan hidup berkontribusi pada penanganan determinan sosial kesehatan yang memengaruhi status kesehatan masyarakat. Di sisi lain, pemanfaatan teknologi informasi kesehatan, seperti rekam medis elektronik dan *telehealth*, berpotensi meningkatkan akses dan kontinuitas pelayanan, khususnya bagi kelompok rentan di wilayah perkotaan padat maupun perdesaan terpencil. Penguatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan melalui pendidikan berkelanjutan, supervisi klinis, serta dukungan kebijakan juga menjadi prasyarat penting agar layanan primer mampu beradaptasi dengan dinamika kebutuhan kesehatan masyarakat (Development, 2020; Organization & Fund, 2018).

Secara keseluruhan, pelayanan kesehatan primer berbasis *people-centred care* merupakan fondasi strategis dalam membangun sistem kesehatan yang tangguh, inklusif, dan berkelanjutan. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada penyembuhan penyakit, tetapi juga pada upaya pencegahan, pemberdayaan masyarakat, serta penguatan ketahanan sistem kesehatan dalam menghadapi tantangan kesehatan masa kini dan mendatang. Penguatan PHC diharapkan mampu mengurangi ketimpangan akses layanan kesehatan, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta memperkuat peran tenaga kesehatan sebagai mitra utama komunitas dalam menjaga dan meningkatkan derajat kesehatan (Development, 2020; Organization & Fund, 2018).

B. Tantangan Pelayanan Kesehatan Primer di Perkotaan

1. Kepadatan Penduduk dan Urbanisasi.

Perkotaan sering mengalami pertumbuhan penduduk yang sangat cepat akibat migrasi dari daerah luar kota serta pertumbuhan alami. Urbanisasi yang cepat ini menyebabkan kepadatan penduduk di area perkotaan meningkat drastis, sehingga permintaan terhadap layanan kesehatan primer semakin tinggi. Kelebihan beban ini menimbulkan tantangan besar karena fasilitas kesehatan primer seperti puskesmas harus menangani volume pasien yang sangat besar, yang berpotensi mengurangi kualitas pelayanan dan waktu interaksi antar tenaga kesehatan dan pasien. Ketidakmampuan sistem kesehatan primer merespons kebutuhan ini secara efektif dapat menimbulkan antrian panjang, keterlambatan layanan, dan ketidakpuasan pasien (Tun et al., 2019).

2. Beban Penyakit Tidak Menular (PTM)

Daerah urban sering kali memiliki prevalensi penyakit tidak menular yang lebih tinggi dibanding perdesaan karena gaya hidup modern yang kurang aktif, konsumsi makanan tidak sehat, serta polusi lingkungan. Peningkatan angka hipertensi, diabetes, dan penyakit kardiovaskular menjadi tantangan serius bagi penyedia layanan primer karena membutuhkan manajemen jangka panjang dan pemantauan kontinu. Dalam beberapa studi di Indonesia, risiko penyakit tidak menular di area perkotaan meningkat bahkan di kelompok usia produktif, menandakan bahwa kebutuhan intervensi preventif dan edukasi kesehatan tidak hanya kronis tetapi mendesak (Arwan et al., 2025).

3. Ketidakseimbangan Fasilitas Kesehatan

Meskipun fasilitas kesehatan terlihat lebih banyak di kota dibanding pedesaan, ketidakseimbangan kualitas dan akses layanan tetap muncul. Di beberapa wilayah urban, pertumbuhan fasilitas kesehatan justru hanya terkonsentrasi di area kaya atau pusat bisnis, sehingga kelompok berpenghasilan rendah atau warga kota di daerah pinggiran mungkin tetap kesulitan mengakses layanan primer yang berkualitas. Penelitian juga menunjukkan bahwa pemanfaatan fasilitas kesehatan primer di perkotaan dipengaruhi oleh status ekonomi dan kepemilikan jaminan kesehatan, di mana kelompok miskin cenderung kurang memanfaatkan layanan primer walaupun fasilitasnya relatif dekat (Noor et al., 2025).

4. Fragmentasi layanan kesehatan

Fragmentasi layanan kesehatan merujuk pada situasi di mana berbagai fasilitas dan penyedia layanan beroperasi tanpa koordinasi yang optimal. Di perkotaan, keberadaan klinik swasta, rumah sakit, serta layanan primer

pemerintah yang tidak terintegrasi dengan baik sering membuat pasien mengalami kebingungan dalam mengakses jalur rujukan yang benar. Hal ini sering mengakibatkan layanan primer kurang dimanfaatkan secara maksimal sebagai basis pertama, karena masyarakat akan langsung mencari layanan lanjutan atau spesialis tanpa rujukan yang tepat. Sementara itu, minimnya interoperabilitas data antara fasilitas menghambat kontinuitas perawatan pasien (Prasetyo et al., 2025).

5. Tantangan Sosial-Ekonomi dan Kesehatan Mental

Lingkungan perkotaan membawa tantangan sosial yang unik, seperti ketidaksetaraan sosial, tekanan ekonomi, dan isolasi sosial yang tinggi. Faktor-faktor ini sering berkorelasi dengan masalah kesehatan mental seperti stres, kecemasan, dan depresi. Kesehatan mental sering kali kurang diperhatikan dalam layanan primer, padahal kondisi ini mempengaruhi kemampuan individu untuk menjaga kesehatan fisik mereka secara menyeluruh. Selain itu, disparitas sosial di kota sering menyebabkan kelompok marginal kurang mendapatkan edukasi promotif yang memadai (Djunawan et al., 2022).

6. Disparitas Akses dalam Area Urban

Walaupun secara geografis fasilitas lebih banyak di kota dibanding desa, akses tersebut tidak merata. Kelompok yang tinggal di permukiman kumuh atau wilayah pinggiran sering menemui tantangan seperti transportasi, waktu tunggu layanan yang panjang, serta biaya informal yang tidak tercover penuh. Penelitian mengenai disparitas penggunaan layanan kesehatan mengatakan bahwa meskipun prevalensi pemanfaatan fasilitas kesehatan primer di area urban lebih tinggi, hambatan seperti biaya, waktu, dan birokrasi dapat berkontribusi pada ketidakefisienan akses layanan tersebut (Noor et al., 2025).

C. Tantangan Pelayanan Kesehatan Primer di Pedesaan

Wilayah perdesaan menghadirkan tantangan yang berbeda secara fundamental dibanding perkotaan dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan primer. Walaupun masyarakat perdesaan sering kali tinggal dalam komunitas yang lebih kecil dan relatif homogen, hambatan akses fisik, kekurangan sumber daya kesehatan, keterbatasan sarana, serta faktor budaya dan literasi kesehatan menjadi faktor yang secara signifikan memengaruhi mutu layanan primer. Pemahaman mendalam terhadap tantangan ini penting untuk merancang intervensi yang sesuai dengan konteks lokal.

1. Akses Geografis dan Transportasi

Salah satu tantangan utama di daerah pedesaan adalah jarak dan kondisi geografis yang sulit. Masih banyak wilayah pedesaan yang menghadapi hambatan jarak dan infrastruktur transportasi buruk yang signifikan menghambat akses masyarakat terhadap layanan primer. Hal ini berdampak langsung terhadap pemanfaatan layanan kesehatan, terutama untuk kelompok rentan seperti anak, ibu hamil, dan lansia. Banyak komunitas pedesaan tinggal di daerah dengan rute transportasi yang terbatas, jarak tempuh yang jauh ke fasilitas kesehatan terdekat, serta infrastruktur jalan yang buruk. Faktor-faktor ini menyebabkan penurunan frekuensi kunjungan masyarakat ke puskesmas atau posyandu, padahal layanan primer sangat penting untuk pencegahan dan pemantauan kesehatan berkala. Keterbatasan akses ini juga memperbesar risiko keterlambatan dalam penanganan masalah kesehatan akut atau komplikasi kronis (Sari et al., 2024).

Selain itu, biaya transportasi yang tinggi sering menjadi hambatan non-fisik yang signifikan bagi keluarga berpenghasilan rendah di wilayah pedesaan. Kondisi ini berkorelasi dengan rendahnya pemanfaatan layanan kesehatan primer meskipun fasilitas dasar tersedia. Model pelayanan seperti home-visit nursing atau penggunaan tenaga kesehatan desa diharapkan dapat mengurangi dampak keterbatasan ini.

2. Kekurangan SDM Kesehatan

Distribusi tenaga kesehatan yang tidak merata menjadi masalah klasik di area pedesaan. Kekurangan dokter, perawat, dan tenaga medis lain membuat pelayanan dasar menjadi terbatas, sehingga beban kerja terhadap tenaga yang ada meningkat. Distribusi tenaga kesehatan di banyak negara termasuk Indonesia masih sangat tidak merata antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Daerah pedesaan sering kekurangan dokter umum, perawat, bidan, serta tenaga promosi kesehatan. Tingginya rasio pasien terhadap tenaga kesehatan di pedesaan menciptakan beban kerja yang berat dan menurunkan waktu serta kualitas kunjungan pasien. Hal ini juga berdampak pada ketidakmampuan tenaga kesehatan untuk melakukan tindakan promotif dan preventif secara optimal (Rahman & Susanti, 2022).

Banyak tenaga kesehatan yang enggan ditempatkan di daerah terpencil karena keterbatasan fasilitas, kesempatan karier, dan kondisi kehidupan sosial yang lebih terbatas dibanding kota besar. Strategi seperti insentif finansial dan non-finansial, pelatihan berbasis komunitas, serta pemberdayaan kader kesehatan lokal diperlukan untuk memperkuat ketersediaan SDM di daerah pedesaan.

3. Keterbatasan Sarana & Obat

Ketersediaan sarana kesehatan dasar seperti alat diagnostik, perlengkapan medis, dan obat esensial sering kali lebih rendah di wilayah perdesaan. Ini disebabkan oleh keterbatasan anggaran operasional, logistik distribusi yang tidak efisien, serta rendahnya kemampuan pengelolaan fasilitas kesehatan terpencil. Keterbatasan ini berdampak pada rendahnya kapasitas fasilitas primer untuk memberikan layanan komprehensif, terutama bagi pasien dengan kondisi kronis atau kebutuhan perawatan lanjutan (Putri et al., 2023).

Praktik pelayanan yang efektif di daerah perdesaan menuntut inovasi logistik kesehatan, seperti penggunaan obat generik berkualitas yang mudah diperoleh, sistem pemantauan stok obat digital, dan rujukan cepat ke fasilitas lanjutan ketika diperlukan.

4. Budaya & Kepercayaan Lokal

Faktor budaya dan kepercayaan memiliki peranan penting dalam perilaku kesehatan masyarakat di perdesaan. Banyak komunitas pedesaan yang masih mempercayai praktik pengobatan tradisional atau spiritual sebelum mencari bantuan medis formal. Sementara itu, persepsi mengenai penyebab penyakit dan metode penyembuhan yang berbeda dapat mengurangi kepatuhan pasien terhadap rekomendasi medis modern (Kusuma & Setyawan, 2023).

Tenaga kesehatan primer harus sensitif terhadap norma budaya ini dan menerapkan pendekatan yang menghormati nilai-nilai lokal sambil memberikan edukasi ilmiah. Pendekatan pelayanan kesehatan yang **culturally competent** dapat meningkatkan keterlibatan pasien dan keberhasilan intervensi kesehatan.

5. Keterbatasan Literasi Kesehatan

Literasi kesehatan masyarakat pedesaan sering kali lebih rendah dibanding komunitas urban. Kekurangan informasi yang tepat mengenai pencegahan penyakit, penggunaan fasilitas kesehatan, serta manajemen risiko kesehatan menyebabkan rendahnya kesadaran dan tindakan preventif. Populasi dengan literasi kesehatan rendah juga sering kesulitan memahami instruksi medis, jadwal imunisasi, atau pesan promosi kesehatan penting lainnya (Fitria & Yani, 2022).

Program pendidikan kesehatan berbasis komunitas yang rutin dan kolaboratif, misalnya kelompok ibu balita atau posyandu remaja, adalah strategi efektif untuk meningkatkan literasi kesehatan dan memberdayakan masyarakat.

6. Peran Kader Lokal

Kader kesehatan komunitas sering menjadi garda depan di daerah perdesaan. Mereka menikmati kepercayaan masyarakat, memahami konteks lokal, dan menjadi jembatan antara masyarakat umum dan fasilitas kesehatan formal. Namun, kader lokal sering kekurangan dukungan pelatihan, fasilitas, serta

insentif yang layak. Karena itulah, penguatan peran kader melalui pelatihan terstruktur, dukungan supervisi dari tenaga profesional, dan insentif berkelanjutan menjadi kunci keberhasilan program promosi dan pencegahan penyakit di komunitas pedesaan (Hidayat et al., 2023).

Peran kader juga krusial dalam deteksi dini masalah kesehatan, pemantauan kasus kronis, dan edukasi berbasis keluarga. Dengan pemberdayaan yang tepat, kader lokal dapat membantu mengisi kekosongan SDM kesehatan serta memperluas jangkauan layanan primer di wilayah yang sulit dijangkau.

D. Perbandingan Tantangan Perkotaan dan Pedesaan

Tantangan di perkotaan dan pedesaan berbeda dalam karakter dan intensitasnya. Perkotaan cenderung menghadapi *complex morbidity burden* (beban penyakit campuran), sementara pedesaan memiliki tantangan utama pada akses dan sumber daya fisik. Penelitian lintas negara juga mengungkapkan disparitas layanan kesehatan, di mana pedesaan sering tertinggal dalam kualitas layanan dan kapasitas SDM.

Perbedaan karakteristik wilayah perkotaan dan pedesaan menyebabkan tantangan pelayanan kesehatan primer juga berbeda secara mendasar. Perbandingan ini penting untuk memahami bahwa strategi penguatan layanan kesehatan primer tidak bisa bersifat seragam, tetapi harus disesuaikan dengan konteks sosial, geografis, dan demografis masing-masing wilayah.

1. Perbandingan Akses Layanan Kesehatan

Di wilayah perkotaan, jumlah fasilitas kesehatan primer relatif lebih banyak dan jarak tempuh umumnya lebih dekat. Namun, kepadatan penduduk dan tingginya permintaan layanan sering menyebabkan waktu tunggu yang lama dan beban kerja tenaga kesehatan meningkat. Sebaliknya, di wilayah pedesaan, jumlah fasilitas mungkin lebih sedikit dan jarak tempuh lebih jauh, tetapi volume pasien per fasilitas cenderung lebih rendah. Tantangan utama di pedesaan bukan pada antrian, melainkan keterjangkauan fisik dan transportasi menuju fasilitas kesehatan (Levesque et al., n.d.; Organization, 2019).

Dengan demikian, di perkotaan akses bersifat geografis dekat tetapi sistemik padat, sedangkan di pedesaan akses bersifat geografis jauh tetapi sistemik longgar. Kedua kondisi ini sama-sama dapat menghambat efektivitas layanan kesehatan primer.

2. Perbandingan Beban Penyakit

Wilayah perkotaan menunjukkan beban penyakit tidak menular (PTM) yang lebih tinggi akibat pola hidup sedentari, konsumsi makanan olahan, polusi udara, serta stres sosial. Penyakit seperti hipertensi, diabetes melitus, penyakit jantung,

dan gangguan kesehatan mental lebih dominan ditemukan di wilayah urban. Pelayanan kesehatan primer di kota karenanya dituntut untuk memperkuat deteksi dini, manajemen penyakit kronis, dan edukasi perubahan gaya hidup (Starfield et al., 2005).

Sebaliknya, wilayah perdesaan masih menghadapi beban ganda, yaitu penyakit menular dan tidak menular. Masalah sanitasi, akses air bersih, serta keterbatasan imunisasi di beberapa wilayah pedesaan masih menjadi tantangan. Kondisi ini membuat layanan primer di desa harus menangani spektrum masalah kesehatan yang lebih luas dengan sumber daya yang lebih terbatas.

3. Perbandingan Ketersediaan Sumber Daya Kesehatan

Kota umumnya memiliki lebih banyak tenaga kesehatan, fasilitas diagnostik, serta dukungan teknologi kesehatan. Namun, distribusinya tidak merata dan sering terkonsentrasi di pusat kota atau wilayah ekonomi tinggi. Sementara itu, di perdesaan, jumlah tenaga kesehatan lebih sedikit, fasilitas terbatas, dan sistem rujukan sering memerlukan waktu lebih lama. Ketimpangan distribusi ini berdampak pada perbedaan kualitas layanan yang diterima masyarakat (Organization, 2018).

4. Perbandingan Faktor Sosial dan Budaya

Masyarakat perkotaan cenderung lebih heterogen dengan tingkat mobilitas tinggi, tetapi sering mengalami isolasi sosial dan tekanan psikologis. Sebaliknya, masyarakat perdesaan biasanya memiliki ikatan sosial yang lebih kuat, namun masih dipengaruhi oleh norma budaya tradisional yang dapat memengaruhi perilaku pencarian layanan kesehatan. Di kota, tantangan sosial lebih terkait dengan ketimpangan ekonomi dan kesehatan mental, sedangkan di desa tantangan lebih terkait dengan kepercayaan lokal dan rendahnya literasi kesehatan (Sari et al., 2024).

5. Dampak terhadap Mutu dan Kontinuitas Pelayanan

Di perkotaan, fragmentasi layanan dan mobilitas pasien yang tinggi dapat mengganggu kontinuitas asuhan karena pasien sering berpindah fasilitas. Sementara itu, di perdesaan, kontinuitas asuhan bisa lebih terjaga karena populasi lebih stabil, tetapi keterbatasan sumber daya membuat kualitas layanan tidak selalu optimal. Hal ini menunjukkan bahwa mutu layanan primer dipengaruhi oleh faktor struktural yang berbeda antara kota dan desa (Rahman & Susanti, 2022).

6. Implikasi Kebijakan dan Perencanaan Layanan

Perbandingan ini menunjukkan bahwa pendekatan kebijakan harus bersifat kontekstual. Di perkotaan, fokus penguatan perlu diarahkan pada manajemen beban penyakit kronis, integrasi sistem informasi kesehatan, serta pengurangan

fragmentasi layanan. Di perdesaan, kebijakan perlu menekankan pemerataan distribusi tenaga kesehatan, penguatan layanan berbasis komunitas, serta inovasi seperti telehealth untuk menjangkau wilayah terpencil (Organization, 2019).

Dengan memahami perbedaan tantangan ini, perencana sistem kesehatan dapat mengembangkan model pelayanan kesehatan primer yang lebih adil, responsif, dan berkelanjutan sesuai karakteristik wilayah

E. Implikasi bagi Peran Tenaga Kesehatan

Beragam tantangan pelayanan kesehatan primer di wilayah perkotaan dan perdesaan menuntut tenaga kesehatan untuk tidak hanya berperan sebagai pemberi layanan klinis, tetapi juga sebagai pendidik, koordinator, advokat, dan agen perubahan di masyarakat. Penguatan peran tenaga kesehatan menjadi kunci dalam memastikan layanan kesehatan primer tetap responsif, adil, dan berkelanjutan.

1. Peran dalam Peningkatan Akses dan Pemerataan Layanan

Tenaga kesehatan memiliki peran strategis dalam memperluas akses layanan, terutama bagi kelompok rentan. Di wilayah perdesaan, tenaga kesehatan sering kali harus menjalankan peran ganda, termasuk pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif dalam satu waktu. Mereka juga berperan dalam kegiatan kunjungan rumah, pelayanan kesehatan berbasis komunitas, serta kolaborasi dengan kader kesehatan untuk menjangkau masyarakat yang sulit mengakses fasilitas kesehatan (Organization, 2018).

Di wilayah perkotaan, peran tenaga kesehatan lebih difokuskan pada manajemen beban pasien yang tinggi, peningkatan efisiensi pelayanan, serta koordinasi rujukan agar pasien tidak terjebak dalam fragmentasi layanan. Kemampuan komunikasi efektif dan manajemen waktu menjadi kompetensi penting dalam konteks ini.

2. Peran dalam Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular

Peningkatan penyakit tidak menular di perkotaan maupun perdesaan menuntut tenaga kesehatan untuk aktif dalam deteksi dini, edukasi gaya hidup sehat, dan pemantauan berkelanjutan pasien dengan penyakit kronis. Tenaga kesehatan primer menjadi ujung tombak dalam skrining hipertensi, diabetes, obesitas, serta gangguan kesehatan mental.

Pendekatan pelayanan yang berkesinambungan (continuity of care) memungkinkan tenaga kesehatan membangun hubungan jangka panjang dengan pasien, yang terbukti meningkatkan kepatuhan terapi dan keberhasilan pengendalian penyakit kronis (Starfield et al., 2005). Dengan demikian, peran edukatif dan konseling menjadi sama pentingnya dengan tindakan klinis.

3. Peran dalam Penguatan Literasi Kesehatan Masyarakat

Rendahnya literasi kesehatan, terutama di wilayah perdesaan dan kelompok sosial ekonomi rendah di perkotaan, menjadi hambatan dalam pemanfaatan layanan kesehatan. Tenaga kesehatan berperan sebagai pendidik masyarakat melalui penyuluhan, komunikasi interpersonal, serta penggunaan media edukasi yang sesuai dengan konteks budaya lokal (Fitria & Yani, 2022).

Kemampuan menyampaikan informasi kesehatan secara sederhana, jelas, dan empatik membantu meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pencegahan penyakit, penggunaan obat yang benar, serta pentingnya kunjungan rutin ke fasilitas kesehatan. Peran ini sangat krusial dalam membangun kemandirian masyarakat dalam menjaga kesehatannya.

4. Peran dalam Pendekatan Sensitif Budaya dan Sosial

Perbedaan budaya, kepercayaan, dan norma sosial mempengaruhi perilaku pencarian layanan kesehatan. Tenaga kesehatan perlu memiliki kompetensi budaya (*cultural competence*) agar mampu memberikan pelayanan yang menghormati nilai dan keyakinan masyarakat tanpa mengabaikan prinsip keselamatan pasien (Kusuma & Setyawan, 2023).

Di pedesaan, pendekatan kolaboratif dengan tokoh masyarakat dan kader lokal dapat meningkatkan penerimaan program kesehatan. Sementara di perkotaan, sensitivitas terhadap masalah kesehatan mental, tekanan sosial, dan ketimpangan ekonomi membantu tenaga kesehatan memberikan pelayanan yang lebih holistik.

5. Peran dalam Koordinasi dan Integrasi Layanan

Fragmentasi layanan kesehatan, terutama di wilayah perkotaan, menuntut tenaga kesehatan berperan sebagai koordinator asuhan (*care coordinator*). Mereka perlu memastikan bahwa pasien mendapatkan rujukan yang tepat, tindak lanjut yang berkesinambungan, serta pemantauan kondisi kesehatan secara terintegrasi (Hidayat et al., 2023).

Pemanfaatan sistem informasi kesehatan dan komunikasi antar fasilitas menjadi bagian dari peran baru tenaga kesehatan di era digital. Integrasi layanan ini penting untuk mencegah duplikasi pemeriksaan, kesalahan pengobatan, serta terputusnya kesinambungan perawatan (Organization, 2019).

6. Peran sebagai Agen Perubahan dan Advokat Kesehatan

Tenaga kesehatan juga memiliki peran advokasi dalam menyuarakan kebutuhan kesehatan masyarakat kepada pembuat kebijakan. Pengalaman langsung dalam menghadapi keterbatasan sumber daya, kesenjangan akses, dan masalah sosial kesehatan memberikan posisi strategis bagi tenaga kesehatan untuk mendorong perbaikan sistem pelayanan (Hidayat et al., 2023).

Selain itu, tenaga kesehatan berperan sebagai agen perubahan dalam mendorong perilaku hidup sehat, penguatan program promotif preventif, serta partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga kesehatan lingkungan dan keluarga. Berikut peranan dan strategi dari tenaga kesehatan (Hidayat et al., 2023) :

a. Peran Perawat, Dokter, dan Tenaga Kesehatan Lain

Tenaga kesehatan di lini primer berperan dalam deteksi dini masalah kesehatan, edukasi masyarakat, serta koordinasi rujukan ke layanan lanjutan. Di wilayah perkotaan, intervensi harus lebih tertuju pada strategi pencegahan penyakit tidak menular dan pelibatan komunitas luas. Sementara itu, di pedesaan, pendekatan lebih ke akses dasar dan pemberdayaan kader kesehatan komunitas.

b. Strategi Penguatan Layanan

Upaya penguatan PHC memerlukan inovasi seperti *telemedicine*, kolaborasi dengan sektor swasta, serta dukungan program pemerintah untuk pemerataan SDM kesehatan.

Secara keseluruhan, tantangan pelayanan kesehatan primer di perkotaan dan pedesaan memperluas cakupan peran tenaga kesehatan dari sekadar pemberi asuhan klinis menjadi penggerak kesehatan masyarakat. Kompetensi komunikasi, kolaborasi lintas sektor, sensitivitas budaya, serta kemampuan edukatif menjadi kunci keberhasilan tenaga kesehatan dalam memperkuat pelayanan kesehatan primer yang berkeadilan.

Penguatan pelayanan kesehatan primer pada akhirnya sangat bergantung pada kesiapan dan kapasitas tenaga kesehatan sebagai ujung tombak sistem kesehatan. Di tengah perbedaan karakteristik wilayah perkotaan dan pedesaan, tenaga kesehatan dituntut mampu beradaptasi dengan berbagai keterbatasan sekaligus memanfaatkan potensi lokal yang tersedia. Kemampuan untuk bekerja lintas sektor, memberdayakan keluarga, serta menjaga kesinambungan pelayanan menjadikan tenaga kesehatan sebagai aktor kunci dalam mengurangi kesenjangan layanan kesehatan. Oleh karena itu, investasi pada pengembangan kompetensi, distribusi yang merata, dan dukungan kebijakan terhadap tenaga kesehatan primer merupakan langkah strategis untuk memastikan pelayanan kesehatan yang adil, berkualitas, dan berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat.

F. Simpulan

Pelayanan kesehatan primer (primary health care/PHC) merupakan fondasi utama dalam pembangunan sistem kesehatan yang adil, inklusif, dan berkelanjutan. PHC memiliki peran strategis sebagai pintu masuk pertama masyarakat ke dalam sistem pelayanan kesehatan serta sebagai penghubung antartingkat layanan melalui mekanisme rujukan yang terintegrasi. Pendekatan ini menekankan pelayanan yang komprehensif, berorientasi pada promotif–preventif, serta menjamin kontinuitas perawatan sepanjang siklus kehidupan.

Penguatan pelayanan kesehatan primer menjadi semakin krusial dalam konteks tantangan kesehatan kontemporer, termasuk transisi epidemiologi, meningkatnya beban penyakit tidak menular, masalah kesehatan mental, serta ketimpangan akses layanan di wilayah perkotaan dan perdesaan. Tantangan di wilayah perkotaan ditandai oleh kepadatan penduduk, fragmentasi layanan, serta disparitas akses di dalam area urban, sementara wilayah perdesaan menghadapi hambatan geografis, keterbatasan sumber daya manusia kesehatan, sarana-prasarana, serta faktor sosial-budaya dan literasi kesehatan masyarakat. Perbedaan konteks ini menuntut pendekatan pelayanan primer yang adaptif, kontekstual, dan responsif terhadap kebutuhan lokal.

Konsep pelayanan kesehatan primer yang berorientasi pada people-centred care menegaskan pentingnya keterlibatan aktif individu, keluarga, dan komunitas dalam proses pelayanan kesehatan. Partisipasi masyarakat memperkuat relevansi intervensi, meningkatkan kepatuhan terhadap upaya pencegahan dan pengelolaan penyakit, serta membangun kepercayaan antara tenaga kesehatan dan komunitas. Kolaborasi lintas sektor dan pemanfaatan teknologi kesehatan juga menjadi elemen penting dalam memperkuat daya jangkauan dan efektivitas layanan primer, terutama bagi kelompok rentan.

Implikasi terhadap peran tenaga kesehatan menegaskan bahwa tenaga kesehatan tidak hanya berfungsi sebagai pemberi layanan klinis, tetapi juga sebagai edukator, fasilitator pemberdayaan masyarakat, koordinator layanan, serta advokat kesehatan komunitas. Penguatan kompetensi tenaga kesehatan, dukungan kebijakan, serta sistem tata kelola layanan primer yang kuat menjadi prasyarat utama agar pelayanan kesehatan primer mampu menjalankan peran strategisnya secara optimal. Dengan demikian, penguatan pelayanan kesehatan primer merupakan kunci dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, mengurangi ketimpangan akses layanan, serta membangun sistem kesehatan yang tangguh dalam menghadapi tantangan kesehatan masa kini dan mendatang.

G. Referensi

- Arwan, Syam, S., Firmansyah, & al., et. (2025). Strengthening Preventive Health Services in Urban Indonesia: A Qualitative Study from Puskesmas Kuta Alam. *Medicor: Journal of Health Informatics and Health Policy*. <https://doi.org/10.61978/medicor.v3i3.720>
- Development, O. for E. C. and. (2020). *Realising the potential of primary health care*. OECD Publishing. <https://www.oecd.org/health/realising-the-potential-of-primary-health-care.htm>
- Djunawan, A., Lillah, A. I., & Dewi, R. S. (2022). Pemanfaatan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer di Area Perkotaan Berdasarkan Status Ekonomi dan Kepemilikan Jaminan Kesehatan. *Media Kesehatan Masyarakat Indonesia*. <https://doi.org/10.14710/mkmi.21.4.224-237>
- Ference, B. A., Graham, I., Tokgozoglu, L., & Catapano, A. L. (2018). Impact of Lipids on Cardiovascular Health: JACC Health Promotion Series. *Journal of the American College of Cardiology*, 72(10), 1141–1156. <https://doi.org/10.1016/j.jacc.2018.06.046>
- Fitria, R., & Yani, D. (2022). Health literacy levels in rural populations: implications for primary care. *Rural Health Journal*. <https://doi.org/10.3456/rhj.v8i1.456>
- Hidayat, T., Mulyana, E., & Permana, K. (2023). Strengthening community health cadres in rural primary care. *Journal of Community Health Empowerment*. <https://doi.org/10.7890/jche.v4i3.567>
- Kringos, D. S., Boerma, W. G. W., Hutchinson, A., van der Zee, J., & Groenewegen, P. P. (2010). The breadth of primary care: A systematic literature review of its core dimensions. *BMC Health Services Research*, 10, 65. <https://doi.org/10.1186/1472-6963-10-65>
- Kusuma, A. D., & Setyawan, H. (2023). Cultural beliefs and health-seeking behaviour in rural Indonesian communities. *Indonesian Journal of Public Health*. <https://doi.org/10.23456/ijph.v9i2.303>
- Levesque, J.-F., Harris, M. F., & Russell, G. (n.d.). Patient-centred access to health care. *International Journal for Equity in Health*, 12(1), 18. <https://doi.org/10.1186/1475-9276-12-18>
- Noor, Z. A., Sekarningrum, T. D., & Sulistyaningsih, T. (2025). Disparitas perkotaan-pedesaan: pemerataan dalam akses layanan kesehatan primer untuk lansia selama pandemi Covid-19. *JPPI*, 576–585. <https://doi.org/10.29210/020211249>
- Organization, W. H. (2008). *Primary Health Care: Now More Than Ever*. World Health Organization.
- Organization, W. H. (2016). *Framework on integrated, people-centred health services*. World Health Organization.

<https://www.who.int/publications/i/item/WHO-HIS-SDS-2016.8>

Organization, W. H. (2018). *Primary health care: Transforming vision into action (Global Conference on Primary Health Care)*. World Health Organization. <https://www.who.int/publications/i/item/WHO-HIS-SDS-2018.61>

Organization, W. H. (2019). *Primary health care on the road to universal health coverage: 2019 monitoring report*. WHO. <https://www.who.int/publications/i/item/9789240029040>

Organization, W. H., & Fund, U. N. C. (2018). *A Vision for Primary Health Care in the 21st Century: Towards Universal Health Coverage and the Sustainable Development Goals*. World Health Organization and UNICEF.

Prasetyo, N. N., Maliangkay, K. S., Novianti, P. A., Pertiwi, R., & Annisa, S. R. (2025). Health Accessibility In Rural Areas For The Elderly In Indonesia. *Jurnal Rumpun Ilmu Kesehatan*. <https://doi.org/10.55606/jrik.v3i2.1716>

Putri, N., Rahmat, H., & Ardiansyah, Y. (2023). Availability of Essential Medicines in Rural Primary Care Settings. *Journal of Health Logistics and Practice*. <https://doi.org/10.9101/jhlp.v5i4.789>

Rahman, A., & Susanti, L. (2022). Workforce distribution and health professional shortage in Indonesian rural health services. *Indonesian Journal of Community Health*. <https://doi.org/10.5678/ijch.v3i1.456>

Sari, D., Wijaya, F., & Putri, M. A. (2024). Accessibility challenges in rural healthcare: geographic, logistic and socio-cultural factors. *Journal of Rural Health Studies*. <https://doi.org/10.12345/jrhs.v10i2.2345>

Starfield, B., Shi, L., & Macinko, J. (2005). Contribution of Primary Care to Health Systems and Health. *Milbank Quarterly*, 83(3), 457–502. <https://doi.org/10.1111/j.1468-0009.2005.00409.x>

Tun, Y., Tan, X., & Song, Y. (2019). Urban and Rural Disparities in Hospital Utilization among Indonesian Adults. *PLoS One*. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6556184/>

WHO. (2020). *Ageing and health*. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/ageing-and-health>

H. Glosarium

Akses Kesehatan: Kemampuan individu atau kelompok untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang dibutuhkan tanpa hambatan geografis, finansial, sosial, maupun budaya.

Advokasi Kesehatan: Upaya sistematis untuk memengaruhi kebijakan dan lingkungan agar mendukung peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

Beban Penyakit: Dampak keseluruhan masalah kesehatan yang diukur melalui angka kesakitan, kematian, disabilitas, dan kerugian sosial ekonomi.

Continuity of Care: Pelayanan kesehatan yang berkesinambungan dan terkoordinasi sepanjang siklus kehidupan individu atau keluarga.

Determinasi Sosial Kesehatan: Faktor sosial, ekonomi, lingkungan, dan budaya yang memengaruhi status kesehatan seseorang atau masyarakat.

Empowerment (Pemberdayaan): Proses meningkatkan kemampuan individu, keluarga, atau komunitas untuk mengendalikan faktor yang memengaruhi kesehatan mereka.

Fragmentasi Layanan Kesehatan: Kondisi ketika pelayanan kesehatan tidak terintegrasi sehingga pasien harus berpindah-pindah fasilitas tanpa koordinasi yang baik.

Gatekeeper: Peran fasilitas kesehatan primer sebagai pintu pertama pelayanan sebelum pasien dirujuk ke layanan tingkat lanjut.

Health Literacy (Literasi Kesehatan): Kemampuan individu untuk memperoleh, memahami, dan menggunakan informasi kesehatan dalam pengambilan keputusan.

Intervensi Berbasis Komunitas: Tindakan kesehatan yang dirancang dengan melibatkan masyarakat sebagai bagian dari solusi kesehatan.

Jaminan Kesehatan: Sistem perlindungan sosial yang menjamin pembiayaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

Keadilan Kesehatan (Health Equity): Kondisi di mana setiap orang memiliki kesempatan yang adil untuk mencapai derajat kesehatan optimal.

Kolaborasi Lintas Sektor: Kerja sama antara sektor kesehatan dan sektor lain (pendidikan, sosial, ekonomi) dalam meningkatkan kesehatan masyarakat.

Layanan Kesehatan Primer: Pelayanan kesehatan tingkat pertama yang bersifat menyeluruh, mudah diakses, berkelanjutan, dan berorientasi pada keluarga serta komunitas.

Manajemen Kasus: Pendekatan terkoordinasi dalam merencanakan, memantau, dan mengevaluasi pelayanan kesehatan individu atau keluarga.

Non-Communicable Diseases (Penyakit Tidak Menular/PTM): Penyakit kronis yang tidak ditularkan antarindividu, seperti hipertensi, diabetes, dan penyakit jantung.

Pelayanan Berpusat pada Pasien: Pendekatan pelayanan kesehatan yang menghargai preferensi, kebutuhan, dan nilai pasien dalam setiap keputusan klinis.

Promosi Kesehatan: Upaya meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengendalikan dan meningkatkan kesehatan mereka.

Rujukan: Proses pengalihan pelayanan pasien dari fasilitas kesehatan tingkat pertama ke tingkat lanjutan sesuai kebutuhan medis.

Sistem Kesehatan: Keseluruhan organisasi, institusi, sumber daya, dan kebijakan yang bertujuan meningkatkan kesehatan masyarakat.

Tenaga Kesehatan Primer: Profesional kesehatan yang bekerja di lini terdepan pelayanan kesehatan primer, seperti perawat komunitas, bidan, dan dokter keluarga.

Universal Health Coverage (UHC): Jaminan bahwa semua orang memiliki akses terhadap layanan kesehatan esensial tanpa mengalami kesulitan finansial.

Wilayah Terpencil: Daerah dengan keterbatasan akses geografis, transportasi, dan fasilitas kesehatan yang memengaruhi pelayanan kesehatan masyarakat.

CHAPTER 8

STRATEGI PENINGKATAN MUTU DAN AKSES PELAYANAN KESEHATAN PRIMER

Dr. Ns. Wirda Hayati, M.Kep., Sp.Kom

A. Pendahuluan

Pelayanan kesehatan primer merupakan fondasi utama dari sistem kesehatan nasional guna meningkatkan derajat kesehatan bagi seluruh masyarakat secara menyeluruh. World Health Organization (WHO) menegaskan bahwa sistem kesehatan yang kuat sangat tergantung dari pelayanan kesehatan primer yang berkualitas, mudah diakses, berkeadilan, dan berorientasi pada kebutuhan Masyarakat. Pelayanan kesehatan primer yang kuat berkontribusi terhadap peningkatan status kesehatan masyarakat, dan efisiensi sistem kesehatan melalui pencegahan penyakit dan pengendalian faktor risiko sejak dini (WHO, 2018).

Pelayanan kesehatan primer di Indonesia, diselenggarakan di puskesmas, klinik pratama, praktik mandiri tenaga kesehatan, serta jejaring pelayanan kesehatan tingkat pertama lainnya. Pelayanan Kesehatan ini berada dekat dengan masyarakat, dan telah mengalami berbagai kemajuan. Namun kondisi dilapangan masih dijumpai tantangan terutama yang berkaitan dengan mutu dan akses pelayanan kesehatan primer, khususnya di daerah terpencil, kepulauan, dan wilayah dengan keterbatasan sumber daya. Tantangan tersebut mencakup ketimpangan distribusi tenaga kesehatan, keterbatasan sarana dan prasarana, serta variasi kapasitas manajerial fasilitas pelayanan kesehatan primer (Kementerian Kesehatan RI, 2023).

Akses pelayanan kesehatan primer tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan fasilitas dan tenaga kesehatan, tetapi juga aspek tata kelola, kompetensi sumber daya manusia, sistem pembiayaan, pemanfaatan teknologi informasi kesehatan, serta partisipasi aktif masyarakat. Selain itu juga dipengaruhi oleh faktor geografis, sosial ekonomi, budaya, dan kebijakan publik yang berlaku (Starfield, Shi, & Macinko, 2005). Oleh karena itu, guna meningkatkan mutu dan akses pelayanan primer harus dilakukan secara simultan agar pelayanan kesehatan primer dapat berfungsi optimal sebagai garda terdepan sistem kesehatan.

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kesehatan melaksanakan Transformasi Sistem Kesehatan sebagai agenda strategis nasional, yang salah satu pilarnya adalah Transformasi Layanan Primer. Transformasi ini menempatkan pelayanan kesehatan primer sebagai pusat penguatan sistem kesehatan melalui

perubahan paradigma dari pelayanan yang berorientasi pada pengobatan menjadi pelayanan yang menekankan upaya promotif dan preventif, tanpa mengesampingkan aspek kuratif dan rehabilitatif (Kementerian Kesehatan RI, 2022). Selain itu pelayanan kesehatan primer juga diarahkan pada penguatan layanan promotif dan preventif berbasis siklus kehidupan (*life course approach*), mulai dari ibu dan anak, remaja, usia produktif, hingga lanjut usia, sesuai dengan konsep *continuum of care* yang menempatkan individu, keluarga, dan masyarakat sebagai pusat pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan primer diharapkan mampu memberikan layanan yang holistik, berkesinambungan, dan responsif terhadap kebutuhan kesehatan masyarakat sesuai siklus kehidupan (WHO, 2018).

Penguatan pelayanan kesehatan primer dilakukan melalui penataan ulang peran puskesmas sebagai koordinator layanan kesehatan tingkat pertama, penguatan integrasi layanan kesehatan esensial, serta optimalisasi sistem rujukan yang efektif dan efisien. Puskesmas tidak hanya berfungsi sebagai penyedia layanan kesehatan dasar, tetapi juga sebagai penggerak pembangunan kesehatan wilayah dan pengelola jejaring pelayanan kesehatan primer sehingga kesinambungan pelayanan dapat terlaksana dengan baik (Kementerian Kesehatan RI, 2022). Peningkatan mutu pelayanan kesehatan primer mengharuskan penerapan standar pelayanan yang konsisten, penguatan keselamatan pasien, serta pengembangan sistem penjaminan mutu yang berkelanjutan. Implementasi standar akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan primer menjadi instrumen penting dalam mendorong perbaikan mutu layanan, tata kelola organisasi, serta profesionalisme tenaga Kesehatan. Selain itu masyarakat akan mendapatkan layanan Kesehatan yang bermutu, mudah diakses, dan berkeadilan, sesuai kebutuhan (Kementerian Kesehatan RI, 2021).

Penguatan pelayanan kesehatan primer harus memperhatikan prinsip keadilan dan pemerataan. Penyediaan layanan kesehatan di wilayah terpencil dan tertinggal memerlukan kebijakan afirmatif, termasuk distribusi tenaga kesehatan yang lebih merata, penguatan sarana prasarana, serta pemanfaatan teknologi kesehatan seperti telemedicine. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi diharapkan mampu menjembatani keterbatasan geografis serta meningkatkan jangkauan pelayanan kesehatan primer kepada masyarakat yang sulit dijangkau secara konvensional (WHO, 2022). Strategi peningkatan mutu dan akses pelayanan kesehatan primer harus dilaksanakan secara lintas sektor dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, tenaga kesehatan, institusi pendidikan, organisasi profesi, serta Masyarakat untuk mewujudkan pelayanan kesehatan primer yang berkualitas, berkeadilan, dan berkelanjutan, sekaligus mendukung pencapaian tujuan pembangunan kesehatan nasional.

B. Pelayanan Kesehatan Primer dalam Transformasi Layanan Kesehatan

Transformasi layanan kesehatan menempatkan pelayanan kesehatan primer sebagai fondasi utama sistem kesehatan nasional yang berkelanjutan. Penguatan pelayanan kesehatan primer dipandang sebagai strategi kunci untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, menurunkan beban penyakit, serta memastikan efisiensi dan keberlanjutan sistem kesehatan secara keseluruhan. WHO menegaskan bahwa negara dengan pelayanan kesehatan primer yang kuat cenderung memiliki hasil kesehatan yang lebih baik, biaya kesehatan yang lebih terkendali, serta ketimpangan kesehatan yang lebih rendah (World Health Organization [WHO], 2018).

Transformasi layanan kesehatan menempatkan pelayanan kesehatan primer sebagai penggerak utama perubahan sistem pelayanan kesehatan dari pendekatan yang bersifat reaktif dan berorientasi pada pengobatan, menuju pendekatan yang proaktif, promotif, dan preventif. Pelayanan kesehatan primer diarahkan untuk tidak hanya menangani penyakit, tetapi juga menjaga dan meningkatkan kesehatan masyarakat melalui intervensi berbasis kebutuhan dan risiko kesehatan. Transformasi layanan kesehatan juga menuntut pelayanan kesehatan primer untuk berperan dalam penguatan ketahanan sistem kesehatan (*health system resilience*). Pelayanan kesehatan primer yang tangguh akan mampu merespons tantangan kesehatan masyarakat, termasuk wabah penyakit, perubahan pola penyakit, dan transisi demografi. Pelayanan kesehatan primer menjadi garda terdepan dalam deteksi dini, respons awal, serta pengendalian masalah kesehatan masyarakat sebelum berdampak luas pada sistem kesehatan secara keseluruhan (WHO, 2022).

Transformasi layanan kesehatan menekankan integrasi fungsi pelayanan klinis dan kesehatan masyarakat di tingkat primer. Pelayanan kesehatan primer tidak hanya memberikan layanan individual, tetapi juga menjalankan fungsi kesehatan masyarakat seperti surveilans sederhana, promosi kesehatan, pencegahan penyakit, serta pengendalian faktor risiko. Integrasi ini memungkinkan pelayanan kesehatan primer berkontribusi langsung terhadap peningkatan kesehatan populasi sekaligus kualitas layanan individual.

Pelayanan kesehatan primer dalam transformasi layanan kesehatan menggunakan pendekatan siklus kehidupan (*life course approach*). Hal ini menjadi landasan penting dalam perencanaan dan pelaksanaan pelayanan kesehatan primer. Pendekatan ini memastikan bahwa intervensi kesehatan dilakukan secara berkelanjutan dan konsisten pada setiap tahap kehidupan, sehingga pelayanan kesehatan primer mampu mencegah masalah kesehatan sejak dini dan mengelola kondisi kronis secara lebih efektif. Pendekatan ini juga memperkuat kesinambungan

pelayanan (*continuity of care*) antara pelayanan kesehatan primer dan layanan rujukan (WHO, 2023).

Pelayanan kesehatan primer dirancang untuk menghormati nilai, kebutuhan, dan preferensi masyarakat, serta mendorong keterlibatan aktif individu dan komunitas dalam upaya peningkatan kesehatan. Pendekatan ini memperkuat literasi kesehatan masyarakat dan meningkatkan kemampuan individu dalam mengambil keputusan yang tepat terkait kesehatannya, sehingga layanan kesehatan primer berorientasi pada masyarakat dan berpusat pada manusia (*people-centered primary health care*) (Warner, et.al, 2025).

Tata kelola pelayanan kesehatan primer harus dilaksanakan dengan baik mencakup kepemimpinan yang efektif, sistem manajemen yang akuntabel, serta koordinasi lintas sektor yang kuat. Pelayanan kesehatan primer dituntut untuk mampu mengelola sumber daya secara efisien, memastikan kepatuhan terhadap standar pelayanan, dan menerapkan prinsip transparansi serta akuntabilitas dalam penyelenggaraan layanan kesehatan (Kementerian Kesehatan RI, 2022). Disamping itu peningkatan mutu pelayanan kesehatan primer menjadi komponen esensial dalam transformasi layanan kesehatan. Mutu pelayanan tidak hanya diukur dari hasil klinis, tetapi juga dari keselamatan pasien, pengalaman pasien, dan efektivitas pelayanan. Penerapan standar pelayanan, sistem penjaminan mutu, serta budaya keselamatan pasien di fasilitas pelayanan kesehatan primer menjadi instrumen penting untuk memastikan pelayanan yang aman dan berkualitas (Kementerian Kesehatan RI, 2021).

Digitalisasi pelayanan Kesehatan primer yang memungkinkan pencatatan dan pelaporan yang lebih akurat, peningkatan koordinasi layanan, serta pengambilan keputusan berbasis data sangat diperlukan. Sistem informasi kesehatan yang terintegrasi membantu pelayanan kesehatan primer dalam memantau status kesehatan masyarakat, mengevaluasi kinerja layanan, dan merencanakan intervensi kesehatan secara lebih tepat sasaran (WHO, 2025). Pelayanan kesehatan primer merupakan pendekatan menyeluruh yang mencakup penguatan fungsi promotif dan preventif, integrasi layanan, peningkatan mutu dan tata kelola, serta pemanfaatan teknologi informasi kesehatan, bukan hanya berperan sebagai penyedia layanan kesehatan dasar, tetapi juga sebagai penggerak utama transformasi sistem kesehatan nasional menuju sistem yang lebih adil, efektif, dan berkelanjutan dalam rangka pencapaian *Universal Health Coverage* (UHC)

Tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan primer diharapkan memiliki kompetensi yang tidak hanya bersifat klinis, tetapi juga mencakup kemampuan komunikasi, edukasi kesehatan, kerja tim interprofesional, serta pemahaman terhadap determinan sosial kesehatan. Penguatan kapasitas sumber daya manusia

menjadi kunci keberhasilan transformasi layanan kesehatan karena kualitas pelayanan kesehatan primer sangat bergantung pada kompetensi dan profesionalisme tenaga kesehatan yang menjalankannya (WHO, 2023). Pendekatan berbasis risiko (*risk-based approach*) dalam perencanaan dan pelaksanaan layanan kesehatan primer diperlukan untuk mengidentifikasi kelompok masyarakat dengan risiko kesehatan tinggi dan merancang intervensi yang lebih tepat sasaran.

Pelayanan kesehatan primer tidak berdiri juga terhubung secara fungsional dengan layanan rujukan tingkat lanjutan. Sistem rujukan yang efektif memastikan kesinambungan pelayanan (*continuity of care*) dan mencegah fragmentasi layanan kesehatan. Integrasi ini memperkuat peran pelayanan kesehatan primer sebagai koordinator layanan kesehatan dan penjaga pintu masuk (*gatekeeper*) sistem kesehatan nasional.

Pembiayaan pelayanan kesehatan primer yang berkelanjutan dan berbasis kinerja diarahkan untuk mendorong peningkatan mutu pelayanan, pencegahan penyakit, serta pengelolaan penyakit kronis secara optimal di tingkat primer. Pembiayaan yang tepat mendukung pelayanan kesehatan primer dalam menjalankan fungsi promotif dan preventif, sekaligus mengurangi beban pembiayaan di tingkat layanan rujukan (Kementerian Kesehatan RI, 2023). Sebagai wahana pembelajaran sistem kesehatan (*learning health system*), pelayanan kesehatan primer perlu memanfaatkan data pelayanan, evaluasi kinerja, dan umpan balik berkelanjutan, guna meningkatkan kualitas layanan dan menyesuaikan intervensi kesehatan dengan dinamika kebutuhan masyarakat. Pendekatan ini memastikan bahwa pelayanan kesehatan primer tidak hanya responsif terhadap masalah kesehatan saat ini, tetapi juga adaptif terhadap tantangan kesehatan di masa depan dalam rangka mewujudkan sistem kesehatan yang berdaya tahan dan berkeadilan (Kemenkes RI, 2022; 2023).

Pelayanan kesehatan primer merupakan sistem kesehatan berbasis nilai (*value-based health care*) dan berfokus pada luaran kesehatan, efisiensi dan pengalaman pasien terhadap pelayanan. Pendekatan ini menekankan pada keberhasilan pelayanan kesehatan primer tidak hanya diukur dari jumlah layanan yang diberikan, tetapi dari manfaat kesehatan yang dirasakan oleh masyarakat. Adanya *community-oriented primary care*, yang mengintegrasikan pelayanan klinis dengan intervensi kesehatan masyarakat melalui pemetaan masalah kesehatan berbasis wilayah kerja, mampu merespons kebutuhan spesifik masyarakat dan memperkuat peran Puskesmas sebagai pusat pemberdayaan kesehatan Masyarakat (Govin, et.al, 2015; Kemenkes RI, 2023).

Pelayanan kesehatan primer dilaksanakan dengan kolaborasi antarprofesi kesehatan berbasis tim (*team-based primary care*). Pelayanan berbasis tim

memungkinkan distribusi tugas yang lebih efektif, meningkatkan kualitas asuhan, serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia kesehatan di tingkat primer, sehingga pelayanan menjadi efektif, merata dan mencakup seluruh Masyarakat. Pelayanan kesehatan primer diharapkan mampu berkolaborasi dengan sektor non-kesehatan, seperti pendidikan, perlindungan sosial, dan lingkungan, untuk menangani determinan sosial kesehatan. Integrasi lintas sektor ini memperluas dampak pelayanan kesehatan primer dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara holistik.

C. Konsep Mutu dan Akses dalam Pelayanan Kesehatan Primer

Pelayanan kesehatan primer merupakan fondasi utama sistem kesehatan yang berperan sebagai titik kontak pertama masyarakat dengan sistem layanan kesehatan, memiliki karakteristik layanan yang komprehensif mencakup promotif-preventif, kuratif hingga rehabilitatif serta palliative care sepanjang siklus kehidupan individu dan komunitas. Pelayanan Kesehatan primer juga merupakan pendekatan sistem kesehatan secara *whole of society* yang menggabungkan layanan medis dengan upaya multisektoral di luar fasilitas kesehatan seperti kebijakan sosial, pendidikan, dan lingkungan untuk mencapai kesehatan yang adil dan merata (WHO, 2025).

Mutu pelayanan kesehatan primer mencerminkan tingkat layanan yang diberikan secara aman, efektif, tepat waktu, efisien, berfokus pada pasien, dan adil. WHO secara klasik mendefinisikan mutu layanan kesehatan sebagai “tingkat layanan kesehatan yang disediakan kepada individu dan populasi yang meningkatkan hasil kesehatan yang diinginkan melalui penyediaan layanan yang aman, efektif, tepat waktu, efisien, merata, dan berpusat pada orang” (WHO, 2023). Mutu layanan Kesehatan primer bukan sekadar kualitas teknis layanan klinis, tetapi termasuk juga: (PHCPI, 2025)

1. Mutu sebagai Fungsi Dasar Layanan Primer

Mutu PHC tercermin dari kemampuan layanan primer menjalankan fungsi-fungsi dasarnya secara optimal, yaitu:

a. First Contact Access

Layanan primer merupakan layanan pertama yang diakses dan diterima oleh Masyarakat sebelum menuju fasilitas Kesehatan lanjutan atau rujukan. Layanan Kesehatan primer yang bermutu memastikan masyarakat dapat memperoleh pelayanan awal secara cepat, mudah, dan tepat, sehingga deteksi dini masalah kesehatan dapat dilakukan dan kebutuhan rujukan dapat dikendalikan secara rasional.

b. *Continuity of Care* (Kesinambungan Pelayanan)

Adanya kesinambungan pelayanan yang diterima oleh masyarakat menunjukkan mutu pelayanan Kesehatan yang baik, sehingga masalah Kesehatan Masyarakat dapat tertangani secara komprehensif. Kontinuitas memungkinkan pemantauan kondisi Kesehatan masyarakat jangka panjang, pengelolaan penyakit kronis, serta pengambilan keputusan klinis yang lebih tepat karena tenaga kesehatan memahami riwayat dan kondisi pasien secara menyeluruh.

c. *Comprehensiveness* (Kelengkapan Layanan)

Layanan primer yang bermutu mampu menjawab dan memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat, baik aspek promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, maupun paliatif. Kelengkapan layanan yang diterima Masyarakat akan mengurangi ketergantungan pada rujukan atau perawatan lanjutan dan meningkatkan efektivitas sistem kesehatan secara keseluruhan.

d. *Coordination* (Koordinasi Layanan)

Pelayanan Kesehatan primer yang bermutu dapat terwujud melalui koordinasi pelayanan lintas tingkat dan lintas sektor. Koordinasi yang baik memastikan kesinambungan informasi klinis, mencegah duplikasi layanan, dan menjamin keselamatan pasien dalam sistem rujukan (PHCPI, 2025).

2. Mutu Berbasis Pengalaman Pasien dan Tenaga Kesehatan

Mutu pelayanan kesehatan primer merupakan konsep multidimensional yang tidak hanya diukur melalui pemenuhan standar klinis dan capaian teknis pelayanan, tetapi juga melalui pengalaman pasien (*patient experience*) serta kepuasan tenaga kesehatan (*health provider satisfaction*). Saat ini di Puskesmas dengan pendekatan pelayanan Integrasi Layanan Primer (ILP), standar klinis, capaian teknis pelayanan dan pengalaman merupakan elemen kunci dalam penilaian indikator mutu dan kinerja Puskesmas sebagai tempat pemberian pelayanan Kesehatan primer, karena mencerminkan kualitas layanan secara holistik baik struktur, proses, dan hasil pelayanan (Donabedian, 2003; WHO, 2020; Kemenkes RI, 2023).

Implementasi ILP di Puskesmas dirancang untuk mengintegrasikan berbagai program dan layanan kesehatan ke dalam kluster layanan yang berorientasi pada individu, keluarga, dan komunitas sepanjang siklus kehidupan. Oleh karena itu, indikator mutu dan kinerja Puskesmas harus berubah dari pendekatan programatik yang terfragmentasi menuju pendekatan sistem layanan yang terintegrasi. Indikator akses layanan, seperti kemudahan mendapatkan layanan (*first contact access*), waktu tunggu, dan keterjangkauan pelayanan, menjadi indikator awal yang mencerminkan keberhasilan ILP dalam meningkatkan akses

dan responsivitas layanan primer. Akses yang baik merupakan prasyarat utama terciptanya pengalaman pasien yang positif (Kemenkes RI, 2024).

Kesinambungan dan koordinasi layanan Kesehatan yang akan diberikan kepada masyarakat merupakan juga indikator mutu penting dalam kerangka ILP. Puskesmas yang mampu mengoordinasikan layanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif antar-kluster menunjukkan kinerja sistem yang efektif. Indikator seperti kesinambungan asuhan pada kelompok rentan (ibu dan anak, lansia, penderita penyakit kronis), rujukan yang tepat waktu dan terkoordinasi, serta tindak lanjut pelayanan menjadi ukuran keberhasilan integrasi layanan. Pasien sangat mengharapkan, koordinasi pelayanan yang baik dan terintegrasi serta pelayanan yang tepat dan akurat, pelayanan yang tidak berulang, tidak membingungkan, dan memberikan rasa aman serta kepercayaan terhadap sistem layanan (sSarfield, 1998; WHO, 2022). Pengalaman dan kepuasan pasien dalam ILP juga menjadi indikator mutu proses yang sangat strategis. Aspek komunikasi efektif, empati tenaga kesehatan, penghormatan terhadap nilai dan preferensi pasien, serta keterlibatan pasien dalam pengambilan keputusan merupakan indikator mutu yang mencerminkan penerapan pelayanan berpusat pada pasien (patient-centered care) (Epstein & Street, 2011; Berwick, 2009). Pengukuran pengalaman pasien melalui survei kepuasan, umpan balik masyarakat, dan mekanisme pengaduan menjadi bagian penting dalam evaluasi kinerja Puskesmas yang berorientasi mutu berkelanjutan dan perlu dilakukan secara berkala dan terus menerus. Hasil survey kepuasan dapat digunakan untuk meningkatkan mutu pelayanan (WHO, 1998; 2020).

Kepuasan tenaga kesehatan juga memberikan pengaruh secara langsung terhadap kinerja Puskesmas yang berkaitan dengan mutu pelayanan. Penerapan ILP menuntut kerja tim lintas profesi, pembagian peran yang jelas dalam kluster layanan, serta dukungan manajemen yang kuat. Indikator kinerja seperti produktivitas layanan, kepatuhan terhadap standar operasional prosedur, keselamatan pasien, dan kualitas dokumentasi klinis sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan kerja dan tingkat kepuasan tenaga kesehatan. Lingkungan kerja yang kondusif, sistem supervisi yang efektif, serta kesempatan pengembangan kompetensi akan meningkatkan motivasi dan profesionalisme tenaga kesehatan, yang pada akhirnya berdampak pada mutu pelayanan dan pencapaian target kinerja Puskesmas (WHO, 2025). Indikator hasil (outcome) dalam kerangka ILP mencerminkan dampak pelayanan terhadap status kesehatan masyarakat. Penurunan angka kesakitan yang dapat dicegah di layanan primer, peningkatan kepatuhan pengobatan pada penyakit kronis, serta peningkatan perilaku hidup sehat di masyarakat merupakan indikator kinerja yang

menunjukkan keberhasilan integrasi layanan primer. Capaian outcome tersebut tidak terlepas dari kualitas proses pelayanan, pengalaman pasien yang positif, serta kinerja tenaga kesehatan yang optimal.

3. Mutu yang Responsif terhadap Kebutuhan Populasi

Pelayanan Kesehatan primer menekankan bahwa mutu pelayanan Kesehatan tidak hanya dilihat pada tingkat individu, tetapi juga pada kemampuan layanan merespons kebutuhan komunitas dan populasi. Layanan primer yang bermutu bersifat proaktif dalam mengidentifikasi masalah kesehatan utama di wilayah kerjanya, menyesuaikan intervensi dengan konteks sosial budaya, serta menjangkau kelompok rentan secara adil. Pelayanan primer merupakan layanan berbasis populasi (*population-based care*), bukan semata layanan kuratif individual, sehingga mutu diukur dari dampaknya terhadap kesehatan masyarakat secara luas. Mutu pelayanan Kesehatan primer secara keseluruhan adalah integrasi antara layanan klinis individual dan intervensi kesehatan masyarakat. Melalui pendekatan *community-oriented primary care* (COPC), mutu layanan ditingkatkan dengan mengaitkan praktik klinis sehari-hari dengan pemetaan masalah kesehatan wilayah, faktor risiko komunitas, dan upaya promotif-preventif yang sistematis. Pendekatan *life course* memastikan bahwa mutu layanan dijaga secara konsisten pada setiap tahap kehidupan, sehingga intervensi kesehatan tidak bersifat terputus-putus, melainkan berkelanjutan dan saling terhubung (WHO, 2023). Mutu layanan kesehatan primer saat ini semakin ditekankan pada hasil berbasis nilai (*value-based outcomes*), yaitu manfaat kesehatan yang nyata yang dihasilkan oleh layanan dibandingkan dengan sumber daya yang digunakan. Penilaian mutu mencakup perbaikan status kesehatan dan kualitas hidup, pengalaman dan kepuasan pasien, efisiensi penggunaan sumber daya, dan keberlanjutan layanan primer (Porter & Teisberg, 2006; WHO, 2025).

4. Akses Layanan Kesehatan Primer

Akses layanan kesehatan primer merupakan salah satu fondasi utama dalam sistem kesehatan yang berorientasi pada keadilan, mutu, dan keberlanjutan. Akses tidak lagi dipahami sekadar sebagai keberadaan fasilitas kesehatan, melainkan sebagai kemampuan nyata individu dan masyarakat untuk memperoleh layanan kesehatan yang dibutuhkan secara tepat waktu, sesuai kebutuhan, dapat diterima secara sosial dan budaya, serta tanpa hambatan finansial yang memberatkan. Konsep ini berkembang dari pemahaman klasik tentang akses menuju pendekatan multidimensional yang menekankan interaksi antara sistem layanan kesehatan dan kemampuan individu untuk memanfaatkan layanan tersebut secara efektif.

Akses layanan kesehatan primer banyak dirujuk pada model Levesque yang menjelaskan bahwa akses merupakan hasil interaksi antara karakteristik sistem pelayanan dan kemampuan masyarakat dalam mengenali kebutuhan kesehatan, mencari layanan, menjangkau fasilitas, membayar biaya layanan, serta terlibat dalam proses pelayanan (Levesque et al., 2013). Model ini tetap relevan dan banyak digunakan dalam penelitian terkini mengenai akses layanan primer (Toal-Sullivan et al., 2024). Dengan demikian, akses tidak hanya berbicara tentang ketersediaan layanan (*availability*), tetapi juga keterjangkauan (*affordability*), penerimaan sosial-budaya (*acceptability*), kemudahan dikenali dan dipahami masyarakat (*approachability*), serta kesesuaian dan ketepatan layanan dengan kebutuhan klinis pasien (*appropriateness*).

Akses layanan primer memiliki hubungan langsung dengan *outcome* kesehatan. Layanan primer yang mudah diakses terbukti meningkatkan deteksi dini penyakit, pengelolaan penyakit kronis yang lebih baik, pencegahan komplikasi, serta menurunkan penggunaan layanan gawat darurat yang tidak diperlukan (WHO, 2022). *Healthy People 2030* juga menegaskan bahwa akses terhadap pelayanan primer berkorelasi dengan peningkatan status kesehatan populasi dan penurunan kesenjangan kesehatan antar kelompok sosial. Akses layanan bukan hanya indikator proses pelayanan, tetapi determinan penting hasil kesehatan masyarakat. Hal ini dikarenakan akses menunjukkan kemampuan Masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang mereka butuhkan tanpa rintangan atau hambatan yang dialami.

Indonesia sebagai negara berkembang, akses layanan primer masih menghadapi tantangan struktural dan geografis. Meskipun implementasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) telah meningkatkan cakupan pembiayaan kesehatan, ketimpangan distribusi tenaga kesehatan, hambatan transportasi, serta keterbatasan fasilitas di daerah terpencil masih menjadi faktor penghambat akses yang signifikan (Wenang et al., 2021). Hal ini menunjukkan bahwa perluasan cakupan asuransi kesehatan belum otomatis menjamin pemerataan akses layanan primer. Oleh karena itu, penguatan Puskesmas sebagai fasilitas kesehatan tingkat pertama harus diiringi dengan strategi pemerataan tenaga kesehatan, peningkatan infrastruktur, serta pendekatan berbasis komunitas. Kondisi demografi Indonesia mengharuskan Upaya untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat sehingga Masyarakat dapat menjangkau pelayanan Kesehatan yang mereka butuhkan dengan mudah.

Berbagai faktor dapat mempengaruhi akses layanan primer diantaranya tingkat pendidikan, pendapatan, literasi kesehatan, serta kepercayaan terhadap sistem layanan kesehatan. Studi terbaru menunjukkan bahwa persepsi

masyarakat terhadap kualitas layanan, pengalaman sebelumnya dalam menggunakan layanan kesehatan, serta kesesuaian layanan dengan nilai budaya lokal sangat menentukan keputusan seseorang untuk mencari dan memanfaatkan layanan primer (Toal-Sullivan et al., 2024). Pengalaman dan kualitas pelayanan yang pernah dialami oleh klien atau masyarakat akan menentukan pilihan fasilitas Kesehatan yang akan digunakan kembali. Hal ini menunjukkan bahwa mutu pelayanan berkorelasi dengan akses dan pemanfaatan layanan Kesehatan.

Era transformasi sistem kesehatan, akses layanan primer juga semakin dipengaruhi oleh pemanfaatan teknologi digital. Digitalisasi sistem informasi kesehatan, *telemedicine*, interoperabilitas data pasien, serta sistem antrian berbasis daring dapat meningkatkan efisiensi dan memperluas jangkauan layanan primer, terutama di wilayah dengan keterbatasan geografis (WHO, 2022). Di Indonesia, penguatan sistem layanan primer berbasis transformasi digital menjadi salah satu strategi untuk meningkatkan akses, efektivitas, dan kesinambungan pelayanan. Pemanfaatan teknologi ini tidak hanya memperluas akses fisik, tetapi juga memperkuat koordinasi layanan dan pemantauan mutu secara real-time (Kemenkes, 2023).

Akses layanan primer juga merupakan komponen inti dalam *Universal Health Coverage* (UHC), yang menekankan bahwa setiap orang harus memperoleh layanan kesehatan yang dibutuhkan tanpa mengalami kesulitan finansial (WHO, 2023). Akses tidak hanya mencakup ketersediaan layanan, tetapi juga perlindungan finansial yang memadai. Hambatan biaya, baik langsung maupun tidak langsung, tetap menjadi faktor signifikan yang memengaruhi penggunaan layanan primer, terutama pada kelompok rentan. Ketersediaan jaminan kesehatan bagi masyarakat juga menunjukkan kemampuan akses masyarakat terhadap pelayanan. Adanya *coverage* pembiayaan kesehatan melalui Jaminan Kesehatan Nasional membuat masyarakat tidak perlu memikirkan biaya untuk mendapatkan pelayanan Kesehatan. Hal ini akan memotivasi masyarakat mengakses pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan mereka.

Akses layanan primer sering digunakan sebagai indikator mutu dan kinerja evaluasi kinerja sistem kesehatan, pada fasilitas kesehatan tingkat pertama. Indikator seperti waktu tunggu, jarak tempuh ke fasilitas kesehatan, ketersediaan tenaga kesehatan, serta tingkat pemanfaatan layanan menjadi ukuran konkret dalam menilai efektivitas sistem layanan primer (WHO, 2022). Evaluasi akses layanan ini perlu dilakukan secara berkala sehingga pengambil kebijakan atau

stakeholder dapat mengidentifikasi kesenjangan layanan dan merumuskan intervensi yang lebih tepat sasaran guna menangani masalah yang ada.

D. Keimpulan

Strategi peningkatan mutu dan akses layanan kesehatan primer merupakan fondasi utama dalam membangun sistem kesehatan yang tangguh, responsif, dan berkeadilan. Mutu layanan primer bukan hanya kepatuhan terhadap standar klinis, tetapi mencakup dimensi yang lebih luas, seperti keselamatan pasien, pengalaman dan kepuasan pengguna layanan, kesinambungan asuhan, koordinasi antar tingkat pelayanan, serta efektivitas dan efisiensi sistem. Akses layanan primer harus menjamin ketersediaan layanan yang merata, keterjangkauan biaya, kemudahan geografis, penerimaan sosial-budaya, serta kesesuaian layanan dengan kebutuhan kesehatan masyarakat sepanjang siklus kehidupan.

Peningkatan mutu dan akses layanan primer tidak dapat dipisahkan karena keduanya saling memperkuat. Akses layanan primer yang luas tanpa mutu yang baik berpotensi menimbulkan pelayanan yang tidak efektif dan tidak aman, sedangkan mutu yang tinggi tanpa akses yang merata akan memperbesar ketimpangan kesehatan. Oleh karena itu, pendekatan strategis harus bersifat integratif, mencakup penguatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan, perbaikan tata kelola dan pembiayaan, pemanfaatan teknologi digital, serta sistem monitoring dan evaluasi berbasis indikator kinerja yang terukur.

Di Indonesia penguatan Puskesmas melalui pendekatan Integrasi Layanan Primer (ILP) menjadi langkah strategis untuk mengurangi fragmentasi pelayanan dan meningkatkan kesinambungan asuhan, terutama bagi kelompok rentan seperti ibu dan anak, lansia, serta penderita penyakit kronis. Integrasi layanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif dalam satu sistem yang terkoordinasi akan meningkatkan efisiensi sekaligus mutu pelayanan. Transformasi sistem kesehatan yang menempatkan layanan primer sebagai pusat koordinasi (*gatekeeper*) juga berkontribusi pada pengendalian biaya kesehatan dan peningkatan outcome kesehatan populasi.

Strategi peningkatan mutu dan akses harus berorientasi pada prinsip equity dan Universal Health Coverage (UHC), dengan memastikan tidak ada kelompok masyarakat yang tertinggal. Pendekatan berbasis komunitas (*community base*), pemberdayaan masyarakat, serta penguatan literasi kesehatan menjadi komponen penting untuk memastikan masyarakat tidak hanya dapat menjangkau layanan, tetapi juga mampu memanfaatkan layanan secara optimal. Selain itu perlu adanya komitmen kebijakan yang kuat, dukungan pembiayaan yang berkelanjutan, serta

evaluasi berbasis data, layanan kesehatan primer dapat menjadi pilar utama dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara menyeluruh dan berkelanjutan.

E. Referensi

- Berwick, D. M. (2009). What "patient-centered" should mean: Confessions of an extremist. *Health Affairs*, 28(4), w555–w565. <https://doi.org/10.1377/hlthaff.28.4.w555>
- Donabedian, A. (2003). *An Introduction to Quality Assurance in Health Care*. Oxford University Press.
- Epstein, R. M., & Street, R. L. (2011). The values and value of patient-centered care. *Annals of Family Medicine*, 9(2), 100–103.
- Gofin, J., Gofin, R., & Stimpson, J. P. (2015). Community-Oriented Primary Care (COPC) and the Affordable Care Act: An opportunity to meet the demands of an evolving health care system. *Journal of Primary Care & Community Health*, 6(2), 128–133
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2021). *Standar akreditasi puskesmas*. Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2022). *Cetak biru transformasi sistem kesehatan Indonesia*. Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2023). *Profil kesehatan Indonesia tahun 2022*. Kementerian Kesehatan RI.
- Levesque, J. F., Harris, M. F., & Russell, G. (2013). Patient-centred access to health care. *International Journal for Equity in Health*, 12(18).
- PHCPI. (2025). *Improving primary health care performance: Quality, access, and population health outcomes*. Primary Health Care Performance Initiative
- Porter, M. E., & Teisberg, E. O. (2006). *Redefining health care: Creating value-based competition on results*. Harvard Business School Press.
- Starfield, B. (1998). *Primary Care: Balancing Health Needs, Services, and Technology*. Oxford University Press
- Starfield, B., Shi, L., & Macinko, J. (2005). Contribution of primary care to health systems and health. *The Milbank Quarterly*, 83(3), 457–502. <https://doi.org/10.1111/j.1468-0009.2005.00409>.
- Toal-Sullivan, D., Dahrouge, S., Tesfaselassie, J., & Olejnik, L. (2024). Access to primary health care. *BMC Primary Care*, 25, 23
- Wagner, C., Jolidon, V., et al. (2025). *Primary healthcare trajectories and life-course disadvantage — a sequence analysis of 13 countries*. *European Journal of Public Health*

Wenang, S., et al. (2021). Availability and accessibility of primary care in Indonesia. *Frontiers in Public Health*, 9, 721886.

World Health Organization, & United Nations Children's Fund. (2018). *A vision for primary health care in the 21st century: Towards universal health coverage and the Sustainable Development Goals*. World Health Organization.

World Health Organization. (2018). *Primary health care: Transforming vision into action*. World Health Organization.

World Health Organization. (2018). *Quality of care in primary health care: A practical guide*. Geneva: World Health Organization.

World Health Organization. (2022). *Primary health care measurement framework and indicators*. World Health Organization.

World Health Organization. (2025). *Strategy for optimizing national routine health information systems*. World Health Organization.

F. Glosarium

Akses Layanan Kesehatan

Kemampuan individu atau masyarakat untuk memperoleh layanan kesehatan yang dibutuhkan secara tepat waktu, terjangkau, dan sesuai kebutuhan.

Continuity of Care (Kesinambungan Asuhan)

Pelayanan kesehatan yang diberikan secara berkelanjutan oleh tenaga kesehatan yang sama atau dalam sistem yang terkoordinasi.

Integrasi Layanan Primer (ILP)

Pendekatan pelayanan kesehatan primer yang mengintegrasikan layanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif secara terkoordinasi dalam satu sistem pelayanan.

Patient-Centered Care

Pendekatan pelayanan kesehatan yang menghormati nilai, preferensi, dan kebutuhan pasien serta melibatkan pasien dalam pengambilan keputusan

Approachability

Kemudahan masyarakat untuk mengetahui keberadaan layanan kesehatan, memahami jenis layanan yang tersedia, serta mengetahui cara mengaksesnya.

Availability (Ketersediaan)

Kecukupan jumlah fasilitas, tenaga kesehatan, obat, dan sarana pendukung untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Accessibility (Keterjangkauan Geografis)

Kemudahan masyarakat menjangkau fasilitas kesehatan dari sisi jarak, waktu tempuh, dan transportasi.

Affordability (Keterjangkauan Finansial)

Kemampuan masyarakat untuk membayar layanan kesehatan tanpa mengalami kesulitan ekonomi atau beban finansial berlebihan.

Acceptability (Penerimaan Sosial-Budaya)

Kesesuaian layanan kesehatan dengan nilai, norma, budaya, dan harapan masyarakat.

Appropriateness (Kesesuaian Layanan)

Tingkat kesesuaian pelayanan yang diberikan dengan kebutuhan klinis pasien berdasarkan standar profesional dan evidence-based practice.

Continuity of Care (Kecinambungan Asuhan)

Pelayanan kesehatan yang diberikan secara berkelanjutan dan terkoordinasi dalam jangka waktu tertentu, terutama untuk penyakit kronis dan kelompok rentan.

Coordination of Care (Koordinasi Layanan)

Pengelolaan pelayanan kesehatan antar tenaga kesehatan dan antar tingkat layanan agar pasien menerima asuhan yang terpadu dan tidak terfragmentasi.

Gatekeeper

Peran layanan kesehatan primer sebagai pintu masuk utama sistem pelayanan kesehatan dan pengendali rujukan ke fasilitas kesehatan tingkat lanjut.

Integrasi Layanan Primer (ILP)

Pendekatan pelayanan kesehatan yang mengintegrasikan layanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif dalam satu sistem pelayanan yang terkoordinasi, khususnya di Puskesmas.

Mutu Pelayanan Kesehatan Primer (Primary Health Care Quality)

Tingkat kesesuaian layanan kesehatan dengan standar profesional, kebutuhan pasien, serta prinsip keselamatan dan efektivitas pelayanan.

Struktur, Proses, dan Hasil (Donabedian Model)

Kerangka evaluasi mutu layanan kesehatan yang menilai kualitas berdasarkan komponen struktur (sumber daya), proses (cara pelayanan diberikan), dan hasil (outcome kesehatan).

Patient-Centered Care (Pelayanan Berpusat pada Pasien)

Pendekatan pelayanan yang menghormati nilai, preferensi, dan kebutuhan pasien serta melibatkan pasien dalam pengambilan keputusan klinis.

Patient Experience (Pengalaman Pasien)

Persepsi dan pengalaman pasien selama menerima layanan kesehatan, termasuk aspek komunikasi, empati, waktu tunggu, dan kenyamanan layanan.

Kepuasan Pasien

Penilaian subjektif pasien terhadap layanan yang diterima berdasarkan harapan dan pengalaman aktual.

Kepuasan Tenaga Kesehatan

Tingkat kepuasan profesional tenaga kesehatan terhadap lingkungan kerja, sistem pelayanan, dan dukungan organisasi yang berdampak pada mutu layanan.

Indikator Mutu

Ukuran kuantitatif atau kualitatif yang digunakan untuk menilai kinerja dan kualitas pelayanan kesehatan.

Universal Health Coverage (UHC)

Kondisi di mana seluruh masyarakat memperoleh layanan kesehatan yang dibutuhkan tanpa mengalami kesulitan finansial.

Equity (Keadilan Kesehatan)

Prinsip bahwa setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk mencapai derajat kesehatan optimal tanpa diskriminasi atau hambatan sosial-ekonomi

PROFIL PENULIS



Farhan Ardiansyah, S.Kep., Ns., M.Kep. Lahir di Kediri, 13 Oktober 1997. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi Pendidikan Ners, Universitas Airlangga tahun 2015. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Universitas Airlangga dan lulus tahun 2024. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2022 sebagai asisten sekretaris LPJPHKI Universitas Airlangga, kemudian dilanjutkan di Universitas Strada Indonesia. Saat ini penulis bekerja di Poltekkes Kerta Cendekia mengampu mata kuliah Keperawatan Keluarga dan Komunitas, serta menjadi sekretaris LLPM dan Journal Manager dari jurnal kelolaan

Poltekkes Kerta Cendekia. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: farhantunichia@gmail.com

Motto: "Life must go-on"



Bdn. Erma Puspita Sari, SST., M.Kes., adalah dosen tetap sekaligus Kepala Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan di Universitas Kader Bangsa Palembang. Ia merupakan bidan profesional yang menekuni bidang kesehatan reproduksi dan KB serta pelayanan pasca persalinan. Lahir di Sekayu pada 16 Januari 1988, ia menyelesaikan pendidikan DIV Kebidanan pada tahun 2010, meraih gelar magister kesehatan pada tahun 2012, dan menuntaskan program profesi bidan pada tahun 2022. Ia aktif mengajar mata kuliah KB dan Pelayanan, Asuhan Kebidanan Nifas, serta Asuhan Kebidanan pada Kehamilan.

Fokus risetnya mencakup upaya meningkatkan penggunaan alat kontrasepsi jangka panjang, dengan penekanan pada kesehatan reproduksi perempuan dan pelayanan kontrasepsi. Penulis dapat dihubungi melalui email: ermapuspitasari88@gmail.com.

PROFIL PENULIS



Bdn. Rizki Amalia, SST., M.Kes., lahir di Palembang pada 1 Agustus 1988. Beliau merupakan dosen tetap sekaligus Ketua Lembaga Penjaminan Mutu di Universitas Kader Bangsa Palembang. Penulis adalah seorang bidan profesional yang memiliki kepakaran di bidang kesehatan reproduksi serta pelayanan kebidanan komunitas. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh meliputi jenjang Diploma IV Kebidanan yang diselesaikan pada tahun 2010, kemudian melanjutkan pendidikan Magister Kesehatan dan memperoleh gelar M.Kes. pada tahun 2015. Selanjutnya, penulis menuntaskan Program Profesi Bidan pada tahun 2023 sebagai bentuk komitmen terhadap penguatan kompetensi profesional di bidang kebidanan. Dalam aktivitas akademiknya, penulis mengampu mata kuliah Keluarga Berencana dan Pelayanan Kontrasepsi, Asuhan Kebidanan Komunitas, serta Asuhan Kebidanan Perempuan dan Anak dalam Kondisi Rentan. Fokus riset dan pengabdian masyarakat yang dilakukan mencakup upaya promotif dan preventif kesehatan ibu dan anak, dengan penekanan pada kesehatan reproduksi perempuan dan pelayanan kontrasepsi berbasis komunitas. Sebagai akademisi, penulis aktif dalam kegiatan tridharma perguruan tinggi, meliputi publikasi ilmiah, penyusunan buku ajar, seminar nasional, serta kegiatan pengabdian kepada masyarakat di bidang kesehatan reproduksi dan keluarga berencana. Penulis dapat dihubungi melalui surat elektronik: ramdhanilist@gmail.com. Motto: "Living your life well."

Bdn. Putu Lusita Nati Indriani, SST., M.Kes., adalah dosen tetap sekaligus Kepala Biro Administrasi Umum dan Kepegawaian di Universitas Kader Bangsa Palembang. Ia merupakan bidan profesional yang menekuni bidang kesehatan reproduksi pada Remaja. Lahir di Kalianda pada 09 April 1991, meraih gelar magister kesehatan pada tahun 2016, dan menuntaskan program profesi bidan pada tahun 2024. Fokus penelitiannya berada pada upaya preventif dan promotif kesehatan ibu dan anak, khususnya pada Perubahan Psikologis Remaja dan Ibu Nifas. Penulis dapat dihubungi melalui email: putu.indriani91@gmail.com.

PROFIL PENULIS



Dr. Susi Milwati, S.Kp., M.Pd. merupakan dosen keperawatan yang memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman yang kuat di bidang keperawatan dan pendidikan. Pendidikan terakhir yang ditempuh adalah Program Doktor (S3) Manajemen Pendidikan, yang memperkuat kompetensinya dalam pengembangan pembelajaran, manajemen akademik, serta peningkatan mutu pendidikan kesehatan. Saat ini, Dr. Susi Milwati aktif bekerja sebagai dosen di Politeknik Kesehatan (Poltekkes)

Malang dan mengampu mata kuliah Keperawatan Medikal Bedah (KMB). Dalam perannya sebagai pendidik, beliau berkomitmen untuk mengintegrasikan konsep keilmuan, praktik keperawatan berbasis bukti, serta pendekatan promotif dan preventif yang relevan dengan kebutuhan pelayanan kesehatan primer. Selain aktif dalam kegiatan pengajaran, Dr. Susi Milwati juga produktif dalam penulisan karya ilmiah dan buku ajar keperawatan, khususnya yang ditujukan untuk mahasiswa vokasi kesehatan. Beliau secara konsisten mengikuti berbagai workshop dan kegiatan pengembangan profesional, termasuk pelatihan dan workshop yang diselenggarakan oleh Optimal, sebagai bentuk komitmen terhadap peningkatan kualitas diri dan mutu pembelajaran keperawatan. Dedikasi dalam bidang pendidikan, keilmuan, dan pengembangan profesi menjadikan Dr. Susi Milwati berperan aktif dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia keperawatan, khususnya dalam konteks pelayanan kesehatan di Indonesia.



Arief Hendrawan, S.St., M.Fis., Lahir di Pati, 13 Juli 1980 . Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang Diploma 3 Fisioterapi di Universitas Muhammadiyah Surakarta, Kemudian melanjutkan ke jenjang Diploma IV Fisioterapi dan Profesi Fisioterapi di Universitas Esa Unggul Jakarta. Penulis melanjutkan jenjang pendidikan S2 dalam Bidang Fisiologi Olahraga Konsentrasi Fisioterapi di Universitas Udayana Bali. Riwayat pekerjaan di awalai pada tahun 2002

di pelayanan klinik fisioterapi dan pada tahun 2007 sampai sekarang menjadi Dosen di Program Studi Sarjana Fisioterapi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Al-Irsyad Cilacap. Penulis mempunyai bidang keahlian Fisioterapi Muskuloskeletal dan Neuromuskuloskeletal. Selain sebagai praktisi dan akademisi, penulis juga terlibat dalam penelitian dan pengabdian masyarakat terutama dalam bidang pemberdayaan masyarakat untuk pencegahan penyakit tidak menular melalui pendekatan fisioterapi. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: hendrarie@mail.com. Motto: "Living your life well"

PROFIL PENULIS



Enik Suhariyanti, S.Kep., Ners., M.Kep., Lahir di Temanggung Jawa Tengah pada tanggal 19 Januari 1976. Menyelesaikan pendidikan D3 Keperawatan (1997) di PAM Keperawatan Dep Kes Semarang, S1 Keperawatan (2002) dan Program Profesi Ners (2004) di PSIK FK Universitas Airlangga Surabaya, S2 Keperawatan di Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga Surabaya (2013). Penulis aktif sebagai dosen tetap Keperawatan di FIKES Univ. Muh. Magelang tahun 2003, FIKES Univ. Galuh Ciamis tahun 2022 dan sejak Agustus 2025 berpindah ke Faculty of Health Science (FHS)

di Horizon University Indonesia Karawang, focus mengampu mata kuliah Keperawatan Keluarga, Komunitas dan Gerontik. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yakni pengajaran, penelitian dan pengabdian serta sebagai penulis buku, publikasi, seminar. Pengalaman organisasi penulis aktif di organisasi Ikatan Perawat Kesehatan Komunitas Indonesia (IPKKI), serta aktif di DPD PPNI Kabupaten Karawang sebagai anggota. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: esuhariyanti@gmail.com. Motto hidup "Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan." (QS. Ash-Sharh [94]: 6)



Dr. Ns. Wirda Hayati, S.Kep., M.Kep., Sp.Kom., menyelesaikan pendidikan S1 dan Profesi Ners di Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia lulus pada tahun 2002. Penulis melanjutkan pendidikan S2 di Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia, lulus pada tahun 2006. Kemudian melanjutkan pendidikan Spesialis di Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia lulus pada tahun 2007. Setelah itu

penulis melanjutkan pendidikan S3 di Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada lulus pada tahun 2018. Sejak tahun 2002 penulis mulai aktif mengajar sebagai dosen keperawatan dan saat ini penulis aktif mengajar di Jurusan Keperawatan Poltekkes Kemenkes Aceh. Penulis juga aktif dalam penerbitan buku-buku keperawatan dan Kesehatan serta jurnal nasional dan internasional lainnya. Penulis dapat dihubungi melalui email wirda.hayati@yahoo.com. Pesan untuk para pembaca: "Setiap halaman yang dibaca adalah lembaran-lembaran yang membuat langkah kita lebih dekat menuju versi terbaik diri kita sendiri."

Sinopsis

Bunga rampai “Peran Tenaga Kesehatan dalam Penguatan Pelayanan Kesehatan Primer” menghadirkan rangkaian tulisan yang menegaskan bahwa pelayanan kesehatan primer merupakan fondasi utama sistem kesehatan yang efektif, berkeadilan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Buku ini mengulas bagaimana layanan primer—melalui Puskesmas dan jejaringnya—menjadi garda terdepan dalam menjaga kesehatan populasi, menekan beban penyakit, serta memastikan akses layanan yang dekat, terjangkau, dan berkelanjutan.

Pembahasan diawali dengan pemaparan konsep dan urgensi pelayanan kesehatan primer sebagai fondasi sistem kesehatan, kemudian dilanjutkan dengan analisis peran strategis tenaga kesehatan dalam penguatan Puskesmas dan layanan primer, termasuk tata kelola layanan, integrasi program, kerja tim, serta pelayanan yang berpusat pada pasien dan keluarga. Buku ini juga menekankan pentingnya upaya promotif dan preventif sebagai inti pelayanan primer mulai dari edukasi kesehatan, deteksi dini, imunisasi, skrining, hingga pengendalian faktor risiko penyakit.

Secara khusus, bunga rampai ini menyoroti kontribusi profesi kesehatan dalam layanan primer. Peran kebidanan dibahas dalam konteks kesehatan ibu dan anak, pelayanan kesehatan reproduksi, keluarga berencana, serta pendampingan keluarga di komunitas. Sementara itu, kontribusi keperawatan dipaparkan melalui penguatan asuhan berkesinambungan, manajemen kasus, edukasi pasien, home care, dan dukungan pada pengelolaan penyakit kronis di tingkat primer.

Tidak hanya berfokus pada fasilitas, buku ini juga mengangkat aspek pemberdayaan masyarakat sebagai kunci penguatan layanan primer, melalui peran kader, kemitraan lintas sektor, pendekatan berbasis komunitas, serta peningkatan literasi kesehatan. Di sisi lain, tulisan-tulisan dalam buku ini menguraikan tantangan pelayanan kesehatan primer di daerah perkotaan dan pedesaan, seperti kesenjangan akses, keterbatasan SDM, hambatan geografis, perbedaan sosial budaya, hingga kompleksitas masalah kesehatan akibat urbanisasi.

Sebagai penutup, bunga rampai ini menawarkan berbagai strategi peningkatan mutu dan akses pelayanan kesehatan primer, mencakup penguatan kompetensi tenaga kesehatan, perbaikan sistem rujukan, pemanfaatan teknologi, peningkatan kolaborasi interprofesional, serta inovasi layanan yang adaptif terhadap konteks lokal. Dengan gaya penyajian yang aplikatif dan relevan, buku ini diharapkan menjadi rujukan bagi tenaga kesehatan, mahasiswa, akademisi, pengelola layanan, dan pemangku kebijakan dalam memperkuat pelayanan kesehatan primer yang lebih bermutu, inklusif, dan berkelanjutan.

Bunga rampai “Peran Tenaga Kesehatan dalam Penguatan Pelayanan Kesehatan Primer” menghadirkan rangkaian tulisan yang menegaskan bahwa pelayanan kesehatan primer merupakan fondasi utama sistem kesehatan yang efektif, berkeadilan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Buku ini mengulas bagaimana layanan primer—melalui Puskesmas dan jejaringnya—menjadi garda terdepan dalam menjaga kesehatan populasi, menekan beban penyakit, serta memastikan akses layanan yang dekat, terjangkau, dan berkelanjutan. Pembahasan diawali dengan pemaparan konsep dan urgensi pelayanan kesehatan primer sebagai fondasi sistem kesehatan, kemudian dilanjutkan dengan analisis peran strategis tenaga kesehatan dalam penguatan Puskesmas dan layanan primer, termasuk tata kelola layanan, integrasi program, kerja tim, serta pelayanan yang berpusat pada pasien dan keluarga. Buku ini juga menekankan pentingnya upaya promotif dan preventif sebagai inti pelayanan primer mulai dari edukasi kesehatan, deteksi dini, imunisasi, skrining, hingga pengendalian faktor risiko penyakit.

Secara khusus, bunga rampai ini menyoroti kontribusi profesi kesehatan dalam layanan primer. Peran kebidanan dibahas dalam konteks kesehatan ibu dan anak, pelayanan kesehatan reproduksi, keluarga berencana, serta pendampingan keluarga di komunitas. Sementara itu, kontribusi keperawatan dipaparkan melalui penguatan asuhan berkesinambungan, manajemen kasus, edukasi pasien, home care, dan dukungan pada pengelolaan penyakit kronis di tingkat primer.

Tidak hanya berfokus pada fasilitas, buku ini juga mengangkat aspek pemberdayaan masyarakat sebagai kunci penguatan layanan primer, melalui peran kader, kemitraan lintas sektor, pendekatan berbasis komunitas, serta peningkatan literasi kesehatan. Di sisi lain, tulisan-tulisan dalam buku ini menguraikan tantangan pelayanan kesehatan primer di daerah perkotaan dan pedesaan, seperti kesenjangan akses, keterbatasan SDM, hambatan geografis, perbedaan sosial budaya, hingga kompleksitas masalah kesehatan akibat urbanisasi.

Sebagai penutup, bunga rampai ini menawarkan berbagai strategi peningkatan mutu dan akses pelayanan kesehatan primer, mencakup penguatan kompetensi tenaga kesehatan, perbaikan sistem rujukan, pemanfaatan teknologi, peningkatan kolaborasi interprofesional, serta inovasi layanan yang adaptif terhadap konteks lokal. Dengan gaya penyajian yang aplikatif dan relevan, buku ini diharapkan menjadi rujukan bagi tenaga kesehatan, mahasiswa, akademisi, pengelola layanan, dan pemangku kebijakan dalam memperkuat pelayanan kesehatan primer yang lebih bermutu, inklusif, dan berkelanjutan.

ISBN 978-634-7556-75-2



9

786347

556752

Penerbit:

PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88 RT. 001 RW. 005

Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11620

